MEDINA / PROTOCOLE V2 / 01

Protocole V2 Prévenir les collisions et prouver le travail

Réduire les collisions et les erreurs, sans promettre zéro absolu. Un auteur actif par cours/chemin, des missions approuvées avant le travail, un registre distant à avance rapide et une intégration séquentielle rendent la coordination vérifiable. Les droits GitHub actuels ne permettent pas d'affirmer une protection serveur imposée : Administration renvoie403.

Le protocole s'applique aux quatre systèmes S08/S05/S04/S06. Une conversation, même issue de la même IA qu'une autre, est une session concurrente. Les anciens systèmes restent conservés hors de ce recontrôle ; aucune ancienne branche entière n'est fusionnée pour aller plus vite.

État réel documenté	Portée
Garde implémentée et tests locaux	18 tests OK, dont deux processus/clones en concurrence sur bare local. Lire tests-garde.log et revue-garde.txt ; cela ne simule pas les autorisations du vrai GitHub.
Registre distant initialisé	refs/heads/medina/session-registry Commit e0874b89f6d7cb4c02acbff44ed90b9dad656928 Vérification distante : True ; réservations initiales : 0 ; aucun force-push.
Protection serveur non vérifiée	server_protection_verified=false. HTTP403 sur protection historique ; rulesets publics lus vides. Une règle proposée n'est pas une règle active.
Travail médical non lancé	104 audits préparés, pas réalisés. 154 productions et 12 réserves planifiées ; génération zéro ne vaut pas mission active.

Documents qui fixent cette édition

Fichier de référence	SHA-256
plan-v2.json	6a88d91878f825075342797596fc2fdd182d635924d9486a2a8007ea3bdcd1a7
preuves-S08.json	d87f16ddf35a1dfa0b101178cb3782a8dce62fa7ecddd018a2e63a96eb4b5966
preuves-S05.json	015273810b864089cfe61eec224378885badd996bd730ef335760ffb39eca5b6
preuves-S04.json	ca56a30d195c43e908a63ed714602d68726146cf50f0adf370535cb50c7728db
preuves-S06.json	5ee6ae78e4bb67b022563b4ed25e84a6970e766331c67cfa9a9be8b408b31544
README-V2.txt	c7ab846af4de81a7949c367316c519aae55542196321f1fb783f48729b0db617
prompt-commun-ia.yaml	25d88bf328c55d6a32aab86528e5e2b8c2bf9bf89fdd4b10d73853e579669679
graphe-ssp-diagnostics.json	f81c0ca278f4ab80d740218d5f5a6b2ea196a72db57423dd626c44f98399ad35
couverture-265-ssp.json	7bbdcd67407edd826c9013dcc65404d6673d0c684b4cf20da07eec16286fc81e
tests-garde.log	be40d83df698921da59e01421fe8f6acd643f12aca6788babdfdd9f4155fc079
recu-registre.json	36eb109a800cb8c1ee49b399d97bcba545a2bd41900555faf8183f54920c3eb4
progression-v2.json	380d5a79a1ee072efd1a484ceccae174f056f0d1b6f65bb17ae737188ae7888e
AUTORISATIONS_GITHUB.csv	3437a90a5ac3816a8835b4989e78109c3f75646be4a61bbff49e6dd67f785e77

Les empreintes lient cette édition aux données préparées. Le PDF ne transforme pas une proposition de source en passage consulté, un contrôle technique en contrôle clinique, ni un plan d’audit en audit effectué.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 02

Les unités de coordination : mission, cours, chemin et version

Objet	Contrat
Mission	ID stable ; rôle author/audit/integrator ; responsable de répartition Codex ou Claude ; acteur/conversation ; base SHA40 ; branche ; génération positive ; chemins autorisés ; approbation active dans la base trusted.
Cours	Catégorie CIM trois caractères et ses sous-codes ; propriétaire canonique unique. covers/alias/renvois examinés pour prévenir un doublon sémantique même si les noms de fichiers diffèrent.
Chemin	Répertoire propre et descendants ; la collision parent/enfant compte. Audit et auteur peuvent lire la même source mais ne partagent jamais la même sortie de rapport.
Version	SHA de base, SHA livré, SHA intégré, empreintes SHA256 des fichiers et sources utiles. Un succès sur un ancien SHA ne couvre pas automatiquement le nouveau.
Responsabilité	Chaque responsable garde la provenance de ses auteurs et lecteurs. Un sous-agent n’autorise ni double attribution ni travail simultané sur un fichier partagé.
Autorité	Parité Codex/Claude dans les règles du projet ; Vial prioritaire. Ces déclarations ne donnent ni token GitHub, ni permission Administration, ni preuve de l’identité réelle d’un modèle.

Ce qu’isole un worktree

Le répertoire, HEAD et l’index sont propres au worktree ; les objets/références et une partie de la configuration Git restent partagés. Ne pas déplacer la branche d’une autre tâche, nettoyer globalement les worktrees, modifier la configuration commune ou partager une sortie de build. Sur une autre machine, utiliser un clone distinct et le même registre distant.

Ce qu’un audit lecture seule signifie ici

L’audit n’a des chemins réservés que pour ses preuves et son rapport. Il examine un snapshot figé et son diff ne peut toucher les sources protégées. Ce contrat n’est pas une sandbox du système d’exploitation : le détenteur d’un accès filesystem ou d’un token peut tenter autre chose ; les contrôles et règles serveur doivent rendre ces écarts visibles ou les refuser.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 03

Répartition des fichiers : sources propres et intégration partagée

Propriétaire de la mutation	Exemples et contraintes
Auteur d’une leçon	chapters/CODE ; glossary/code.py ; ressources spécifiques attribuées ; dossier execution/ID. Le manifeste doit nommer les chemins réels, pas un joker qui ouvre un système entier.
Auditeur	docs/collaboration/ssp-v2/execution/ID uniquement pour rapport, recherche et preuves attribuées. Aucune correction source dans cette mission.
Intégrateur attribué	chapters.json et les seuls fichiers partagés explicitement réservés ; préserver exactement les lignes de catalogue hors cours attribués. La mutation nosology reste limitée aux quatre fichiers autorisés, selon configuration.
Coordinateur de gouvernance	Configuration garde et manifestes, dans une PR de gouvernance séparée des modifications source/catalogue. Il ne peut modifier sa propre approbation.
Documentation de préparation	Les documents ordinaires hors execution sont exemptés par la garde de périmètre. Le garde ne déduit pas le sens d’un rapport copié dans un autre dossier ; ce choix doit rester explicite.

Conflits détectables

Une réservation active bloque les autres mutations du même cours et les chemins égaux ou parent/enfant. Une mission “chapters/I63” entre en conflit avec “chapters/I63/I63_a.html” ; “chapters/I630” n’est pas le même préfixe. Les symlinks et sous-modules sont refusés aux ancêtres des chemins protégés pour éviter une redirection hors périmètre.

Identité : ce qui est déclaré et ce qui est authentifié

actor, conversation et owner sont des champs déclaratifs contrôlés pour cohérence ; un nom Codex/Claude n’authentifie pas le processus qui l’a fourni. Le contrôleur de confiance doit lier mission et branche au vrai compte/installation GitHub, à l’auteur PR, au dépôt head numérique et à une politique de fork. Avec des credentials partagés, l’attribution modèle/session ne peut pas être prouvée par cette seule garde.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 04

Le registre Git distant : réservation sérialisée sans écrasement

Le registre vit sur refs/heads/medina/session-registry et conserve les réservations actives et libérées. acquire lit la configuration et le manifeste approuvé dans la base trusted, récupère la tête distante, vérifie la génération et les collisions, ajoute une entrée, crée un commit enfant de cette tête, puis tente un push ordinaire. Aucun force-push, aucune réécriture et aucun retry automatique ne remplace le travail concurrent.

Situation	Résultat attendu
Deux clones ont la même ancienne tête	Deux commits frères ne peuvent tous deux avancer la même référence à avance rapide. Un gagne ; l’autre reçoit le refus Git, relit l’état et refait une décision explicite.
Réservation déjà obtenue	Nouvelle acquisition du même ID/génération refusée. Une nouvelle génération doit être strictement supérieure aux anciennes générations source pertinentes.
Libération périmée	--expected-registry permet de refuser une libération si le registre a avancé depuis sa revue ; génération et raison explicite requises.
Mission interrompue	Pas de libération automatique sur expiration ou silence. Conserver SHA/diff/worktree, clôturer ou transférer explicitement puis libérer la réservation.
Lecture d’un registre altéré	Vérifier schéma, unicité des réservations actives, collisions, hash du manifeste et génération ; la branche registre doit elle aussi être protégée contre des écritures non autorisées.
Administrateur hostile ou force-push autorisé	Le mécanisme normal à avance rapide ne suffit pas contre celui qui peut remplacer la référence ou changer les règles. Aucun caractère inviolable n’est revendiqué.

Une file durable d’intégration distincte

Une réservation n’est pas un reçu de livraison. Garder chaque demande d’intégration dans un registre durable jusqu’au reçu indiquant acceptation, rejet ou reprise. Actions concurrency seul peut remplacer une exécution en attente ; il n’est pas une file conservant nécessairement toutes les demandes. Dans ce dépôt personnel public, utiliser strict/up-to-date et un intégrateur séquentiel ; merge queue n’est pas disponible pour cette propriété.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 05

Commandes : statut réel et modèles de démarrage

La syntaxe ci-dessous est un modèle paramétré, pas une réservation exécutée sur des cours. Les aides CLI ont été consultées ; les scénarios de commande sont couverts par les tests locaux cités. Le reçu distant prouve uniquement l'initialisation du registre avec zéro réservation. Remplacer les champs par le manifeste approuvé exact et rafraîchir origin/main avant de fixer BASE.

```
python3 tools/ai_session_guard.py --help

python3 tools/ai_session_guard.py acquire --help

python3 tools/ai_session_guard.py start --help

python3 tools/ai_session_guard.py check --help
```

1. Rafraîchir et réserver, depuis un dépôt propre

```
git fetch origin

BASE=$(git rev-parse origin/main)

python3 tools/ai_session_guard.py status --base "$BASE"

python3 tools/ai_session_guard.py acquire MISSION --base "$BASE"
```

MISSION doit déjà être active dans .medina/missions/MISSION.json de la base. Les 270 manifestes planifiés de génération0 ne remplissent pas ce critère. L'initialisation d'une branche registre absente n'est pas une option acquire : l'absence provoque volontairement un échec.

2. Créer un espace isolé et valider l'entrée

```
git worktree add -b BRANCHE_EXACTE_DU_MANIFESTE /tmp/medina-MISSION "$BASE"

python3 tools/ai_session_guard.py start MISSION --base "$BASE" --actor IA_DECLAREE --conversation CONVERSATION_EXACTE --worktree /tmp/medina-MISSION
```

start exige branche assignée, HEAD exactement à la base, worktree propre et appartenant au dépôt, plus actor/conversation cohérents et réservation courante. Ne pas combiner comme un seul protocole conversation_workspace.py et ce gestionnaire : l'autre outil génère ses propres identifiants et noms de branche, sans lien automatique avec la mission centrale.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 06

Commandes : contrôler, livrer et libérer

3. Contrôler le candidat, sans exécuter son code en contexte privilégié

```
python3 tools/ai_session_guard.py check --base SHA_BASE_APPROUVEE --head SHA_CANDIDAT
--branch BRANCHE_EXACTE_DU_MANIFESTE
```

SHA_BASE_APPROUVEE et SHA_CANDIDAT sont des SHA40 existants. Un contrôleur de confiance fournit ces valeurs depuis l'événement GitHub et la base vérifiée ; des arguments arbitraires fournis localement ne prouvent pas leur authenticité. --registry-sha accepte un snapshot de registre déjà récupéré par ce contrôleur, pas un registre candidat choisi pour contourner la réservation.

4. Livrer une version précise

Conserver le SHA livré, la base, les chemins, les empreintes et les résultats ; pousser la branche de tâche et ouvrir la PR attribuée selon le workflow autorisé. Une ouverture de PR n'est pas une publication ; une CI verte n'est pas un audit médical. Une mutation partagée nécessite la mission intégrateur ; ne pas élargir les paths d'une mission auteur après coup pour éviter une erreur de garde.

5. Libérer après conservation explicite

```
python3 tools/ai_session_guard.py release MISSION --base SHA_BASE_APPROUVEE --generation
GENERATION --reason "Travail conservé, reçu et décision identifiés" --expected-registry
SHA_REGISTRE_RELU
```

La libération ajoute state=released et release_reason à la réservation historique ; elle ne supprime pas les fichiers ni leur provenance. L'ancienne génération ne peut pas être réacquise. Pour reprendre, obtenir une approbation de génération supérieure dans main puis acquérir cette génération. En cas de refus, ne pas forcer : lire l'état exact et résoudre la divergence de réservation.

Commandes de tests et portée de preuve

```
python3 -m unittest discover -s tests -p test_ai_session_guard.py -v
```

Le reçu tests-garde.log contient 18 tests OK en 20.209s. Cette commande reproduit le périmètre du fichier de tests ; elle est citée ici sans prétendre à une nouvelle exécution de cette édition PDF. Les fixtures utilisent des dépôts temporaires et des bare locaux ; elles ne rendent pas main protégé sur GitHub.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 07

Les scénarios réellement couverts par les tests

Famille de scénario	Vérification et limite
Mission autorisée / identité déclarée	Auteur inconnu mais attribué peut démarrer et changer sa source ; actor/conversation incohérents refusés.
Périmètre documentaire / ancien système	Planning ordinary et ancien système seul restent hors garde ; modification mixte d'un ancien système dans mission quatre systèmes refusée.
Confiance de la base	Mission nouvelle dans le candidat, modification de sa propre approbation et config désactivant sa propre source sont refusées.
Catalogue partagé	Mission intégrateur obligatoire ; comparaison structurée des lignes conserve exactement les cours hors mission.
Gouvernance séparée	Intégrateur préapprouvé ; pas d'auto-approbation ni de modification gouvernance couplée à source/catalogue.
Génération et libération	Registre avancé, ancienne génération, réacquisition et libération périmée refusés ; raisons et historique conservés.
Chemins et lectures simultanées	Parent/enfant en collision ; cours disjoints acceptés ; audit ne possède que ses sorties et n'écrit pas les sources.
Sorties execution et symlinks	Rapports execution exigent mission ; symlinks de source et parents protégés refusés, y compris ancêtres sans enfant précédemment suivi.
Worktree de démarrage	Branche exacte, HEAD de base, propreté et appartenance au dépôt vérifiés.
Concurrence réelle à deux processus	Deux clones issus du même parent, barrière avant push : un seul commit distant accepté. Pas de lost update.
Relais de gouvernance	Bootstrap, approbation du relais, libération explicite, acquisition relais, renouvellement auteur génération2 testés sans effacer l'historique.

Pour le détail exact des 18 méthodes et assertions, consulter tests/test_ai_session_guard.py, tests-garde.log et revue-garde.txt. Le nombre de familles ci-dessus n'est pas le nombre de méthodes de test.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 08

Relais de gouvernance sans auto-approbation

A. Préapprouver le relais

La mission bootstrap active et réservée propose le manifeste d'un coordinateur relais : autre ID, branche et conversation. Son diff est contrôlé ; le manifeste n'est fiable qu'après intégration dans main.

B. Conserver puis libérer

Sauvegarder worktree, SHA, diff et reçus. Libérer explicitement le bootstrap avant d'acquérir le relais lorsque leurs chemins de gouvernance se chevauchent.

C. Acquérir sur main frais

Le relais récupère le main contenant son approbation, acquiert sa réservation et crée son espace. Il peut fermer l'ancien bootstrap mais ne modifie jamais sa propre approbation.

D. Renouveler un auteur

Conserver le travail et libérer l'ancienne réservation ; le relais approuve dans une PR distincte la génération source strictement supérieure ; l'auteur acquiert ensuite cette génération depuis main.

E. Éviter le dernier mandat fermé

Préapprouver le prochain relais avant de fermer le dernier mandat de gouvernance. Sinon personne ne peut s'auto-approuver : récupération exceptionnelle humaine/administrateur nécessaire, séparée, motivée et tracée.

La récupération exceptionnelle n'est pas un "pass"

Ne pas désactiver la garde, inventer un manifeste antérieur ou prétendre qu'un contrôle a réussi. Une intervention administrative de récupération conserve l'incident, le travail sauvegardé, le changement exact, l'autorité et les vérifications renouvelées. Les autres tâches sans chevauchement peuvent continuer sous leur mandat existant.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 09

Intégration, conflits et reprise depuis un main frais

1. Comparer le diff utile

Une ancienne branche sert de preuve ou de source de patch ciblé ; sa fusion entière peut réintroduire règles et contenus dépassés. Inventorier SHA, cours, fichiers et réserves avant de reprendre.

2. Préparer un candidat actuel

L’intégrateur attribué repart du main courant, applique les seuls commits/patchs nécessaires, reconstruit les catalogues partagés et vérifie les invariants hors mission.

3. Résoudre sans choix aveugle

Un conflit de catalogue est une fusion structurée par code ; un conflit de passage médical devient une décision avec sources et lecteur. Ne pas choisir systématiquement ours/theirs et ne pas recopier une ancienne arborescence entière.

4. Revalider après avance de main

Si main ou le registre évolue avant intégration, vérifier les nouvelles collisions, reconstruire le candidat et renouveler les contrôles affectés. Le succès sur la précédente paire head/base ne suffit plus.

5. Émettre le reçu durable

Enregistrer demande, tâche, base, SHA livré/intégré, adaptations, empreintes, contrôles, réserves et décision. La demande ne disparaît pas avant ce reçu.

6. Publier avec ordre de version

Le déploiement cite le SHA intégré et son build ; vérifier URL et fichiers servis. Un ancien build fini tard ne doit pas écraser la version plus récente. Le reçu de publication médicale corrigée reste à préparer avant les corrections canoniques.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 10

GitHub : imposer la règle et respecter les limites observées

La garde locale et la CI rendent le périmètre contrôlable ; elles ne peuvent pas, seules, interdire toute écriture directe sur main par API ou un autre poste. Le serveur doit imposer l'ouverture d'une PR, le contrôle requis strict et les règles de branche. Le GET actuel de protection historique renvoie403 faute de permission Administration : ce n'est ni une preuve d'absence ni une preuve d'activation.

Mesure	Configuration et vérification nécessaires
Règle de main active	Require PR ; check garde obligatoire issu de la source attendue ; strict/up-to-date ; no force-push ; no delete ; linear history ; pas de bypass opérationnel, include admins/enforce_admins si protection historique.
Méthode de fusion	Autoriser squash ou rebase si linear history. Cette règle interdit les merge commits ; elle n'empêche pas à elle seule un push direct.
Propriété personnelle publique	Branch/tag rulesets et protections accessibles sur Free public. Merge queue : public détenu par organisation seulement ; indisponible pour le dépôt personnel actuel. Les restrictions legacy par acteurs qui poussent exigent également un dépôt organisation.
Éviter restrict_updates mal configuré	Cette règle réserve toute mise à jour aux acteurs de bypass et peut bloquer aussi les fusions normales ; ce n'est pas un simple synonyme de "PR obligatoire".
Branche registre	Interdire les modifications arbitraires, force-push et suppression ; coordonner les droits de l'allocateur. L'avance rapide protège contre commits frères normaux, pas contre acteur autorisé à réécrire la référence.
Lecture après activation	Relire ciblage, mode active, check/source, bypass et exigences ; démontrer refus push direct et cas invalides. Pas de statut "imposé" avant preuve distante.
Administrateur / propriétaire	Il peut éditer/supprimer les règles, changer workflows, permissions ou installations. Include-admin/no-bypass contraint les opérations tant que la règle existe ; aucune interdiction inviolable contre cet administrateur.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 11

CI de confiance : garder un échec réel et la bonne révision

Piège	Règle ou limite à appliquer
Workflow du candidat	Le contrôleur et Python viennent du base trusted ; le candidat est lu comme données Git. Pas d’import, action locale, hooks package, build, test ou artefact PR exécuté avec privilèges.
Statut sur la mauvaise révision	pull_request_target utilise le contexte base/default ; son GITHUB_SHA et ses checks automatiques ne prouvent pas un statut sur head PR. Attacher/vérifier explicitement le check requis au head courant et à la base/registre examinés.
Contexte Actions usurpé	GitHub Actions est une App commune à plusieurs workflows. Un autre workflow peut produire le même contexte : nom requis + source Actions ne prouve pas la provenance de la garde. Plus forte séparation : App reporter dédiée dont les credentials restent hors PR/writers, ou mécanisme organisationnel de workflow requis disponible.
Skipped / neutral	GitHub peut considérer ces états satisfaisants pour un required check. Verdict terminal inconditionnel : tous résultats obligatoires exactement success, preuves présentes et identités/révisions cohérentes. Aucun faux succès par filtre paths, condition de job ou erreur absorbée.
Bootstrap et post-push	Le workflow actuel indique la garde absente de base lors du bootstrap et laisse passer cette activation documentaire ; cela n’est pas un contrôle médical/source réussi. Son contrôle push main est diagnostic continue-on-error : il arrive après l’écriture et ne la prévient pas.
Secrets et dépendances	Permissions minimales ; actions épinglées par SHA complet à imposer ; pas de secrets/cache privilégié exposé au code PR. La référence checkout@v4 existante est mutable et sa mise à niveau constitue un jalon de durcissement, pas une garantie déjà obtenue.
Révision ou événement imprévu	Tête PR exacte, base trusted et registre frais ; événements supportés explicites. Un état inconnu ne devient pas “passed” ; un échec doit garder son code de sortie d’échec.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 12

Identités GitHub, forks et activation concrète

La branche et les champs de mission vérifient une cohérence opérationnelle. Pour une séparation forte, le contrôleur doit confronter le vrai GitHub actor, l'auteur PR, l'installation attendue et le dépôt numérique head aux données approuvées. Le présent garde déclaratif ne prouve ni quel modèle agit derrière un compte partagé, ni l'équité effective du travail fourni.

Politique de forks

La politique la plus simple refuse un dépôt head différent du dépôt base sauf approbation préalable liant exactement fork, acteur, branche, mission et chemins. Comparer les identifiants numériques de dépôt, pas seulement owner/name. Un dépôt public peut être forké ; le point contrôlable est l'admission du contenu dans main, pas l'interdiction générale de créer un fork.

Check-list de démonstration avant dire “imposé”

Démonstration	Réponse attendue
Push direct main	Refus par règle serveur, sans dépendre d'un hook local.
Mission absente / candidate	Refus ; l'approbation doit déjà exister dans base trusted.
Actor/fork/branche non lié	Refus selon politique d'identité explicite ; limite déclarative documentée si non implémentée.
Cours ou parent/enfant occupé	Refus ; autre tâche disjointe toujours possible.
Workflow / garde / preuve altérés	Aucune auto-validation du candidat ; source de verdict contrôlée.
Ancien SHA, ancien registre, skipped	Aucun succès réutilisé pour une version non vérifiée ; verdict terminal d'échec.
Mission valide et disponible	Réservation courante, diff limité, bonnes preuves ; contrôle accepté pour les empreintes exactes.
Relecture de configuration	Réponse distante enregistrée avec date, règle ciblée, mode active et bypass ; pas de403 interprété comme succès.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 13

Accès GitHub : actions concrètes et permissions réelles

Main : PR et contrôle strict

https://github.com/vialdjoukang-spec/Medina/settings/branches

Ajouter protection main > Require a pull request > Require status checks > MEDINA / mission et périmètre > Require branches up to date > inclure admins/sans bypass ; interdire force et suppression.

Administration propriétaire requise ; Application actuelle sans ce droit

Rulesets et source du contrôle

https://github.com/vialdjoukang-spec/Medina/settings/rules

Protéger main et workflows ; ne pas autoriser un autre workflow à usurper le contexte ; vérifier identités et voies de contournement.

Pas de ruleset public actif au relevé

Registre partagé

https://github.com/vialdjoukang-spec/Medina/tree/medina/session-registry

Garder cette branche dédiée ; autoriser écritures normales du coordinateur, interdire force et suppression ; aucune fusion de cette branche dans main.

Initialisé et relu distant e0874b89f6d7cb4c02acbff44ed90b9dad656928

Permissions des comptes

https://github.com/vialdjoukang-spec/Medina/settings/access

Vérifier les identités des comptes ou applications réelles de Codex et Claude ; même niveau nécessaire ; jamais partager de jeton.

Un nom IA ou --actor ne donne pas accès

Installation GitHub App

https://github.com/settings/installations

Ouvrir installation réellement utilisée > Configure > accès Medina ; accorder seulement les permissions nécessaires proposées ; si Administration absente, configurer protection via compte propriétaire.

Une permission absente du manifeste App ne peut pas être inventée

Ces liens rendent la configuration concrète et consultable. Aucun réglage serveur n’est prétendu appliqué par ce PDF ; le propriétaire agit avec ses droits réels, puis une lecture de retour et les démonstrations négatives établissent la portée obtenue.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 14

Sources primaires des règles GitHub

rulesets

https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-rulesets/about-rulesets

Rulesets branches/tags disponibles pour dépôts personnels publics Free ; les règles se cumulent. Les push rulesets ont une disponibilité distincte.

available_rules

https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-rulesets/available-rules-for-rulesets

PR, contrôles, historique linéaire et restriction de mise à jour sont des règles distinctes ; la source App du statut requis peut être fixée.

protected_branches

https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches

Public Free pris en charge ; administrateurs exemptés par défaut sauf inclusion. Les états success, skipped et neutral peuvent satisfaire les contrôles requis. Restriction des acteurs qui poussent réservée aux dépôts détenus par organisation.

merge_queue

https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/configuring-pull-request-merges/managing-a-merge-queue

File de fusion disponible en public détenu par organisation, ou privé organisation Enterprise Cloud ; indisponible pour Medina personnel. merge_group doit être contrôlé si cette option devient disponible.

workflow_events

https://docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/events-that-trigger-workflows

pull_request_target utilise le contexte default/base ; ne pas y exécuter du code PR non fiable. Son SHA automatique est celui de la base, pas head PR.

secure_use

https://docs.github.com/en/actions/reference/security/secure-use

Pas de checkout/exécution de code non fiable ni confiance aveugle aux artefacts dans les contextes privilégiés ; épingler les actions à un SHA complet.

required_status_troubleshooting

https://docs.github.com/en/pull-requests/how-tos/merge-and-close-pull-requests/troubleshooting-required-status-checks

Le contrôle requis doit effectivement être exécuté sur la bonne révision ; distinguer job skipped, workflow filtré et verdict réellement positif.

Observations de lecture publique

GET api.github.com/repos/vialdjoukang-spec/Medina/rulesets →200 [] ; GET /rules/branches/main →200 []. Ces observations montrent l’absence de rulesets listés/effectifs à l’instant de lecture, sans déterminer la protection historique inaccessible via App. Aucune écriture de settings n’a été faite par l’analyse méthodologique.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 15

SSP : de la présentation au diagnostic et à la compétence

PROFILES2017, pages imprimées26–27, décrit des points d’entrée génériques : circonstances, symptômes, plaintes et résultats que le jeune résident doit évaluer de façon structurée, en établissant un différentiel et des mesures adaptées. Les situations fréquentes, urgentes ou sources de détresse ont été retenues ; leurs implications varient selon âge, sexe/genre, temporalité et lieu de soins.

Type de lien	Ce qu’il permet de dire
Diagnostic causal / diagnostic	Une entité peut expliquer la présentation dans un contexte défini ; passage clinique et sous-entité explicités. Une catégorie de codage large n’est pas un diagnostic individuel.
Différentiel	Alternative à envisager/évaluer/exclure ; discrimination, tests initiaux et urgence à décrire dans la démarche. Une liste de noms n’est pas une stratégie diagnostique.
Contexte / notion	Risque, complication, mécanisme, terrain ou accompagnement sans causalité/différentiel établi. Utile à enseigner, ne crée pas une couverture diagnostique.
Compétence / parcours de soins	Consentement, refus, prévention, screening, communication, vulnérabilité, coordination, fin de vie ; objectif transversal/scénario, pas maladie artificielle.
Hors périmètre actuel	Autre propriétaire ou contexte hors quatre systèmes ; renvoi en lecture seule conservé. Cela ne signifie pas “non exigible à l’examen”.
Candidat / non résolu	Source non lue, insuffisante ou lien incertain ; proposition conservée sans la compter comme diagnostic étayé.

Le graphe v2 reste partiel

472 arêtes transmises : 91 diagnostics, 329 différentiels, 19 contextes, 33 candidats. 95 SSP ont au moins une arête, 92 hors candidats, 88 un diagnostic ou différentiel. Quatre ont seulement du contexte ; trois seulement des candidats ; 170 ne sont pas documentées dans ce contrôle. Aucun de ces nombres ne mesure l’exhaustivité clinique.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 16

Pourquoi 265/265 glouton ne démontre pas une couverture clinique

tools/import_nosology.py attribue historiquement des SSP par plages de catégories ; tools/pathologies_ssp.py prend fréquentes et cours filled, ajoute gloutonnement les catégories gagnant le plus de tags, puis MANUAL complète des liens proposés. Chaque étape manipule une incidence pédagogique qui reste à justifier ; la complétude de cette incidence ne valide ni le lien ni le contenu d'un cours.

Étape de simulation exacte sur arbre méthodologique	Catégories / SSP
Socle : fréquentes + catégories state filled	299 / 142
Après couverture gloutonne	347 / 219
Après107 paires MANUAL	398 / 265
Ancien fichier ANNEXE_PATHOLOGIES_SSP.md	291 / 265, état historique non régénéré

Le glouton ne prouve pas une solution minimale ; les cours existants et fréquents sont préimposés. Le départage du code actuel utilise seulement la première lettre et l'ordre d'entrée, contrairement au commentaire évoquant le code. Conserver source commit et ordre des données pour reproduire une comparaison. Ces nombres globaux ne sont pas les 258 catégories conservatoires des quatre systèmes.

Réparer les sept libellés tronqués sans réécrire les cours

La regex historique lit une seule ligne physique du PDF ; les identifiants1–265 sont complets, mais sept libellés perdent une continuation. L'annexe v2 corrige39,66,93,130,216,226,227 et conserve les258autres. Les sources globales et les cours anciens restent inchangés ; SSP238 est déjà complet. Pour66, le PDF rendu confirme "premenstrual symptoms" malgré la ligature extraite dans le mauvais ordre.

SSP / page	Libellé complet normalisé
39 · p29	visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour blindness, blurred vision
66 · p29	menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation, premenstrual symptoms
93 · p30	macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, necrosis, tumours

SSP / page	Libellé complet normalisé
130 · p31	non-medical substance use (“misuse”), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal substances (“controlled medicines”), gambling and gaming
216 · p33	sudden changes of mental status such as confusion, delusion, (auto-)aggressive behaviour
226 · p33	shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic conditions
227 · p33	shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising diseases, such as cardiovascular, metabolic and oncologic diseases

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 17

Le dossier de preuve d’un lien SSP

Champ	Exigence
Situation	Numéro officiel, libellé anglais complet et page PROFILES ; traduction séparée si vérifiée.
Diagnostic / sous-entité	Entité clinique, catégorie3caractères, sous-code examiné si utile et propriétaire canonique ; contexte âge/setting/temporalité.
Relation	Diagnostic, différentiel, contexte, compétence, hors périmètre ou candidat ; motif clinique et niveau de nécessité.
Source	URL, titre/éditeur, version/date, page/section, passage effectivement consulté, date de consultation, empreinte si disponible ; limite de lecture explicite.
Contrôle	Auteur/lecteur, décision et réserve, statut réel ; source de codage distingue le code mais ne prouve pas à elle seule la présentation clinique.
Cours	Chemin, onglet/ancrage et empreinte du contenu qui enseigne raisonnement, discrimination et premières actions ; course planned ≠ content delivered.
Traçabilité normalisée	ID stable de l’arête, fichier source, index/pointeur JSON et preuve originale conservée. Les identifiants originaux et IDs normalisés peuvent différer ; ne pas en déduire une arête manquante.

Validation de portée avant validation de total

• Figer le commit et les empreintes des sources, le libellé et la page PROFILES, le catalogue des quatre systèmes et la portée exacte de revue.

• Typer chaque lien, préciser population, âge, lieu de soins, temporalité, grossesse ou gravité ; vérifier le code et son libellé officiel.

• Lire la section clinique elle-même : source suisse puis européenne, éditeur, version, passage/page, date et limites. Un HTTP200 ne vaut pas preuve médicale.

• Justifier la pertinence fréquente, urgente ou contextuelle sans déduction par mot partagé, simple plage CIM ou mention indirecte ; garder sources contradictoires et incertitudes.

• Distinguer proposition, passage consulté, lien documenté, décision éditoriale et validation indépendante réellement effectuée. Aucun statut favorable sans contrôle accompli.

• Repérer la section du cours qui enseigne démarche, discrimination, actions et drapeaux rouges ; un cours planifié reste distinct d’un contenu livré.

• Examiner le différentiel attendu et les variations de contexte ; une seule arête par SSP ne suffit jamais à déclarer une complétude clinique.

• Livrer une matrice où diagnostics, différentiels, contextes, compétences, hors-périmètre et incertitudes sont séparés, avec sources et ancrages versionnés.

Conserver le doute sans détruire le socle

Une catégorie historique non recontrôlée reste conservée avec son statut. Les11ajouts documentés se joignent au socle247 ; cela ne permet pas d’appeler les258catégories “revalidées”. Les19catégories candidates S04, des catégories hématologiques non précisées et d’autres familles gardent leurs lacunes visibles. Un examen clinique complet de chaque SSP doit encore rechercher les alternatives et contextes non couverts.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 18

Annexe : triage documentaire des 265 SSP

Cette annexe énumère les265situations officielles, pas265situations entièrement couvertes. D=documenté diagnostique partiel ; C=contexte seul ; P=candidats seuls ; ND=non documenté dans cette revue bornée. Un renvoi hors quatre systèmes conserve son propriétaire et n’autorise aucune modification de ce système.

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
1	abnormal perspiration	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E05, E16
2	enlarged lymph nodes (lymphadenopathy)	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 6 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C77, C81, C82, C83, C84, C91
3	excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia)	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 4 · Diff 3 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : E10, E11, E13, E21, E23, E83, N25, R63
4	fatigue, tiredness	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 3 · Diff 17 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C82, C90, C92, D50, D59, D64, E03, E05, E10, E11, E16, E23, E27, E83, E87, E88, N18
5	feeling of illness	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
6	fever, chills, hyperthermia	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 4 · Ctx 1 · Cand 2 Codes : D70, D76, E05, G00, N10, N12, N13, N15
7	flushing	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E05
8	hypothermia	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E16
9	itching	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : N18
10	pain of all types	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
11	sleep problems	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
12	swelling, oedema (diffuse or local)	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 4 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C64, N00, N04, N17, N18
13	unnatural death	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
14	unexpected or sudden death	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
15	weight gain, obesity	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E03, E24, E66
16	weight loss, malnutrition, loss of appetite	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 3 · Diff 5 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E05, E10, E11, E13, E27, F50, K90, N18
17	abnormal eye movements	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
18	acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
19	alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : G52, R49
20	asymmetric face, deformation	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : G51
21	bleeding nose	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
22	blepharospasm	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
23	difficulty in swallowing, choking	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 3 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : G12, G52, G70

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
24	discharge from ear	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
25	dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
26	earache	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
27	facial, jaw or tooth pain, trismus	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : G50
28	hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
29	micro- and macrocephaly	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : Q03
30	nasal discharge	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
31	nasal obstruction	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
32	neck stiffness and pain	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
33	painful, red, itchy eyes; eye discharge	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
34	snoring	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
35	sore throat	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
36	squint (strabismus)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
37	swelling of face, lips, neck; goitre	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 6 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C73, D34, E01, E04, E05, E06
38	swelling of the eyelid	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : N04
39 *	visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour blindness, blurred vision	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 4 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E16, E22, G43, G70, G93
40	apnoea, apnoea with arousal	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
41	change of respiratory pattern	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
42	changes of breast size, breast lump, breast discharge	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E22
43	chest discomfort	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
44	chest pain	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
45	cough, expectoration, haemoptysis	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
46	dyspnoea	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : N18
47	heartburn (pyrosis)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
48	impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
49	painful respiration, wheezing, stridor	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
50	palpitations	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
51	parietal chest pain	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
52	abdominal, epigastric pain	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E88
53	abdominal distension	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
54	abdominal mass	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C64
55	altered defaecation pattern, incontinence, pain	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
56	anal itching, anal pain, anal protrusion	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
57	anal bleeding	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
58	constipation	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E83
59	diarrhoea	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E05
60	melena, fresh blood, mucus, pus in faeces	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
61	nausea, vomiting	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 5 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E05, E83, E86, E88, N10, N18
62	atypical sexual development	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E25, E34

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
63	anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 6 · Diff 6 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E10, E11, E13, E21, E23, E83, N00, N04, N13, N17, N18, N25
64	dysuria, pyuria, haematuria	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 8 · Ctx 0 · Cand 4 Codes : C64, C65, C66, N00, N02, N07, N08, N10, N12, N13, N28, Q61, S37
65	issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 6 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E22, E23, E28, E29, E34, E89
66 *	menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation, premenstrual symptoms	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 5 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E22, E24, E25, E28, E89
67	pelvic mass	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
68	pelvic pain	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
69	request for contraception, emergency contraception	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
70	request for genetic counselling	C — contexte seul Diag 0 · Diff 0 · Ctx 1 · Cand 1 Codes : N07, Q61
71	scrotal pain, swelling, mass	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
72	sexual complaints and dysfunction	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 3 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E22, E23, E29
73	swelling, pain in groin	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
74	symptoms related to menopause	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E28

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
75	urethral discharge	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
76	urinary incontinence and enuresis	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
77	urinary retention	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
78	uterine prolapse, pelvic relaxation	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
79	vaginal bleeding	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
80	vaginal discharge	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
81	abnormal posture and back deformities	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
82	back pain	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 5 · Ctx 0 · Cand 2 Codes : C64, C65, C66, N10, N15, N28, Q61
83	deformities of skeleton and joints	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
84	myalgia	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : G71
85	pain, burning, cramp, numbness in the extremities	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 2 · Diff 4 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : G54, G56, G60, G61, G62, G63, N18
86	swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : E79, M10
87	changes in oral, genital or perianal mucosa	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
88	ecchymosis, haematoma, purpura	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 6 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C92, D65, D66, D67, D68, D69
89	hyper- or hypopigmentation	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
90	infected wound, delayed wound healing, skin ulcers	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
91	jaundice (icterus)	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : D59, E80
92	lack or loss of hair, excess hair	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 6 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E23, E24, E25, E28, E34
93 *	macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, necrosis, tumours	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
94	nail complaints	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
95	redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
96	abnormal sense of balance, falls	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : G20, G23, I63
97	abnormal gait	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 2 · Diff 5 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : E51, E53, G20, G23, G62, G91, I63, R26
98	abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 3 · Diff 3 · Ctx 2 · Cand 0 Codes : E16, G10, G20, G21, G23, G24, R25, R27
99	disorders of speech or language	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 5 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : G12, G43, G45, G52, I61, I63, R47
100	dizziness, vertigo	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 3 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : G43, H81, I63, R42

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
101	headache	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 3 · Diff 9 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C70, C71, D32, E22, G00, G43, G44, G93, G96, I67, N18
102	memory disturbance, cognitive impairment	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 2 · Diff 8 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : C71, E03, F01, F32, G10, G30, G31, G45, G91, N18, R41
103	paresis, paralysis	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 3 · Diff 15 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : C70, C71, D32, E53, G12, G35, G36, G45, G51, G54, G56, G57, G61, G70, G71, I61, I63, R29
104	sensory loss, changes in various forms of sensation	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 3 · Diff 11 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : C71, D32, E53, G35, G36, G43, G54, G56, G57, G60, G61, G62, G63, I61, I63
105	twitches, convulsion, seizure	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 2 · Diff 5 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C70, C71, D32, E16, E87, G40
106	abdominal injuries	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : S37
107	burn, cold injury	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
108	contusion, soft tissue bruising	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
109	dislocation of joint	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
110	drowning or near drowning	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
111	foreign body	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
112	head and brain injuries and trauma	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : S06
113	injuries of the extremities	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
114	laceration, closed or open wound	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
115	spine injuries	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
116	thoracic injuries	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
117	vascular injuries	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
118	anxiety and panic	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
119	attention deficit	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
120	change in behaviour	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : G10, G31
121	change in eating behaviour	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
122	change in mood	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
123	hyperactivity	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
124	irrational fear, fear of illness	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
125	irritability, aggressive and violent behaviour	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
126	mental confusion, delirium	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 3 · Diff 3 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : E05, E22, E83, E87, F05, G04, R41
127	obsessive and/or compulsive behaviour	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
128	reactions to major stressful events	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
129	self-harm, including suicide	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
130 *	non-medical substance use (“misuse”), addiction e.g. tobacco, alcohol, illegal substances (“controlled medicines”), gambling and gaming	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
131	abnormal blood pressure	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 6 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E24, E25, E26, N00, N18, Q61
132	abnormal external genitalia (female, male)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
133	abnormal findings upon auscultation	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
134	abnormal findings upon inspection	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
135	abnormal findings upon palpation	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
136	abnormal findings upon percussion	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
137	bradycardia, tachycardia, irregular pulse	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E05, E16
138	cachexia and malnutrition	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
139	cognitive impairment	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 5 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E03, F01, F32, G30, G31, G91
140	cyanosis	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : D74
141	disorganised speech	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
142	exophthalmos (proptosis)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
143	halitosis (fetor oris)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
144	gangrene	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
145	impairment or loss of consciousness, coma	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 4 · Diff 7 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : E05, E15, E16, E22, E51, E83, E87, G40, G41, R40, S06
146	oedema	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 4 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C64, N00, N04, N17, N18
147	pallor	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 3 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C92, D50, D59, D64
148	pulseless patient	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
149	transient loss of consciousness, syncope	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : R55
150	abnormal blood gas values	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : N17, N25
151	abnormal cardiac enzymes	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
152	abnormal coagulation profile	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 3 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : D66, D67, D68
153	abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
154	abnormal leukocyte count	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 5 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C91, C92, D61, D70, D72, D76
155	abnormal ECG	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E88
156	abnormal electrolytes	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 2 · Diff 20 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C75, E03, E05, E20, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E55, E67, E83, E86, E87, E88, E89, N17, N18, N25
157	abnormal faecal analyses, occult blood, parasites	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
158	abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 5 · Diff 5 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E10, E11, E13, E15, E16, E22, E24, E74
159	abnormal histology, cytology and molecular genetic test	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 5 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C64, C65, C66, C73, C81, D34, D47
160	abnormal liver enzymes	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
161	abnormal markers of kidney function	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 2 · Diff 7 · Ctx 0 · Cand 10 Codes : E86, E88, N00, N01, N03, N08, N11, N13, N14, N16, N17, N18, N19, N26, N27, N29, Q60, Q61, Q62
162	abnormal serum lipids	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 4 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E03, E10, E11, E78, N04
163	abnormal thyroid hormones	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 9 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E03, E05, E06, E07, E22, E23, E34, E89
164	abnormal urine sediment	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 4 Codes : N01, N02, N03, N05, N10
165	anaemia	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 16 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C82, C88, C90, C92, D50, D51, D52, D55, D56, D57, D58, D59, D61, D62, D63, D64, D76
166	blood group incompatibility	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
167	effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
168	elevated biomarkers of inflammation	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
169	low bone density	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E21
170	nutritional deficiencies	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
171	polycythaemia	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : D75
172	proteinemia, albuminemia	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C88, C90, N04

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
173	proteinuria	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 2 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 5 Codes : N00, N01, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N18
174	thrombopenia, thrombocytosis	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 7 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : C92, D47, D61, D65, D69, D73, D76
175	abnormal birth weight and prematurity	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
176	basic care in normal delivery and childbed	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
177	basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation	C — contexte seul Diag 0 · Diff 0 · Ctx 1 · Cand 2 Codes : Q60, Q62, Q63
178	maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
179	problems related to delivery	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
180	problems related to lactation	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
181	process and basic care of pregnancy	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
182	request for abortion	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
183	suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
184	abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E22, E23

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
185	behavioural issues in childhood and adolescence	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
186	child abuse and neglect	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
187	child immunisation	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
188	developmental delay	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
189	feeding and eating issues during infancy, childhood and adolescence	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
190	fetal problems during pregnancy	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
191	infant death	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
192	irritable, crying infant	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
193	learning and school problems in childhood and adolescence	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
194	low muscle tone and hypotonia	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
195	well-baby and well-child visit	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
196	elder abuse and neglect	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
197	functional impairment (cognition, sensory and motor)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
198	malnutrition and sarcopenia	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
199	polymorbid, polymedicated patient	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
200	pressure ulcers	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
201	progressively dependent patient	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
202	urinary and faecal incontinence	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : G91
203	acute abdominal, epigastric pain	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
204	acute chest; epigastric, arm, jaw, tooth pain	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
205	acute neurological deficits	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 5 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : G35, G43, G45, I60, I61, I63
206	acute severe dyspnoea	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : N17
207	acute severe headache, meningism	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : G00, I60
208	burn	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
209	colic	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
210	haematemesis	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
211	intoxication, poisoning	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
212	mydriasis, myosis	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
213	self-harm and suicide attempt	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
214	severe hypertension, severe hypotension	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
215	severe acute blood loss	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 0 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : D62
216 *	sudden changes of mental status such as confusion, delusion, (auto-)aggressive behaviour	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 2 · Diff 1 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : F05, G04, S06
217	syncope, loss of consciousness	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 1 · Diff 2 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E15, G40, R55
218	cardiorespiratory disturbances and arrest	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
219	seizures	D — diagnostic/différentiel partiel Diag 2 · Diff 4 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : E16, E87, G04, G40, G41
220	uncomplicated common trauma	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
221	consultation before engaging in sports activities	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
222	immunization plan	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
223	promotion of healthy life style	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
224	request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
225	screening for asymptomatic conditions	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
226 *	shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic conditions	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
227 *	shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising diseases, such as cardiovascular, metabolic and oncologic diseases	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
228	caregivers’ fatigue, loss of energy	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
229	change in treatment goals and end-of-life decisions	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
230	holistic care of the dying patient	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
231	management of refractory symptoms (pain, nausea)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
232	need for psychosocial and spiritual support of all involved individuals	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
233	absenteeism (school, work)	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
234	concern about appearance, body image	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
235	domestic violence, sexual abuse, rape	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
236	harassing, bullying, mobbing	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
237	issues regarding sexual orientation	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
238	issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
239	loss, death, grieving process, illness of someone close	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
240	mental or spiritual suffering	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
241	problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
242	consultation before or after trip to foreign (tropical) country	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
243	determination of work or school incapacity	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
244	dietary counselling	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
245	environmental and psychosocial aspects of chronic condition	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
246	errors or misconduct of a co-worker or other healthcare professional	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
247	immunocompromised patient	C — contexte seul Diag 0 · Diff 0 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : D70
248	issues linked with food tolerance	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
249	medically unexplained symptoms	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
250	nosocomial infection	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
251	obtain informed consent for a procedure	P — candidats seuls Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 1 Codes : Z49
252	patient refusing treatment	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
253	patient with sexually transmitted infection	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
254	patient with other cultural background, migration	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
255	physical and psychosocial inpatient and outpatient rehabilitation	P — candidats seuls Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 1 Codes : Z49
256	poor adherence to treatment	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
257	pre-intervention and pre-operative assessment	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
258	request for certificate, attestation or expertise by patients and insurers	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
259	request for unnecessary investigations and treatment	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
260	request for information about gene therapy	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
261	request for information related to organ donation, transplantation	C — contexte seul Diag 0 · Diff 0 · Ctx 1 · Cand 0 Codes : N18

SSP	Libellé officiel anglais	Triage et catégories
262	benefits and risks of complementary medicine	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
263	suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)	P — candidats seuls Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 1 Codes : N14
264	suspicion of rare disease	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun
265	vulnerable patient	ND — non documenté ici Diag 0 · Diff 0 · Ctx 0 · Cand 0 Codes : aucun

* Libellé réparé dans la copie scoped v2. Les identifiants d’arêtes par SSP se trouvent dans couverture-265-ssp.json ; le graphe détaillé ci-après permet de retrouver sources, justifications et limites.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 19

Annexe : graphe probant — N-05 — Neurologie

146 arêtes issues de preuves-S08.json. Les arêtes de contexte/candidat restent explicitement séparées ; les renvois ne changent pas leur propriétaire.

SSP 6 → G00 · diagnostic

Méningite bactérienne sans classement étiologique ailleurs · Méningite bactérienne, non classée ailleurs

Fièvre, céphalée et raideur méningée motivent la recherche d’une méningite bactérienne.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-bd92c50ab6951f1e3c65 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/26
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	mening · Bacterial meningitis; Symptoms of meningitis https://www.usz.ch/en/disease/meningitis-inflammation-of-the-meninges/
Source / section	icd · ClaML: G00; catégorie G00 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 6 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 19 → G52 · differentiel

Atteinte des nerfs crâniens IX/X · Affections des autres nerfs crâniens

La source décrit dysphagie, dysarthrie et dysphonie dans les atteintes de ces nerfs.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0d9aa69a5bae632e1d68 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/94
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	pocket · p51 HN IX et X https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G52.1, G52.2; catégorie G52 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 19 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 19 → R49 · contexte

Dysphonie · Troubles de la voix

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-99292eb4dfdec1b72cb2 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/123
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	profiles · SSP 19 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R49; catégorie R49 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 19 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 20 → G51 · diagnostic

Paralysie faciale périphérique · Affections du nerf facial [nerf crânien VII]

La paralysie faciale périphérique est distinguée des lésions centrales et des causes infectieuses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8c741c1e9f7e3b1755e3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/91
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p50 HN VII Fazialisparese https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G51.0; catégorie G51 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 20 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 23 → G12 · differentiel

Sclérose latérale amyotrophique / maladie du motoneurone · Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

La faiblesse progressive et les troubles bulbaires sont décrits; SLA est explicitement incluse en G12.2 dans le ClaML.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-33c2b59db53adb6a691b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/65
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	als · ALS-Diagnose; Sprech-, Schluck- und Atemfunktion https://www.usz.ch/krankheit/amyotrophe-lateralsklerose/
Source / section	icd · ClaML: G12.2; catégorie G12 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 23 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 23 → G52 · differentiel

Atteinte des nerfs crâniens IX/X · Affections des autres nerfs crâniens

La source décrit dysphagie, dysarthrie et dysphonie dans les atteintes de ces nerfs.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-67edb47ccd00fd17e4af docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/93
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p51 HN IX et X https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G52.1, G52.2; catégorie G52 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 23 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 23 → G70 · differentiel

Myasthénie · Myasthénie et autres affections neuromusculaires

Une présentation oculaire, bulbaire ou généralisée doit être distinguée des autres causes neuromusculaires.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cb5725fae064e1beeb51 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/70
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	pocket · p67 Myasthenia gravis; p68 crise https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G70.0; catégorie G70 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 23 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 27 → G50 · diagnostic

Névralgie du trijumeau · Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V]

La douleur faciale paroxystique dans le territoire trigéminal est explicitement décrite.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3d9716553bf22027f097 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/7
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p42 Trigeminusneuralgie https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G50.0; catégorie G50 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 27 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 29 → Q03 · diagnostic

Hydrocéphalie congénitale · Hydrocéphalie congénitale

Le périmètre crânien augmenté chez le nourrisson doit être relié à une cause concrète, pas à l’ensemble Q00–Q07.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ca6c612d1041fad8bef6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/63
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	hydro · Formes congénitales; symptômes nourrisson https://www.usz.ch/krankheit/hydrocephalus/
Source / section	icd · ClaML: Q03; catégorie Q03 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 29 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 39 → G43 · differentiel

Migraine avec aura · Migraine

Les phénomènes visuels, sensitifs, du langage et parfois moteurs de l’aura imposent une distinction avec un événement aigu.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d85f5a4ef9d5f105e9ef docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/1
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p41 Migräne mit Aura https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G43.1; catégorie G43 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 39 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 39 → G70 · differentiel

Myasthénie · Myasthénie et autres affections neuromusculaires

Une présentation oculaire, bulbaire ou généralisée doit être distinguée des autres causes neuromusculaires.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4b4749860eb457d8c7a0 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/69
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p67 Myasthenia gravis; p68 crise https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G70.0; catégorie G70 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 39 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 39 → G93 · differentiel

Hypertension intracrânienne idiopathique · Autres affections du cerveau

Les troubles de pression du LCR figurent dans la démarche des céphalées après exclusion d’autres causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0f3d1b525e3256af9c8a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/97
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	pocket · p43 Idiopathische intrakranielle Hypertension https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G93.2; catégorie G93 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 39 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 84 → G71 · differentiel

Dystrophie musculaire · Affections musculaires primitives

Les dystrophies sont nommées dans le bilan d’une faiblesse musculaire; toutes les myopathies ne sont pas G71.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-42e034f0105a9634616e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/90
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	nmz · Beispiele vererbbarer neuromuskulärer Krankheiten; symptômes https://neurologie.insel.ch/de/unser-angebot/neuromuskulaeres-zentrum/fragen-und-antworten
Source / section	icd · ClaML: G71.0; catégorie G71 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 84 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 85 → G54 · differentiel

Atteinte radiculaire non classée ailleurs · Affections des racines et des plexus nerveux

Une topographie radiculaire est décrite; G54 reste conditionné à l’absence d’étiologie classée ailleurs.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c6441a45cbab8aafa0c8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/86
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p65 Radikuläre Syndrome; p64 distinction radiculaire/nerf https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G54.2, G54.4; catégorie G54 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 85 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 85 → G56 · diagnostic

Syndrome du canal carpien / atteinte ulnaire ou radiale · Mononévrite du membre supérieur

Les distributions sensitives et motrices sont distinguées par nerf, sous une catégorie mère.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c45734aebad75c30f4e6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/81
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p64 Periphere Nervenläsionen https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G56.0, G56.2, G56.3; catégorie G56 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 85 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 85 → G60 · differentiel

Neuropathie héréditaire / Charcot-Marie-Tooth · Neuropathie héréditaire et idiopathique

Une cause héréditaire est explicitement distinguée des causes diabétiques et toxiques.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5d4c7b45dafdae661d86 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/77
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pnp · Ursachen: formes héréditaires https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/
Source / section	icd · ClaML: G60.0; catégorie G60 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 85 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 85 → G61 · differentiel

Guillain-Barré et CIDP · Polynévrites inflammatoires

Les formes aiguës et chroniques inflammatoires sont nommées et décrites, avec faiblesse et troubles sensitifs.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ac0f69451efbb0f1262e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/73
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pnp · Immunvermittelte Polyneuropathie https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/

Trace	Détail
Source / section	icd · ClaML: G61.0, G61.8; catégorie G61 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 85 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 85 → G62 · diagnostic

Polyneuropathie toxique / alcoolique · Autres polynévrites

La source décrit troubles sensitifs distaux, douleurs et atteinte de marche; alcool/toxiques forment des causes identifiées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-59cd5e1c1531e4c95fce docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/74
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pnp · Toxische Polyneuropathie; symptômes https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/
Source / section	icd · ClaML: G62.1, G62.2; catégorie G62 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 85 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 85 → G63 · contexte

Manifestation de polyneuropathie diabétique · Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs

Code de manifestation astérisque: à relier à l’étiologie diabétique, sans produire une maladie indépendante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-41b94433636c817cc773 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/79
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pnp · Diabetische Polyneuropathie https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/
Source / section	icd · ClaML: G63.2; catégorie G63 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 85 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 96 → G20 · diagnostic

Maladie de Parkinson · Maladie de Parkinson

Bradykinésie, tremblement, instabilité et perturbation de marche sont décrits.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fd7d7a661635e9c00631 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/45
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	park · Parkinson: Symptome https://www.usz.ch/krankheit/parkinson/
Source / section	icd · ClaML: G20; catégorie G20 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 96 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 96 → G23 · differentiel

Parkinsonisme atypique: PSP ou atrophie multisystématisée · Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux

Des troubles de marche/chutes précoces et dysautonomie conduisent à distinguer les formes atypiques.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2832f57bbd73fc0ae0bf docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/49
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	parkin · Atypische Parkinsonsyndrome https://www.parkinson.ch/themen/atypische-parkinsonsyndrome
Source / section	icd · ClaML: G23.1, G23.2, G23.3; catégorie G23 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 96 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 96 → I63 · differentiel

Infarctus du tronc cérébral ou du cervelet · Infarctus cérébral

L’infarctus central est nommé parmi les diagnostics du syndrome vestibulaire aigu.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3ed8d0598ce0c302340d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/23
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p57–58 Schwindel https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: I63; catégorie I63 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 96 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 97 → E51 · differentiel

Encéphalopathie de Wernicke · Carence en thiamine [carence en vitamine B1]

La source associe trouble de conscience, oculomotricité et ataxie à une carence en thiamine.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1d60edfd1e28a48d4406 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/143
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p35 B1 Mangel https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E51.2; catégorie E51 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 97 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 97 → E53 · differentiel

Carence en vitamine B12 sans anémie nécessaire · Autres avitaminoses du groupe B

Myéloneuropathie et troubles de sensibilité/marche peuvent exister sans anémie; D51 ne doit pas être attribué automatiquement.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2b49f0d3787e7ab6a4b5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/141
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	pocket · p35 B12 Mangel https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E53.8; catégorie E53 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 97 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 97 → G20 · diagnostic

Maladie de Parkinson · Maladie de Parkinson

Bradykinésie, tremblement, instabilité et perturbation de marche sont décrits.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-07f294f9d01d1e1b8137 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/44
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	park · Parkinson: Symptome https://www.usz.ch/krankheit/parkinson/
Source / section	icd · ClaML: G20; catégorie G20 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 97 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 97 → G23 · differentiel

Parkinsonisme atypique: PSP ou atrophie multisystématisée · Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux

Des troubles de marche/chutes précoces et dysautonomie conduisent à distinguer les formes atypiques.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f187653bd6a1fdebd8ce docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/48
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	parkin · Atypische Parkinsonsyndrome https://www.parkinson.ch/themen/atypische-parkinsonsyndrome
Source / section	icd · ClaML: G23.1, G23.2, G23.3; catégorie G23 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 97 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 97 → G62 · diagnostic

Polyneuropathie toxique / alcoolique · Autres polynévrites

La source décrit troubles sensitifs distaux, douleurs et atteinte de marche; alcool/toxiques forment des causes identifiées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ce1ec70d3c37608f0192 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/76
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pnp · Toxische Polyneuropathie; symptômes https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/
Source / section	icd · ClaML: G62.1, G62.2; catégorie G62 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 97 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 97 → G91 · differentiel

Hydrocéphalie à pression normale · Hydrocéphalie

La source relie troubles de marche, mémoire et continence à l’hydrocéphalie à pression normale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-66ff56749e62f60fd09b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/61
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	hydro · Normaldruckhydrocephalus; symptômes adultes https://www.usz.ch/krankheit/hydrocephalus/
Source / section	icd · ClaML: G91.2; catégorie G91 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 97 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 97 → I63 · differentiel

Infarctus du tronc cérébral ou du cervelet · Infarctus cérébral

L’infarctus central est nommé parmi les diagnostics du syndrome vestibulaire aigu.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1af3907b3f8c63d796bd docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/24
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p57–58 Schwindel https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: I63; catégorie I63 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 97 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 97 → R26 · contexte

Trouble de marche · Anomalies de la démarche et de la motilité

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9a313fdb6df694485771 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/115
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	profiles · SSP 97 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R26; catégorie R26 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 97 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 98 → G10 · differentiel

Maladie de Huntington · Chorée de Huntington

La maladie est décrite comme associant troubles moteurs, cognitifs et comportementaux; absence d’étoile ne justifie pas son exclusion.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-eb2484ebc2deeab0b800 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/51
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	huntington · Présentation; Was ist die Huntington-Krankheit? https://www.usz.ch/krankheit/huntington-krankheit/
Source / section	icd · ClaML: G10; catégorie G10 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 98 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n'est fournie.

SSP 98 → G20 · diagnostic

Maladie de Parkinson · Maladie de Parkinson

Bradykinésie, tremblement, instabilité et perturbation de marche sont décrits.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-365635e47a965f38453e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/43
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	park · Parkinson: Symptome https://www.usz.ch/krankheit/parkinson/
Source / section	icd · ClaML: G20; catégorie G20 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 98 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n'est fournie.

SSP 98 → G21 · differentiel

Syndrome parkinsonien secondaire · Syndrome parkinsonien secondaire

Une cause médicamenteuse, toxique ou autre est explicitement distinguée du Parkinson idiopathique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f3f7535adfcf33af1dce docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/46
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	park · Parkinson: Ursachen und Risikofaktoren / symptomatisch https://www.usz.ch/krankheit/parkinson/
Source / section	icd · ClaML: G21; catégorie G21 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 98 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 98 → G23 · differentiel

Parkinsonisme atypique: PSP ou atrophie multisystématisée · Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux

Des troubles de marche/chutes précoces et dysautonomie conduisent à distinguer les formes atypiques.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-42ebea0e4dca042ad7b4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/47
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	parkin · Atypische Parkinsonsyndrome https://www.parkinson.ch/themen/atypische-parkinsonsyndrome
Source / section	icd · ClaML: G23.1, G23.2, G23.3; catégorie G23 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 98 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 98 → G24 · diagnostic

Dystonie · Dystonie

La dystonie constitue un trouble moteur identifié; la catégorie mère ne transforme pas chaque dystonie en leçon distincte.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-42019b43427e01d9f10c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/50
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p44 Akute Hyperkinesien / Status dystonicus https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G24; catégorie G24 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 98 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 98 → R25 · contexte

Mouvement involontaire · Mouvements involontaires anormaux

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0b3f294ebb87d750d23d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/114
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	profiles · SSP 98 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R25; catégorie R25 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 98 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 98 → R27 · contexte

Trouble de coordination · Autres troubles de la coordination

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-684acffe98d41350af0f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/116
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	profiles · SSP 98 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R27; catégorie R27 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 98 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 99 → G12 · differentiel

Sclérose latérale amyotrophique / maladie du motoneurone · Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

La faiblesse progressive et les troubles bulbaires sont décrits; SLA est explicitement incluse en G12.2 dans le ClaML.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fe5ba338c991b49a5ff2 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/66
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	als · ALS-Diagnose; Sprech-, Schluck- und Atemfunktion https://www.usz.ch/krankheit/amyotrophe-lateralsklerose/
Source / section	icd · ClaML: G12.2; catégorie G12 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 99 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 99 → G43 · differentiel

Migraine avec aura · Migraine

Les phénomènes visuels, sensitifs, du langage et parfois moteurs de l’aura imposent une distinction avec un événement aigu.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3ad385c84ab4b5f7b77c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/2
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p41 Migräne mit Aura https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G43.1; catégorie G43 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 99 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 99 → G45 · differentiel

Accident ischémique transitoire · Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

La régression des déficits ne permet pas d’écarter un événement vasculaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1290ac8222b26c37d686 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/16
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	stroke · Vorboten / transitorische ischämische Attacken https://www.usz.ch/krankheit/schlaganfall/
Source / section	icd · ClaML: G45; catégorie G45 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 99 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 99 → G52 · differentiel

Atteinte des nerfs crâniens IX/X · Affections des autres nerfs crâniens

La source décrit dysphagie, dysarthrie et dysphonie dans les atteintes de ces nerfs.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8e925401e7d0e1fd3956 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/95
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p51 HN IX et X https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G52.1, G52.2; catégorie G52 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 99 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 99 → I61 · differentiel

Hémorragie intracérébrale · Hémorragie intracérébrale

Le déficit focal aigu peut provenir d’une hémorragie et requiert une distinction étiologique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e547775024cc0fd83139 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/20
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	chuv_stroke · Formes hémorragiques; Quels sont les symptômes? https://www.chuv.ch/fr/neurologie/nlg-home/patients-et-familles/maladies-traitees/accidents-vasculaires-cerebraux
Source / section	icd · ClaML: I61; catégorie I61 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 99 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 99 → I63 · diagnostic

Infarctus cérébral · Infarctus cérébral

Le déficit soudain moteur, sensitif ou du langage conduit à rechercher un AVC ischémique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-064ebb056ce1797ba7c9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/12
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	stroke · Symptome bei Schlaganfall; formes ischémiques https://www.usz.ch/krankheit/schlaganfall/

Trace	Détail
Source / section	icd · ClaML: I63; catégorie I63 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 99 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n'est fournie.

SSP 99 → R47 · contexte

Trouble du langage · Troubles du langage, non classés ailleurs

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-747d85fa28aa07438848 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/122
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	profiles · SSP 99 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R47; catégorie R47 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 99 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n'est fournie.

SSP 100 → G43 · differentiel

Migraine vestibulaire · Migraine

La migraine vestibulaire figure dans les diagnostics du vertige épisodique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4861a3333147b52bf031 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/5

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p57 et59 Vestibuläre Migräne https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G43; catégorie G43 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 100 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 100 → H81 · differentiel

Vertige positionnel bénin, vestibulopathie aiguë, maladie de Ménière · Atteintes des fonctions vestibulaires

Des causes vestibulaires périphériques doivent figurer face aux causes centrales.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e240a024c6910314c11b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/124
Propriétaire / statut	S12 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p57–59 Schwindel https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: H81.0, H81.1, H81.2; catégorie H81 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 100 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 100 → I63 · differentiel

Infarctus du tronc cérébral ou du cervelet · Infarctus cérébral

L’infarctus central est nommé parmi les diagnostics du syndrome vestibulaire aigu.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-93a1d48dd19b7d3cf5c7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/22
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p57–58 Schwindel https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: I63; catégorie I63 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 100 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 100 → R42 · contexte

Vertige/étourdissement · Étourdissements et éblouissements

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2dbeb452adcb045088b2 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/121
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	profiles · SSP 100 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R42; catégorie R42 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 100 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 101 → C70 · differentiel

Tumeur méningée maligne · Tumeur maligne des méninges

Les formes malignes méningées sont décrites; comportement malin documenté requis, aucune attribution automatique par grade.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-05109d38180c3937c205 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/103
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	meningioma · Was ist ein Meningeom? formes bösartig; symptômes https://www.usz.ch/krankheit/meningeom/
Source / section	icd · ClaML: C70.0; catégorie C70 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 101 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 101 → C71 · differentiel

Tumeur primitive maligne de l’encéphale · Tumeur maligne de l’encéphale

Les symptômes peuvent révéler un processus tumoral; localisation et comportement doivent être établis avant C71.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-55aa1efefe9d8611f675 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/106
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	tumor · Types primitifs et malins; Symptome bei Hirntumor https://www.usz.ch/krankheit/hirntumore-hirnmetastasen/
Source / section	icd · ClaML: C71; catégorie C71 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 101 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 101 → D32 · differentiel

Méningiome bénin · Tumeur bénigne des méninges

La source décrit méningiome habituellement bénin et céphalées/crises/déficits; le comportement bénin conditionne D32.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-75f744e4ed73713dd76e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/99
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	meningioma · Symptome: Von Kopfschmerzen bis Krämpfen und Lähmungen https://www.usz.ch/krankheit/meningeom/
Source / section	icd · ClaML: D32.0; catégorie D32 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 101 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 101 → G00 · diagnostic

Méningite bactérienne sans classement étiologique ailleurs · Méningite bactérienne, non classée ailleurs

Fièvre, céphalée et raideur méningée motivent la recherche d’une méningite bactérienne.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8c7972dfb98400fa2a67 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/27
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	mening · Bacterial meningitis; Symptoms of meningitis https://www.usz.ch/en/disease/meningitis-inflammation-of-the-meninges/
Source / section	icd · ClaML: G00; catégorie G00 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 101 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 101 → G43 · diagnostic

Migraine · Migraine

La migraine figure parmi les causes primaires de céphalée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b0915b506a6e577368b5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/0
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p41 Migräne https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G43; catégorie G43 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 101 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 101 → G44 · diagnostic

Céphalée de tension et algie vasculaire de la face · Autres syndromes d’algies céphaliques

Deux familles de céphalées primaires sont nommées; elles partagent une catégorie mère.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ba5f973245537a63df16 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/6
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p41 Spannungskopfschmerz; p42 Clusterkopfschmerz https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G44.0, G44.2; catégorie G44 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 101 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 101 → G93 · differentiel

Hypertension intracrânienne idiopathique · Autres affections du cerveau

Les troubles de pression du LCR figurent dans la démarche des céphalées après exclusion d’autres causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8df72cec3ab7920929b5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/96
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	pocket · p43 Idiopathische intrakranielle Hypertension https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G93.2; catégorie G93 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 101 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n'est fournie.

SSP 101 → G96 · differentiel

Fuite de LCR / syndrome de pression basse avec fuite démontrée · Autres affections de système nerveux central

Une fuite démontrée constitue une cause spécifique; ne pas assimiler toutes les céphalées positionnelles à G96.0.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ba959e5f92113a791cb3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/98
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p43 Liquorunterdrucksyndrom https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G96.0; catégorie G96 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 101 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n'est fournie.

SSP 101 → I67 · differentiel

Thrombose veineuse cérébrale non pyogène sans infarctus · Autres maladies cérébrovasculaires

La source distingue la thrombose veineuse des occlusions artérielles; le sous-code retenu exclut l’infarctus constitué.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4db178539a9edb39f525 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/25
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	chuv_stroke · Thrombose sino-veineuse cérébrale; symptômes https://www.chuv.ch/fr/neurologie/nlg-home/patients-et-familles/maladies-traitees/accidents-vasculaires-cerebraux
Source / section	icd · ClaML: I67.6; catégorie I67 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 101 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → C71 · differentiel

Tumeur primitive maligne de l’encéphale · Tumeur maligne de l’encéphale

Les symptômes peuvent révéler un processus tumoral; localisation et comportement doivent être établis avant C71.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-421affc47ee0692987f5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/110
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	tumor · Types primitifs et malins; Symptome bei Hirntumor https://www.usz.ch/krankheit/hirntumore-hirnmetastasen/
Source / section	icd · ClaML: C71; catégorie C71 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → E03 · differentiel

Hypothyroïdie avec troubles cognitifs · Autres hypothyroïdies

La cause endocrinienne de troubles cognitifs apparaît dans la démarche neurologique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-74c6151040050a0536b1 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/137
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p35 Schilddrüsendysfunktion https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E03; catégorie E03 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → F01 · differentiel

Démence vasculaire · Démence vasculaire

L’origine vasculaire est distinguée des démences dégénératives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2b99a830a62c5179e699 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/129
Propriétaire / statut	S09 · lien_editorial_documente
Source / section	dementia_pdf · p1 vaskuläre Demenz https://www.medix.ch/media/medix_dossier_demenz_okt.24.pdf

Trace	Détail
Source / section	icd · ClaML: F01; catégorie F01 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → F32 · differentiel

Trouble dépressif avec plaintes cognitives · Episodes dépressifs

Une dépression peut simuler ou accompagner un déclin cognitif.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-bc6c49fd51c44693076a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/127
Propriétaire / statut	S09 · lien_editorial_documente
Source / section	dementia_pdf · p3 Depression kann demenzähnliche Symptome auslösen https://www.medix.ch/media/medix_dossier_demenz_okt.24.pdf
Source / section	icd · ClaML: F32; catégorie F32 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → G10 · differentiel

Maladie de Huntington · Chorée de Huntington

La maladie est décrite comme associant troubles moteurs, cognitifs et comportementaux; absence d’étoile ne justifie pas son exclusion.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b096622251f202dbc464 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/52

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	huntington · Présentation; Was ist die Huntington-Krankheit? https://www.usz.ch/krankheit/huntington-krankheit/
Source / section	icd · ClaML: G10; catégorie G10 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → G30 · diagnostic

Maladie d’Alzheimer · Maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est distinguée des autres causes de déclin cognitif.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1f37c990883826c7be3e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/54
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	dementia_pdf · p1 Alzheimer-Krankheit https://www.medix.ch/media/medix_dossier_demenz_okt.24.pdf
Source / section	icd · ClaML: G30; catégorie G30 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → G31 · differentiel

Démence frontotemporale ou à corps de Lewy · Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs

Ces maladies sont nommées séparément; les sous-codes se regroupent sous G31 avec leur preuve propre.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e0b6a36b066a75f74910 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/56
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	dementia_pdf · p3 autres formes de démence https://www.medix.ch/media/medix_dossier_demenz_okt.24.pdf
Source / section	icd · ClaML: G31.0, G31.82; catégorie G31 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → G45 · diagnostic

Amnésie globale transitoire · Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

La source distingue l’amnésie globale transitoire de causes épileptiques, inflammatoires et ischémiques.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-dcddb39dba46859cf977 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/17
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p38 Amnesie / TGA https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G45.4; catégorie G45 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master

Trace	Détail
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → G91 · differentiel

Hydrocéphalie à pression normale · Hydrocéphalie

La source relie troubles de marche, mémoire et continence à l’hydrocéphalie à pression normale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-279c93967dd984f7aa32 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/59
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	hydro · Normaldruckhydrocephalus; symptômes adultes https://www.usz.ch/krankheit/hydrocephalus/
Source / section	icd · ClaML: G91.2; catégorie G91 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 102 → R41 · contexte

Trouble cognitif/mnésique · Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5235b1c99dd5e6e0c3a8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/119

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R41; catégorie R41 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 102 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → C70 · differentiel

Tumeur méningée maligne · Tumeur maligne des méninges

Les formes malignes méningées sont décrites; comportement malin documenté requis, aucune attribution automatique par grade.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cf00653348fe50565396 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/105
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	meningioma · Was ist ein Meningeom? formes bösartig; symptômes https://www.usz.ch/krankheit/meningeom/
Source / section	icd · ClaML: C70.0; catégorie C70 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → C71 · differentiel

Tumeur primitive maligne de l’encéphale · Tumeur maligne de l’encéphale

Les symptômes peuvent révéler un processus tumoral; localisation et comportement doivent être établis avant C71.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2343e8c1199b12d3fb68 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/108
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	tumor · Types primitifs et malins; Symptome bei Hirntumor https://www.usz.ch/krankheit/hirntumore-hirnmetastasen/
Source / section	icd · ClaML: C71; catégorie C71 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → D32 · differentiel

Méningiome bénin · Tumeur bénigne des méninges

La source décrit méningiome habituellement bénin et céphalées/crises/déficits; le comportement bénin conditionne D32.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6d5c6a749ef77182a73f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/101
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	meningioma · Symptome: Von Kopfschmerzen bis Krämpfen und Lähmungen https://www.usz.ch/krankheit/meningeom/
Source / section	icd · ClaML: D32.0; catégorie D32 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → E53 · differentiel

Carence en vitamine B12 sans anémie nécessaire · Autres avitaminoses du groupe B

Myéloneuropathie et troubles de sensibilité/marche peuvent exister sans anémie; D51 ne doit pas être attribué automatiquement.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-76468a0a1e5e75624745 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/140
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p35 B12 Mangel https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E53.8; catégorie E53 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G12 · differentiel

Amyotrophie spinale · Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

L’amyotrophie spinale est nommée parmi les maladies donnant faiblesse/paralysie, avec bilan spécialisé.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2f96b5435d5091c90c9d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/67
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	nmz · Beispiele vererbbarer neuromuskulärer Krankheiten; symptômes https://neurologie.insel.ch/de/unser-angebot/neuromuskulaeres-zentrum/fragen-und-antworten
Source / section	icd · ClaML: G12; catégorie G12 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G12 · differentiel

Sclérose latérale amyotrophique / maladie du motoneurone · Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

La faiblesse progressive et les troubles bulbaires sont décrits; SLA est explicitement incluse en G12.2 dans le ClaML.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e64ad3a114507f3ae156 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/64
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	als · ALS-Diagnose; Sprech-, Schluck- und Atemfunktion https://www.usz.ch/krankheit/amyotrophe-lateralsklerose/
Source / section	icd · ClaML: G12.2; catégorie G12 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G35 · differentiel

Sclérose en plaques · Sclérose en plaques

Les manifestations motrices, sensitives et visuelles sont décrites; les diagnostics alternatifs doivent être écartés.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-07c5951ce280eb63419d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/33
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	ms · Définition et symptômes; Diagnose Multiple Sklerose https://www.usz.ch/krankheit/multiple-sklerose/
Source / section	icd · ClaML: G35; catégorie G35 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G36 · differentiel

Neuromyélite optique / NMOSD · Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées

NMOSD figure parmi les causes neuro-immunes de myélite; une catégorie mère inclut Devic.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c02fc7987ff947139037 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/35
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p17 myélite aiguë, p18 AQP4 https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G36.0; catégorie G36 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G45 · differentiel

Accident ischémique transitoire · Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

La régression des déficits ne permet pas d’écarter un événement vasculaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e59e4adf343cf82291b9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/15
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	stroke · Vorboten / transitorische ischämische Attacken https://www.usz.ch/krankheit/schlaganfall/
Source / section	icd · ClaML: G45; catégorie G45 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G51 · diagnostic

Paralysie faciale périphérique · Affections du nerf facial [nerf crânien VII]

La paralysie faciale périphérique est distinguée des lésions centrales et des causes infectieuses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-7b74a0d60216e8e72c21 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/92
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p50 HN VII Fazialisparese https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf

Trace	Détail
Source / section	icd · ClaML: G51.0; catégorie G51 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G54 · differentiel

Atteinte radiculaire non classée ailleurs · Affections des racines et des plexus nerveux

Une topographie radiculaire est décrite; G54 reste conditionné à l’absence d’étiologie classée ailleurs.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a7bb0f26fb2e46bf8b74 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/87
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p65 Radikuläre Syndrome; p64 distinction radiculaire/nerf https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G54.2, G54.4; catégorie G54 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G56 · diagnostic

Syndrome du canal carpien / atteinte ulnaire ou radiale · Mononévrite du membre supérieur

Les distributions sensitives et motrices sont distinguées par nerf, sous une catégorie mère.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2eac5b90f34a76d8c697 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/83

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p64 Periphere Nervenläsionen https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G56.0, G56.2, G56.3; catégorie G56 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G57 · differentiel

Neuropathie fibulaire compressive · Mononévrite du membre inférieur

La chute du pied et la topographie sensitive imposent une distinction avec une atteinte radiculaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e0a617c53182a0e18c74 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/84
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p64 Peronaeusdruckläsion https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G57.3; catégorie G57 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G61 · differentiel

Guillain-Barré et CIDP · Polynévrites inflammatoires

Les formes aiguës et chroniques inflammatoires sont nommées et décrites, avec faiblesse et troubles sensitifs.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-644ff5ca4266de925d11 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/71
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pnp · Immunvermittelte Polyneuropathie https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/
Source / section	icd · ClaML: G61.0, G61.8; catégorie G61 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G70 · differentiel

Myasthénie · Myasthénie et autres affections neuromusculaires

Une présentation oculaire, bulbaire ou généralisée doit être distinguée des autres causes neuromusculaires.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f2928eb339c895fc99dc docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/68
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p67 Myasthenia gravis; p68 crise https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G70.0; catégorie G70 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → G71 · differentiel

Dystrophie musculaire · Affections musculaires primitives

Les dystrophies sont nommées dans le bilan d’une faiblesse musculaire; toutes les myopathies ne sont pas G71.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6436917fc5caad62edbc docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/89
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	nmz · Beispiele vererbbarer neuromuskulärer Krankheiten; symptômes https://neurologie.insel.ch/de/unser-angebot/neuromuskulaeres-zentrum/fragen-und-antworten
Source / section	icd · ClaML: G71.0; catégorie G71 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 103 → I61 · differentiel

Hémorragie intracérébrale · Hémorragie intracérébrale

Le déficit focal aigu peut provenir d’une hémorragie et requiert une distinction étiologique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-65375f9cb7fd314124b9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/19
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	chuv_stroke · Formes hémorragiques; Quels sont les symptômes? https://www.chuv.ch/fr/neurologie/nlg-home/patients-et-familles/maladies-traitees/accidents-vasculaires-cerebraux
Source / section	icd · ClaML: I61; catégorie I61 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n'est fournie.

SSP 103 → I63 · diagnostic

Infarctus cérébral · Infarctus cérébral

Le déficit soudain moteur, sensitif ou du langage conduit à rechercher un AVC ischémique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-abe624977d3534820584 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/11
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	stroke · Symptome bei Schlaganfall; formes ischémiques https://www.usz.ch/krankheit/schlaganfall/
Source / section	icd · ClaML: I63; catégorie I63 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n'est fournie.

SSP 103 → R29 · contexte

Signe moteur à préciser · Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fc1f637d07dd89ef5853 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/117
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R29; catégorie R29 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 103 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → C71 · differentiel

Tumeur primitive maligne de l’encéphale · Tumeur maligne de l’encéphale

Les symptômes peuvent révéler un processus tumoral; localisation et comportement doivent être établis avant C71.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-83276068072cafe062fc docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/109
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	tumor · Types primitifs et malins; Symptome bei Hirntumor https://www.usz.ch/krankheit/hirntumore-hirnmetastasen/
Source / section	icd · ClaML: C71; catégorie C71 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → D32 · differentiel

Méningiome bénin · Tumeur bénigne des méninges

La source décrit méningiome habituellement bénin et céphalées/crises/déficits; le comportement bénin conditionne D32.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-436b36a00b3048483dfe docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/102
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	meningioma · Symptome: Von Kopfschmerzen bis Krämpfen und Lähmungen https://www.usz.ch/krankheit/meningeom/
Source / section	icd · ClaML: D32.0; catégorie D32 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → E53 · differentiel

Carence en vitamine B12 sans anémie nécessaire · Autres avitaminoses du groupe B

Myéloneuropathie et troubles de sensibilité/marche peuvent exister sans anémie; D51 ne doit pas être attribué automatiquement.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-41b6eb853f06afa41530 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/139
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p35 B12 Mangel https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E53.8; catégorie E53 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G35 · differentiel

Sclérose en plaques · Sclérose en plaques

Les manifestations motrices, sensitives et visuelles sont décrites; les diagnostics alternatifs doivent être écartés.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-efd55dc5b634040c768f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/34
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	ms · Définition et symptômes; Diagnose Multiple Sklerose https://www.usz.ch/krankheit/multiple-sklerose/
Source / section	icd · ClaML: G35; catégorie G35 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G36 · differentiel

Neuromyélite optique / NMOSD · Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées

NMOSD figure parmi les causes neuro-immunes de myélite; une catégorie mère inclut Devic.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9a273e93ccf865354556 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/36
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p17 myélite aiguë, p18 AQP4 https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf

Trace	Détail
Source / section	icd · ClaML: G36.0; catégorie G36 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G43 · differentiel

Migraine avec aura · Migraine

Les phénomènes visuels, sensitifs, du langage et parfois moteurs de l’aura imposent une distinction avec un événement aigu.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6172ff765147ced536b7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/3
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p41 Migräne mit Aura https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G43.1; catégorie G43 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G54 · differentiel

Atteinte radiculaire non classée ailleurs · Affections des racines et des plexus nerveux

Une topographie radiculaire est décrite; G54 reste conditionné à l’absence d’étiologie classée ailleurs.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c031509748cb2ea25b4d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/88
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p65 Radikuläre Syndrome; p64 distinction radiculaire/nerf https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G54.2, G54.4; catégorie G54 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G56 · diagnostic

Syndrome du canal carpien / atteinte ulnaire ou radiale · Mononévrite du membre supérieur

Les distributions sensitives et motrices sont distinguées par nerf, sous une catégorie mère.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ceb514ca37231ab7d657 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/82
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p64 Periphere Nervenläsionen https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G56.0, G56.2, G56.3; catégorie G56 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G57 · differentiel

Neuropathie fibulaire compressive · Mononévrite du membre inférieur

La chute du pied et la topographie sensitive imposent une distinction avec une atteinte radiculaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a1a27e29b973fa61478f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/85
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p64 Peronaeusdruckläsion https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G57.3; catégorie G57 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G60 · differentiel

Neuropathie héréditaire / Charcot-Marie-Tooth · Neuropathie héréditaire et idiopathique

Une cause héréditaire est explicitement distinguée des causes diabétiques et toxiques.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ca8ab7523a7335568dbc docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/78
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pnp · Ursachen: formes héréditaires https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/
Source / section	icd · ClaML: G60.0; catégorie G60 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G61 · differentiel

Guillain-Barré et CIDP · Polynévrites inflammatoires

Les formes aiguës et chroniques inflammatoires sont nommées et décrites, avec faiblesse et troubles sensitifs.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-50546ffc6bb18e79fb2d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/72
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pnp · Immunvermittelte Polyneuropathie https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/
Source / section	icd · ClaML: G61.0, G61.8; catégorie G61 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G62 · diagnostic

Polyneuropathie toxique / alcoolique · Autres polynévrites

La source décrit troubles sensitifs distaux, douleurs et atteinte de marche; alcool/toxiques forment des causes identifiées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d6997977066b5ea26529 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/75
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	pnp · Toxische Polyneuropathie; symptômes https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/
Source / section	icd · ClaML: G62.1, G62.2; catégorie G62 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → G63 · contexte

Manifestation de polyneuropathie diabétique · Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs

Code de manifestation astérisque: à relier à l’étiologie diabétique, sans produire une maladie indépendante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-765bc82a8efe921f4ad2 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/80
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pnp · Diabetische Polyneuropathie https://www.usz.ch/krankheit/polyneuropathie/
Source / section	icd · ClaML: G63.2; catégorie G63 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → I61 · differentiel

Hémorragie intracérébrale · Hémorragie intracérébrale

Le déficit focal aigu peut provenir d’une hémorragie et requiert une distinction étiologique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fdb584d7c89ccf53cd0a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/21
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	chuv_stroke · Formes hémorragiques; Quels sont les symptômes? https://www.chuv.ch/fr/neurologie/nlg-home/patients-et-familles/maladies-traitees/accidents-vasculaires-cerebraux
Source / section	icd · ClaML: I61; catégorie I61 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 104 → I63 · diagnostic

Infarctus cérébral · Infarctus cérébral

Le déficit soudain moteur, sensitif ou du langage conduit à rechercher un AVC ischémique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-dfa6e1a6eb8d374f122d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/13
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	stroke · Symptome bei Schlaganfall; formes ischémiques https://www.usz.ch/krankheit/schlaganfall/
Source / section	icd · ClaML: I63; catégorie I63 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 104 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 105 → C70 · differentiel

Tumeur méningée maligne · Tumeur maligne des méninges

Les formes malignes méningées sont décrites; comportement malin documenté requis, aucune attribution automatique par grade.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c12c00a3ffdd38385a09 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/104
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	meningioma · Was ist ein Meningeom? formes bösartig; symptômes https://www.usz.ch/krankheit/meningeom/
Source / section	icd · ClaML: C70.0; catégorie C70 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 105 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 105 → C71 · differentiel

Tumeur primitive maligne de l’encéphale · Tumeur maligne de l’encéphale

Les symptômes peuvent révéler un processus tumoral; localisation et comportement doivent être établis avant C71.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-620de0f92b637af437de docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/107
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	tumor · Types primitifs et malins; Symptome bei Hirntumor https://www.usz.ch/krankheit/hirntumore-hirnmetastasen/
Source / section	icd · ClaML: C71; catégorie C71 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 105 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 105 → D32 · differentiel

Méningiome bénin · Tumeur bénigne des méninges

La source décrit méningiome habituellement bénin et céphalées/crises/déficits; le comportement bénin conditionne D32.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-edccf4d2d96687dca607 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/100
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	meningioma · Symptome: Von Kopfschmerzen bis Krämpfen und Lähmungen https://www.usz.ch/krankheit/meningeom/
Source / section	icd · ClaML: D32.0; catégorie D32 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 105 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 105 → E16 · differentiel

Hypoglycémie / crise aiguë provoquée · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Une crise aiguë provoquée par hypoglycémie doit rester distincte d’une épilepsie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-7faf5f19caf8a0f801df docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/131
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p4 Epilepsie: sichere Provokationsfaktoren https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E16.2; catégorie E16 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 105 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 105 → E87 · differentiel

Trouble électrolytique provoquant une crise · Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

Un trouble électrolytique peut provoquer une crise aiguë.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-99d9e935b086abe9da45 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/134
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p4 Epilepsie: sichere Provokationsfaktoren https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E87; catégorie E87 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 105 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 105 → G40 · diagnostic

Épilepsie · Épilepsie

Les crises récurrentes non provoquées relèvent d’un bilan d’épilepsie; une crise isolée n’équivaut pas automatiquement à cette maladie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c003073d4135a2db61c4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/37
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	epi · Was ist Epilepsie; Anfallsformen https://www.usz.ch/krankheit/epilepsie/
Source / section	icd · ClaML: G40; catégorie G40 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 105 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 112 → S06 · diagnostic

Traumatisme crânio-cérébral · Lésion traumatique intracrânienne

Un traumatisme avec confusion ou coma ne doit pas être assimilé à une atteinte neurologique spontanée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ed428bf4240884896020 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/111
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	tcc · Qu’est-ce qu’un TCC? Quels sont les symptômes? https://www.chuv.ch/fr/neurochirurgie/nch-home/patients-et-familles/maladies-traitees/le-traumatisme-cranio-cerebral/
Source / section	icd · ClaML: S06; catégorie S06 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 112 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 120 → G10 · differentiel

Maladie de Huntington · Chorée de Huntington

La maladie est décrite comme associant troubles moteurs, cognitifs et comportementaux; absence d’étoile ne justifie pas son exclusion.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a5663d0adae8b708d0a9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/53
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	huntington · Présentation; Was ist die Huntington-Krankheit? https://www.usz.ch/krankheit/huntington-krankheit/
Source / section	icd · ClaML: G10; catégorie G10 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 120 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 120 → G31 · differentiel

Démence frontotemporale ou à corps de Lewy · Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs

Ces maladies sont nommées séparément; les sous-codes se regroupent sous G31 avec leur preuve propre.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-30468c933f3f314ce817 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/58
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	dementia_pdf · p3 autres formes de démence https://www.medix.ch/media/medix_dossier_demenz_okt.24.pdf
Source / section	icd · ClaML: G31.0, G31.82; catégorie G31 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 120 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 126 → F05 · diagnostic

Delirium · Delirium, non induit par l’alcool et d’autres substances psycho-actives

Le syndrome confusionnel aigu impose une recherche causale et une distinction avec un déclin chronique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3f64ff12a81564fbd9df docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/125
Propriétaire / statut	S09 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p39 Delir https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: F05; catégorie F05 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 126 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 126 → G04 · differentiel

Encéphalite auto-immune · Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

Les troubles mnésiques/comportementaux subaigus, crises et altération de conscience forment une présentation d’encéphalite; causes infectieuses à distinguer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e94f25ec9ce110969d2c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/29
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p19 Autoimmune Enzephalitis, Diagnosekriterien https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G04; catégorie G04 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 126 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 126 → R41 · contexte

Confusion à expliquer · Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6d7a00036c8471ed29df docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/120
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	profiles · SSP 126 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R41; catégorie R41 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 126 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 139 → E03 · differentiel

Hypothyroïdie avec troubles cognitifs · Autres hypothyroïdies

La cause endocrinienne de troubles cognitifs apparaît dans la démarche neurologique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e926acfeade1230a19c1 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/138
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p35 Schilddrüsendysfunktion https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E03; catégorie E03 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 139 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 139 → F01 · differentiel

Démence vasculaire · Démence vasculaire

L’origine vasculaire est distinguée des démences dégénératives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8b53c3f569855d0abe5d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/130
Propriétaire / statut	S09 · lien_editorial_documente
Source / section	dementia_pdf · p1 vaskuläre Demenz https://www.medix.ch/media/medix_dossier_demenz_okt.24.pdf
Source / section	icd · ClaML: F01; catégorie F01 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 139 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 139 → F32 · differentiel

Trouble dépressif avec plaintes cognitives · Episodes dépressifs

Une dépression peut simuler ou accompagner un déclin cognitif.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a6ddfec76472deb20949 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/128
Propriétaire / statut	S09 · lien_editorial_documente
Source / section	dementia_pdf · p3 Depression kann demenzähnliche Symptome auslösen https://www.medix.ch/media/medix_dossier_demenz_okt.24.pdf
Source / section	icd · ClaML: F32; catégorie F32 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 139 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 139 → G30 · diagnostic

Maladie d’Alzheimer · Maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est distinguée des autres causes de déclin cognitif.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d7e6fb5746130be1a9af docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/55
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	dementia_pdf · p1 Alzheimer-Krankheit https://www.medix.ch/media/medix_dossier_demenz_okt.24.pdf
Source / section	icd · ClaML: G30; catégorie G30 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 139 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 139 → G31 · differentiel

Démence frontotemporale ou à corps de Lewy · Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs

Ces maladies sont nommées séparément; les sous-codes se regroupent sous G31 avec leur preuve propre.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c9482fb109f71485e1c4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/57
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	dementia_pdf · p3 autres formes de démence https://www.medix.ch/media/medix_dossier_demenz_okt.24.pdf
Source / section	icd · ClaML: G31.0, G31.82; catégorie G31 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 139 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 139 → G91 · differentiel

Hydrocéphalie à pression normale · Hydrocéphalie

La source relie troubles de marche, mémoire et continence à l’hydrocéphalie à pression normale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-83c2e6a4a13785574b25 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/60
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	hydro · Normaldruckhydrocephalus; symptômes adultes https://www.usz.ch/krankheit/hydrocephalus/
Source / section	icd · ClaML: G91.2; catégorie G91 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 139 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 145 → E16 · differentiel

Hypoglycémie / crise aiguë provoquée · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Une crise aiguë provoquée par hypoglycémie doit rester distincte d’une épilepsie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4d7b15f9bfa661c723a4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/133
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p4 Epilepsie: sichere Provokationsfaktoren https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf

Trace	Détail
Source / section	icd · ClaML: E16.2; catégorie E16 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 145 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 145 → E51 · differentiel

Encéphalopathie de Wernicke · Carence en thiamine [carence en vitamine B1]

La source associe trouble de conscience, oculomotricité et ataxie à une carence en thiamine.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-550f38216b2dfb322cb8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/142
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p35 B1 Mangel https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E51.2; catégorie E51 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 145 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 145 → E87 · differentiel

Trouble électrolytique provoquant une crise · Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

Un trouble électrolytique peut provoquer une crise aiguë.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b5dc96f036f6f81886f3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/136

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p4 Epilepsie: sichere Provokationsfaktoren https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E87; catégorie E87 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 145 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 145 → G40 · differentiel

Crise épileptique avec altération de conscience · Épilepsie

La perte de conscience transitoire comprend des formes épileptiques, syncopales et fonctionnelles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8dfbfda89874f2d56369 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/39
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p12 Transiente Bewusstseinsstörung https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G40; catégorie G40 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 145 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 145 → G41 · differentiel

État de mal épileptique · État de mal épileptique

Un épisode prolongé est distingué des crises brèves.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8535f3e0a9ed1f7eaf4c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/42
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	epi · Wie läuft ein epileptischer Anfall ab? / Status epilepticus https://www.usz.ch/krankheit/epilepsie/
Source / section	icd · ClaML: G41; catégorie G41 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 145 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 145 → R40 · contexte

Trouble quantitatif de conscience · Somnolence, stupeur et coma

Correspondance de présentation et code de symptôme; rechercher la cause avec les liens diagnostiques, sans compter une maladie supplémentaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-427d7e1ead7175ee3d1f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/118
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	profiles · SSP 145 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Source / section	icd · ClaML: R40; catégorie R40 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 145 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 145 → S06 · diagnostic

Traumatisme crânio-cérébral · Lésion traumatique intracrânienne

Un traumatisme avec confusion ou coma ne doit pas être assimilé à une atteinte neurologique spontanée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2679c98a6af70b3ea765 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/112
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	tcc · Qu’est-ce qu’un TCC? Quels sont les symptômes? https://www.chuv.ch/fr/neurochirurgie/nch-home/patients-et-familles/maladies-traitees/le-traumatisme-cranio-cerebral/
Source / section	icd · ClaML: S06; catégorie S06 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 145 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 149 → R55 · differentiel

Syncope · Syncope et collapsus

Le syndrome syncopal se distingue des pertes de conscience épileptiques; code de symptôme.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c840b1179dff6aa20fda docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/145
Propriétaire / statut	T6 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	pocket · p12–13 TLOC https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: R55; catégorie R55 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 149 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 202 → G91 · differentiel

Hydrocéphalie à pression normale · Hydrocéphalie

La source relie troubles de marche, mémoire et continence à l’hydrocéphalie à pression normale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-754cc7fd321c2f6343af docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/62
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	hydro · Normaldruckhydrocephalus; symptômes adultes https://www.usz.ch/krankheit/hydrocephalus/
Source / section	icd · ClaML: G91.2; catégorie G91 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 202 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 205 → G35 · differentiel

Sclérose en plaques · Sclérose en plaques

Les manifestations motrices, sensitives et visuelles sont décrites; les diagnostics alternatifs doivent être écartés.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-64c78c6c82c6b6abad52 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/32
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	ms · Définition et symptômes; Diagnose Multiple Sklerose https://www.usz.ch/krankheit/multiple-sklerose/
Source / section	icd · ClaML: G35; catégorie G35 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 205 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 205 → G43 · differentiel

Migraine avec aura · Migraine

Les phénomènes visuels, sensitifs, du langage et parfois moteurs de l’aura imposent une distinction avec un événement aigu.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-aab0650ac6c1cff2b7bd docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/4
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p41 Migräne mit Aura https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G43.1; catégorie G43 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 205 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 205 → G45 · differentiel

Accident ischémique transitoire · Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

La régression des déficits ne permet pas d’écarter un événement vasculaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ef6380fd82c707c8eff7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/14
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	stroke · Vorboten / transitorische ischämische Attacken https://www.usz.ch/krankheit/schlaganfall/
Source / section	icd · ClaML: G45; catégorie G45 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 205 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 205 → I60 · differentiel

Hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique · Hémorragie sous-arachnoïdienne

La source décrit le saignement sous-arachnoïdien spontané parmi les causes vasculaires et les céphalées aiguës inhabituelles parmi leurs présentations.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1bf3658e16eead6a35ee docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/9
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	chuv_stroke · Types d’AVC; Quels sont les symptômes? https://www.chuv.ch/fr/neurologie/nlg-home/patients-et-familles/maladies-traitees/accidents-vasculaires-cerebraux
Source / section	icd · ClaML: I60; catégorie I60 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 205 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 205 → I61 · differentiel

Hémorragie intracérébrale · Hémorragie intracérébrale

Le déficit focal aigu peut provenir d’une hémorragie et requiert une distinction étiologique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-12856fd803bb5f5991be docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/18
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	chuv_stroke · Formes hémorragiques; Quels sont les symptômes? https://www.chuv.ch/fr/neurologie/nlg-home/patients-et-familles/maladies-traitees/accidents-vasculaires-cerebraux
Source / section	icd · ClaML: I61; catégorie I61 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 205 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 205 → I63 · diagnostic

Infarctus cérébral · Infarctus cérébral

Le déficit soudain moteur, sensitif ou du langage conduit à rechercher un AVC ischémique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0b960bb1fc1f29c55ca7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/10
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	stroke · Symptome bei Schlaganfall; formes ischémiques https://www.usz.ch/krankheit/schlaganfall/

Trace	Détail
Source / section	icd · ClaML: I63; catégorie I63 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 205 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 207 → G00 · diagnostic

Méningite bactérienne sans classement étiologique ailleurs · Méningite bactérienne, non classée ailleurs

Fièvre, céphalée et raideur méningée motivent la recherche d’une méningite bactérienne.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9b8fa060e369f8cf2a1e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/28
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	mening · Bacterial meningitis; Symptoms of meningitis https://www.usz.ch/en/disease/meningitis-inflammation-of-the-meninges/
Source / section	icd · ClaML: G00; catégorie G00 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 207 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 207 → I60 · differentiel

Hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique · Hémorragie sous-arachnoïdienne

La source décrit le saignement sous-arachnoïdien spontané parmi les causes vasculaires et les céphalées aiguës inhabituelles parmi leurs présentations.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-137dee14155aed860698 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/8
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	chuv_stroke · Types d’AVC; Quels sont les symptômes? https://www.chuv.ch/fr/neurologie/nlg-home/patients-et-familles/maladies-traitees/accidents-vasculaires-cerebraux
Source / section	icd · ClaML: I60; catégorie I60 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 207 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 216 → F05 · diagnostic

Delirium · Delirium, non induit par l’alcool et d’autres substances psycho-actives

Le syndrome confusionnel aigu impose une recherche causale et une distinction avec un déclin chronique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-093f8ba33bbe733d6a01 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/126
Propriétaire / statut	S09 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p39 Delir https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: F05; catégorie F05 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 216 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 216 → G04 · differentiel

Encéphalite auto-immune · Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

Les troubles mnésiques/comportementaux subaigus, crises et altération de conscience forment une présentation d’encéphalite; causes infectieuses à distinguer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0e73a1337f61419c697b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/30
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p19 Autoimmune Enzephalitis, Diagnosekriterien https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G04; catégorie G04 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 216 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 216 → S06 · diagnostic

Traumatisme crânio-cérébral · Lésion traumatique intracrânienne

Un traumatisme avec confusion ou coma ne doit pas être assimilé à une atteinte neurologique spontanée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-72c2634819b23171681c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/113
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	tcc · Qu’est-ce qu’un TCC? Quels sont les symptômes? https://www.chuv.ch/fr/neurochirurgie/nch-home/patients-et-familles/maladies-traitees/le-traumatisme-cranio-cerebral/
Source / section	icd · ClaML: S06; catégorie S06 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 216 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 217 → G40 · differentiel

Crise épileptique avec altération de conscience · Épilepsie

La perte de conscience transitoire comprend des formes épileptiques, syncopales et fonctionnelles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-446a630e57c653fd8bfb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/40
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p12 Transiente Bewusstseinsstörung https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G40; catégorie G40 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 217 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 217 → R55 · differentiel

Syncope · Syncope et collapsus

Le syndrome syncopal se distingue des pertes de conscience épileptiques; code de symptôme.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4dedd1b1b0445e433849 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/144
Propriétaire / statut	T6 · lien_editorial_documente

Trace	Détail
Source / section	pocket · p12–13 TLOC https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: R55; catégorie R55 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 217 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 219 → E16 · differentiel

Hypoglycémie / crise aiguë provoquée · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Une crise aiguë provoquée par hypoglycémie doit rester distincte d’une épilepsie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b1c958b46a0d37dd4a1b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/132
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p4 Epilepsie: sichere Provokationsfaktoren https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E16.2; catégorie E16 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 219 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 219 → E87 · differentiel

Trouble électrolytique provoquant une crise · Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

Un trouble électrolytique peut provoquer une crise aiguë.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-86dfdd6a5b70576afcb0 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/135
Propriétaire / statut	S05 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p4 Epilepsie: sichere Provokationsfaktoren https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: E87; catégorie E87 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 219 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 219 → G04 · differentiel

Encéphalite auto-immune · Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

Les troubles mnésiques/comportementaux subaigus, crises et altération de conscience forment une présentation d’encéphalite; causes infectieuses à distinguer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5e6d6e3abeaec19fde4a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/31
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	pocket · p19 Autoimmune Enzephalitis, Diagnosekriterien https://neurologie.insel.ch/fileadmin/Neurologie/Dokumente/Notfall/DE_Neuro_Pocket_2024_web_version.pdf
Source / section	icd · ClaML: G04; catégorie G04 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 219 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf

Trace	Détail
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 219 → G40 · diagnostic

Épilepsie · Épilepsie

Les crises récurrentes non provoquées relèvent d’un bilan d’épilepsie; une crise isolée n’équivaut pas automatiquement à cette maladie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-61adcb55f246af31d308 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/38
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	epi · Was ist Epilepsie; Anfallsformen https://www.usz.ch/krankheit/epilepsie/
Source / section	icd · ClaML: G40; catégorie G40 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 219 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

SSP 219 → G41 · differentiel

État de mal épileptique · État de mal épileptique

Un épisode prolongé est distingué des crises brèves.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2627e91169b338b486fb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S08.json/graph/41
Propriétaire / statut	S08 · lien_editorial_documente
Source / section	epi · Wie läuft ein epileptischer Anfall ab? / Status epilepticus https://www.usz.ch/krankheit/epilepsie/

Trace	Détail
Source / section	icd · ClaML: G41; catégorie G41 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32686264/master
Source / section	profiles · SSP 219 https://www.siwf.ch/files/pdf24/profiles_2017-broschuere.pdf
Limites	Diagnostic à envisager selon contexte clinique; ne constitue ni un diagnostic individuel ni une correspondance officielle PROFILES/CIM., Les SSP sont des situations de départ. Aucune liste officielle de maladies ou table SSP/CIM n’est fournie.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 20

Annexe : graphe probant — E-06 — Endocrinologie et métabolisme

157 arêtes issues de preuves-S05.json. Les arêtes de contexte/candidat restent explicitement séparées ; les renvois ne changent pas leur propriétaire.

SSP 1 → E05 · differentiel

Crise thyrotoxique · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Crise thyrotoxique : fièvre, sueurs/flush, signes digestifs, tachyarythmie, délire jusqu'au coma peuvent s'associer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-031f3255981eca771641 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/86
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.2.6 clinique https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E05 dans un ensemble clinique compatible, pas depuis un symptôme isolé., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 1 → E16 · diagnostic

Hypoglycémie hors coma non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L'enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f81d29cb260072ccb2e2 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/35
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie

Trace	Détail
Limites	Hypoglycémie documentée ; distinguer diabète, nouveau-né et cause hormonale/tumorale., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 3 → E10 · diagnostic

Diabète sucré, type 1 · Diabète sucré, type 1

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f4efccbf0e597e5623f1 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/10
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 3 → E11 · diagnostic

Diabète sucré, type 2 · Diabète sucré, type 2

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-237e705e2b6884c2102d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/14
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 3 → E13 · diagnostic

Autres diabètes sucrés précisés · Autres diabètes sucrés précisés

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b62475fcde21434dff77 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/18
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 3 → E21 · differentiel

Hyperparathyroïdie primaire · Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-57bb241ff2f8715b1c2e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/32
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 3 → E23 · differentiel

Déficit central en vasopressine · Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse

Devant polyurie-polydipsie : distinguer déficit central en vasopressine, résistance rénale et polydipsie primaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-78ce2bbd03d7c8c3c007 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/49
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.1.1,18.1.3,18.1.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E23 central ; N25.1 rénal appartient à S04 ; polydipsie primaire non assimilée automatiquement à un trouble psychiatrique., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 3 → E83 · diagnostic

Hypercalcémie · Anomalies du métabolisme des minéraux

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1e1ca9fbf89a08fd3c25 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/24
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 3 → N25 · differentiel

Résistance rénale à vasopressine, N25.1 · Affections dues à une tubulopathie

Devant polyurie-polydipsie : distinguer déficit central en vasopressine, résistance rénale et polydipsie primaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1ffe56886ade0c7ad501 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/51

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.1.1,18.1.3,18.1.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E23 central ; N25.1 rénal appartient à S04 ; polydipsie primaire non assimilée automatiquement à un trouble psychiatrique., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 3 → R63 · contexte

Polydipsie primaire · Symptômes et signes relatifs à l’absorption d’aliments et de liquides

Devant polyurie-polydipsie : distinguer déficit central en vasopressine, résistance rénale et polydipsie primaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-adce843da05641bf7984 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/53
Propriétaire / statut	T6 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.1.1,18.1.3,18.1.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Symptôme/contextualisation ; aucune attribution psychiatrique automatique., E23 central ; N25.1 rénal appartient à S04 ; polydipsie primaire non assimilée automatiquement à un trouble psychiatrique., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 4 → D50 · differentiel

Anémie par carence en fer · Anémie par carence en fer

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-df6bc7aaace0cd3ac2fb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/8

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S06 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 4 → E03 · differentiel

Hypothyroïdie · Autres hypothyroïdies

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-caf25ad73c20485f7188 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/0
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 4 → E05 · differentiel

Hyperthyroïdie · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4100181f6b5126d1b903 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/1

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 4 → E10 · differentiel

Diabète type1 · Diabète sucré, type 1

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-48145b5d22b80a38f15b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/2
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 4 → E11 · differentiel

Diabète type2 · Diabète sucré, type 2

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8c8683df10cdf68a0949 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/3

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 4 → E16 · diagnostic

Hypoglycémie hors coma non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4a97e51ecfa721ebcd46 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/36
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Hypoglycémie documentée ; distinguer diabète, nouveau-né et cause hormonale/tumorale., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 4 → E23 · differentiel

Insuffisance hypophysaire · Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c8f7893deef51477ce23 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/4
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 4 → E27 · differentiel

Addison · Autres maladies de la glande surrénale

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-54198b419168cb443f64 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/5
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 4 → E83 · diagnostic

Hypercalcémie · Anomalies du métabolisme des minéraux

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-930d411397a169cf6a8f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/25
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 4 → E83 · differentiel

Hypercalcémie · Anomalies du métabolisme des minéraux

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f727757d1ca1c4c2a2a1 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/6
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 4 → E87 · differentiel

Hypokaliémie · Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fa4ff32ce1b981cf473b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/7
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 4 → E88 · differentiel

Syndrome de lyse tumorale, E88.3 · Autres anomalies métaboliques

Cancer/chimiothérapie avec fatigue, vomissements, douleurs abdominales, anomalies électrolytiques et rénales : lyse tumorale parmi les diagnostics ; déshydratation et toxicité rénale sont différentielles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b8a20cd7e72ce7bc1a1b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/146
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	chuv_tls · diapositives5–7, vignette1 et différentiel https://www.unisante.ch/fr/media/1708/download
Limites	Cancer, charge tumorale ou traitement antinéoplasique dans contexte compatible., E88.3 seulement ; nécessite contexte, ne valide pas lipœdème/lipodystrophie., Diapositives pédagogiques ; diagnostic différentiel contextualisé par cancer/chimiothérapie, pas chaque E88.

SSP 4 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Fatigue : différentiel endocrino-métabolique explicite incluant dysthyroïdie, diabète, insuffisance hypophysaire/Addison, hypokaliémie et hypercalcémie ; causes rénale et anémie ferriprive également citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b693532d3717f45c6887 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/9
Propriétaire / statut	S04 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_fatigue · Diagnostik/Ursachen; Labor https://www.medix.ch/wissen/guidelines/kurzversion/psychische-krankheiten/muedigkeit/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Version courte lue. Version complète accessible seulement en partie sans login ; ne pas en revendiquer la lecture.

SSP 6 → E05 · differentiel

Crise thyrotoxique · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Crise thyrotoxique : fièvre, sueurs/flush, signes digestifs, tachyarythmie, délire jusqu’au coma peuvent s’associer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c9b9bfb642e3eb71b640 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/87
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.2.6 clinique https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E05 dans un ensemble clinique compatible, pas depuis un symptôme isolé., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 7 → E05 · differentiel

Crise thyrotoxique · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Crise thyrotoxique : fièvre, sueurs/flush, signes digestifs, tachyarythmie, délire jusqu’au coma peuvent s’associer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-83c782139132820cd2bd docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/88

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.2.6 clinique https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E05 dans un ensemble clinique compatible, pas depuis un symptôme isolé., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 8 → E16 · diagnostic

Hypoglycémie hors coma non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0f9dd879314696caffe8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/37
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Hypoglycémie documentée ; distinguer diabète, nouveau-né et cause hormonale/tumorale., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 15 → E03 · differentiel

Cause endocrine de gain pondéral · Autres hypothyroïdies

Gain pondéral : obésité, hypothyroïdie ou Cushing selon contexte ; perte pondérale : hyperthyroïdie, Addison, malabsorption et trouble alimentaire parmi les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-78edd0e4872f5cf3d101 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/134

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_weight · §66.1.5,66.4.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/adipositas-und-malnutrition/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Insuffisance pondérale n’est pas synonyme de chaque carenceE40–E64., Ne valide pas chaque carence nutritionnelle E40–E64.

SSP 15 → E24 · differentiel

Cause endocrine de gain pondéral · Syndrome de Cushing

Gain pondéral : obésité, hypothyroïdie ou Cushing selon contexte ; perte pondérale : hyperthyroïdie, Addison, malabsorption et trouble alimentaire parmi les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3403e66777bdc2d3fb51 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/135
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_weight · §66.1.5,66.4.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/adipositas-und-malnutrition/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Insuffisance pondérale n’est pas synonyme de chaque carenceE40–E64., Ne valide pas chaque carence nutritionnelle E40–E64.

SSP 15 → E66 · diagnostic

Obésité · Obésité

Gain pondéral : obésité, hypothyroïdie ou Cushing selon contexte ; perte pondérale : hyperthyroïdie, Addison, malabsorption et trouble alimentaire parmi les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-46b11bb389993646c8ad docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/133
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_weight · §66.1.5,66.4.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/adipositas-und-malnutrition/

Trace	Détail
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Insuffisance pondérale n’est pas synonyme de chaque carenceE40–E64., Ne valide pas chaque carence nutritionnelle E40–E64.

SSP 16 → E05 · differentiel

Thyréotoxicose [hyperthyroïdie] · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Gain pondéral : obésité, hypothyroïdie ou Cushing selon contexte ; perte pondérale : hyperthyroïdie, Addison, malabsorption et trouble alimentaire parmi les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cd6caa5fe0cb7bc071e9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/136
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_weight · §66.1.5,66.4.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/adipositas-und-malnutrition/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Insuffisance pondérale n’est pas synonyme de chaque carenceE40–E64., Ne valide pas chaque carence nutritionnelle E40–E64.

SSP 16 → E10 · diagnostic

Diabète sucré, type 1 · Diabète sucré, type 1

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-193654d7cad725d87641 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/11
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 16 → E11 · diagnostic

Diabète sucré, type 2 · Diabète sucré, type 2

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1405e9a3747efb956c62 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/15
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 16 → E13 · diagnostic

Autres diabètes sucrés précisés · Autres diabètes sucrés précisés

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5cae7e982d3b737a2501 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/19
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 16 → E27 · differentiel

Autres maladies de la glande surrénale · Autres maladies de la glande surrénale

Gain pondéral : obésité, hypothyroïdie ou Cushing selon contexte ; perte pondérale : hyperthyroïdie, Addison, malabsorption et trouble alimentaire parmi les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-87cff1ab3b1160bd7638 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/137
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_weight · §66.1.5,66.4.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/adipositas-und-malnutrition/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Insuffisance pondérale n’est pas synonyme de chaque carenceE40–E64., Ne valide pas chaque carence nutritionnelle E40–E64.

SSP 16 → F50 · differentiel

Troubles de l’alimentation · Troubles de l’alimentation

Gain pondéral : obésité, hypothyroïdie ou Cushing selon contexte ; perte pondérale : hyperthyroïdie, Addison, malabsorption et trouble alimentaire parmi les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-db881fbd47d9ac2ffb7a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/139
Propriétaire / statut	S09 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_weight · §66.1.5,66.4.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/adipositas-und-malnutrition/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Insuffisance pondérale n’est pas synonyme de chaque carenceE40–E64., Ne valide pas chaque carence nutritionnelle E40–E64.

SSP 16 → K90 · differentiel

Malabsorption intestinale · Malabsorption intestinale

Gain pondéral : obésité, hypothyroïdie ou Cushing selon contexte ; perte pondérale : hyperthyroïdie, Addison, malabsorption et trouble alimentaire parmi les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2a031a8e613a94a1e779 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/138
Propriétaire / statut	S03 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_weight · §66.1.5,66.4.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/adipositas-und-malnutrition/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Insuffisance pondérale n’est pas synonyme de chaque carenceE40–E64., Ne valide pas chaque carence nutritionnelle E40–E64.

SSP 37 → C73 · differentiel

Cancer thyroïdien · Tumeur maligne de la thyroïde

Nodule dur croissant, atteinte locale et histologie peuvent orienter vers cancer ; adénome folliculaire, goitre nodulaire et thyroïdite sont des différentiels.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2deb8a349512a9e34844 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/94
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.6 clinique et différentiel https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., C73 seulement après diagnostic approprié ; absence de symptômes possible., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 37 → D34 · differentiel

Adénome folliculaire bénin · Tumeur bénigne de la thyroïde

Goitre/nodule : causes liées à iode, non toxiques, hyperthyroïdie et thyroïdite ; carcinome et adénome folliculaire entrent dans le différentiel.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ed49cbc485598d46f7cd docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/76
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.1 et25.6.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/

Trace	Détail
Limites	Nodule ou lésion folliculaire ; bénignité à établir, pas tout nodule = D34., D34 nécessite une entité bénigne documentée, pas le seul nodule., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 37 → E01 · differentiel

Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode · Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode

Goitre/nodule : causes liées à iode, non toxiques, hyperthyroïdie et thyroïdite ; carcinome et adénome folliculaire entrent dans le différentiel.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4902f4707d751571a053 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/72
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.1 et25.6.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., D34 nécessite une entité bénigne documentée, pas le seul nodule., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 37 → E04 · differentiel

Autres goitres non toxiques · Autres goitres non toxiques

Goitre/nodule : causes liées à iode, non toxiques, hyperthyroïdie et thyroïdite ; carcinome et adénome folliculaire entrent dans le différentiel.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-bdb715ae7f9fca8b870d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/73
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.1 et25.6.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/

Trace	Détail
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., D34 nécessite une entité bénigne documentée, pas le seul nodule., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 37 → E05 · differentiel

Thyréotoxicose [hyperthyroïdie] · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Goitre/nodule : causes liées à iode, non toxiques, hyperthyroïdie et thyroïdite ; carcinome et adénome folliculaire entrent dans le différentiel.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-85ea7eb9c97501f6fe88 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/74
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.1 et25.6.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., D34 nécessite une entité bénigne documentée, pas le seul nodule., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 37 → E06 · differentiel

Thyroïdite · Thyroïdite

Goitre/nodule : causes liées à iode, non toxiques, hyperthyroïdie et thyroïdite ; carcinome et adénome folliculaire entrent dans le différentiel.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6d4d1e3cadc4d39edc6d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/75
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.1 et25.6.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., D34 nécessite une entité bénigne documentée, pas le seul nodule., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 39 → E16 · diagnostic

Hypoglycémie hors coma non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L'enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a078f3244967be97cca8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/38
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Hypoglycémie documentée ; distinguer diabète, nouveau-né et cause hormonale/tumorale., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 39 → E22 · differentiel

Hyperprolactinémie/prolactinome · Hypersécrétion de l'hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f1ebd5960b7f61fbea3c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/108
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 42 → E22 · differentiel

Hyperprolactinémie/prolactinome · Hypersécrétion de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b333bfe92f508233890c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/109
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 52 → E88 · differentiel

Syndrome de lyse tumorale, E88.3 · Autres anomalies métaboliques

Cancer/chimiothérapie avec fatigue, vomissements, douleurs abdominales, anomalies électrolytiques et rénales : lyse tumorale parmi les diagnostics ; déshydratation et toxicité rénale sont différentielles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4f02657faa10c4bf9876 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/147
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	chuv_tls · diapositives5–7, vignette1 et différentiel https://www.unisante.ch/fr/media/1708/download
Limites	Cancer, charge tumorale ou traitement antinéoplasique dans contexte compatible., E88.3 seulement ; nécessite contexte, ne valide pas lipœdème/lipodystrophie., Diapositives pédagogiques ; diagnostic différentiel contextualisé par cancer/chimiothérapie, pas chaque E88.

SSP 58 → E83 · diagnostic

Hypercalcémie · Anomalies du métabolisme des minéraux

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b96663d8f7ac0f903397 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/26
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 59 → E05 · differentiel

Crise thyrotoxique · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Crise thyrotoxique : fièvre, sueurs/flush, signes digestifs, tachyarythmie, délire jusqu’au coma peuvent s’associer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a44002bd895b50820b21 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/89
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.2.6 clinique https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E05 dans un ensemble clinique compatible, pas depuis un symptôme isolé., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 61 → E05 · differentiel

Crise thyrotoxique · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Crise thyrotoxique : fièvre, sueurs/flush, signes digestifs, tachyarythmie, délire jusqu’au coma peuvent s’associer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cf276a91206506e71917 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/90
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.2.6 clinique https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E05 dans un ensemble clinique compatible, pas depuis un symptôme isolé., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 61 → E83 · diagnostic

Hypercalcémie · Anomalies du métabolisme des minéraux

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f6ff94e7fd85654d5c6a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/27
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 61 → E86 · differentiel

Déshydratation/hypovolémie · Hypovolémie

Cancer/chimiothérapie avec fatigue, vomissements, douleurs abdominales, anomalies électrolytiques et rénales : lyse tumorale parmi les diagnostics ; déshydratation et toxicité rénale sont différentielles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-122394149aaf55a2a19e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/152

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	chuv_tls · diapositives5–7, vignette1 et différentiel https://www.unisante.ch/fr/media/1708/download
Limites	Différentiel dans la vignette oncologique, ne prouve pas toute hypovolémie., E88.3 seulement ; nécessite contexte, ne valide pas lipœdème/lipodystrophie., Diapositives pédagogiques ; diagnostic différentiel contextualisé par cancer/chimiothérapie, pas chaque E88.

SSP 61 → E88 · differentiel

Syndrome de lyse tumorale, E88.3 · Autres anomalies métaboliques

Cancer/chimiothérapie avec fatigue, vomissements, douleurs abdominales, anomalies électrolytiques et rénales : lyse tumorale parmi les diagnostics ; déshydratation et toxicité rénale sont différentielles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6ffc7ce6fb31eb8b51f9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/148
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	chuv_tls · diapositives5–7, vignette1 et différentiel https://www.unisante.ch/fr/media/1708/download
Limites	Cancer, charge tumorale ou traitement antinéoplasique dans contexte compatible., E88.3 seulement ; nécessite contexte, ne valide pas lipœdème/lipodystrophie., Diapositives pédagogiques ; diagnostic différentiel contextualisé par cancer/chimiothérapie, pas chaque E88.

SSP 62 → E25 · differentiel

Anomalie génito-surrénalienne · Anomalies génito-surrénaliennes

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-47ab05171f43a30baed4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/103
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 62 → E34 · differentiel

Résistance aux androgènes, E34.5 · Autres troubles endocriniens

Infertilité/développement sexuel atypique : hypogonadisme testiculaire, origine centrale ou résistance aux androgènes à différencier.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-dff85c57b4191ed930bd docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/130
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_testis · §47.1,47.3.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-testes/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E34.5 résistance androgènes ; ne valide pas tout E34., E34.5 pour résistance androgènes selon CIM locale ; ne pas la confondre avec E29.1 déficit 5-alpha-réductase.

SSP 63 → E10 · diagnostic

Diabète sucré, type 1 · Diabète sucré, type 1

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4dd9d1d4f8eb4971075f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/12
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 63 → E11 · diagnostic

Diabète sucré, type 2 · Diabète sucré, type 2

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b4e1f56e88eb2e462bae docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/16
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 63 → E13 · diagnostic

Autres diabètes sucrés précisés · Autres diabètes sucrés précisés

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8d684ea0e54dfa4ba204 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/20
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 63 → E21 · differentiel

Hyperparathyroïdie primaire · Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-219e046f4591b3ec27b8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/33
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 63 → E23 · differentiel

Déficit central en vasopressine · Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse

Devant polyurie-polydipsie : distinguer déficit central en vasopressine, résistance rénale et polydipsie primaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1809696c813de9f76a44 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/50
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.1.1,18.1.3,18.1.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E23 central ; N25.1 rénal appartient à S04 ; polydipsie primaire non assimilée automatiquement à un trouble psychiatrique., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 63 → E83 · diagnostic

Hypercalcémie · Anomalies du métabolisme des minéraux

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4c74687115b469aef516 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/28

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 63 → N25 · differentiel

Résistance rénale à vasopressine, N25.1 · Affections dues à une tubulopathie

Devant polyurie-polydipsie : distinguer déficit central en vasopressine, résistance rénale et polydipsie primaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f3ae413a508e4e9625c9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/52
Propriétaire / statut	S04 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.1.1,18.1.3,18.1.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E23 central ; N25.1 rénal appartient à S04 ; polydipsie primaire non assimilée automatiquement à un trouble psychiatrique., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 65 → E22 · differentiel

Hyperprolactinémie/prolactinome · Hypersécrétion de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2a8d3a5dda1b804c854d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/110
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 65 → E23 · differentiel

Hypogonadisme central ou hypothyroïdie centrale · Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-08849c53f6f657b741f8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/114
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 65 → E28 · differentiel

Insuffisance ovarienne/PCOS selon contexte · Dysfonction ovarienne

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d623580c24ab5009cbf5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/118
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 65 → E29 · differentiel

Hypogonadisme testiculaire · Dysfonction testiculaire

Infertilité/développement sexuel atypique : hypogonadisme testiculaire, origine centrale ou résistance aux androgènes à différencier.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-727b004837fcfaca77b8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/128
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_testis · §47.1,47.3.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-testes/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E34.5 résistance androgènes ; ne valide pas tout E34., E34.5 pour résistance androgènes selon CIM locale ; ne pas la confondre avec E29.1 déficit 5-alpha-réductase.

SSP 65 → E34 · differentiel

Résistance aux androgènes, E34.5 · Autres troubles endocriniens

Infertilité/développement sexuel atypique : hypogonadisme testiculaire, origine centrale ou résistance aux androgènes à différencier.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d89b02325fdfce6385f8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/131
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_testis · §47.1,47.3.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-testes/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E34.5 résistance androgènes ; ne valide pas tout E34., E34.5 pour résistance androgènes selon CIM locale ; ne pas la confondre avec E29.1 déficit 5-alpha-réductase.

SSP 65 → E89 · differentiel

Insuffisance ovarienne après chimiothérapie/radiothérapie · Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3398c8f292e9e0613df3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/126
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 66 → E22 · differentiel

Hyperprolactinémie/prolactinome · Hypersécrétion de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ac58f3c8014da9304534 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/111
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 66 → E24 · differentiel

Diagnostic à exclure avant PCOS · Syndrome de Cushing

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-81026ad02feaa1aab993 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/122
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 66 → E25 · differentiel

Diagnostic à exclure avant PCOS · Anomalies génito-surrénaliennes

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6cd034cfab0b889c75b8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/124
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 66 → E28 · differentiel

Insuffisance ovarienne/PCOS selon contexte · Dysfonction ovarienne

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5be0c7c05cd2c581956f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/119
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 66 → E89 · differentiel

Insuffisance ovarienne après chimiothérapie/radiothérapie · Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4fccb704e7088040da0a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/127
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 72 → E22 · differentiel

Hyperprolactinémie/prolactinome · Hypersécrétion de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1fb5d08832a739b2c2ae docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/112
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 72 → E23 · differentiel

Hypogonadisme central ou hypothyroïdie centrale · Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6ab663fdcf3344cf03d5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/115
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 72 → E29 · differentiel

Hypogonadisme testiculaire · Dysfonction testiculaire

Infertilité/développement sexuel atypique : hypogonadisme testiculaire, origine centrale ou résistance aux androgènes à différencier.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-65ff384813beb7c7066e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/129
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_testis · §47.1,47.3.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-testes/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E34.5 résistance androgènes ; ne valide pas tout E34., E34.5 pour résistance androgènes selon CIM locale ; ne pas la confondre avec E29.1 déficit 5-alpha-réductase.

SSP 74 → E28 · differentiel

Insuffisance ovarienne/PCOS selon contexte · Dysfonction ovarienne

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cb3b966d652483fcf953 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/120
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 86 → E79 · contexte

Hyperuricémie à distinguer de goutte · Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine

Hyperuricémie et goutte sont distinctes ; arthrite cristalline relève de M10 et le métabolisme urique peut être un contexte.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-74ae234b8f1f0295e0ee docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/156
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	usz_gout · Ursachen, Diagnostik https://www.usz.ch/krankheit/gicht/

Trace	Détail
Limites	Association contextuelle ; E79.0 ne code pas l’arthrite ; pas une inclusion automatique comme cours autonome., E79.0 exclut arthrite inflammatoire/tophus : ne pas ajouter E79 comme diagnostic de douleur articulaire., Source institutionnelle pour distinguer hyperuricémie et goutte. Ne prouve pas un cours E79 autonome requis par SSP.

SSP 86 → M10 · differentiel

Goutte/arthrite uratique · Goutte

Hyperuricémie et goutte sont distinctes ; arthrite cristalline relève de M10 et le métabolisme urique peut être un contexte.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1ac38ce9c53cf6ab0ed5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/155
Propriétaire / statut	S10 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	usz_gout · Ursachen, Diagnostik https://www.usz.ch/krankheit/gicht/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E79.0 exclut arthrite inflammatoire/tophus : ne pas ajouter E79 comme diagnostic de douleur articulaire., Source institutionnelle pour distinguer hyperuricémie et goutte. Ne prouve pas un cours E79 autonome requis par SSP.

SSP 91 → E80 · differentiel

Défaut de conjugaison bilirubine : Gilbert/Crigler-Najjar · Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine

Ictère/hyperbilirubinémie : défaut de conjugaison dont Gilbert ou Crigler-Najjar à distinguer d’hémolyse et obstruction/atteinte hépatique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ddf35d1c7524eff586e5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/145
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	hug_liver · p6 Bilirubine https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2024-10/strategie_tests_hepatiques_figures_ajoutees_doi.pdf

Trace	Détail
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E80.4/E80.5 soutenus ; pas de revalidation des porphyries par cette source., E80 soutenu pour Gilbert/Crigler-Najjar seulement ; porphyries non recontrôlées.

SSP 92 → E23 · differentiel

Hypogonadisme central ou hypothyroïdie centrale · Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ef5494b445d41cd8b5a0 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/116
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 92 → E24 · differentiel

Diagnostic à exclure avant PCOS · Syndrome de Cushing

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3b40e228d40748a3c26e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/123
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 92 → E25 · differentiel

Anomalie génito-surrénalienne · Anomalies génito-surrénaliennes

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-685bf0823465af4f3db6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/104
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 92 → E25 · differentiel

Diagnostic à exclure avant PCOS · Anomalies génito-surrénaliennes

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-688d32cdeb1bcc1519d3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/125
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 92 → E28 · differentiel

Insuffisance ovarienne/PCOS selon contexte · Dysfonction ovarienne

Troubles menstruels, infertilité et signes d’androgénisation : insuffisance ovarienne ou PCOS ; exclure cause génito-surrénalienne, Cushing et tumeur sécrétante.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6fc9c66061c4125fe662 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/121
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_ovary · §40.1,40.5 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-ovarien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Ne pas reprendre les anciens seuils échographiques comme recommandations actuelles., Seules les entités et différentiels sont repris ; critères chiffrés historiques non repris.

SSP 92 → E34 · differentiel

Résistance aux androgènes, E34.5 · Autres troubles endocriniens

Infertilité/développement sexuel atypique : hypogonadisme testiculaire, origine centrale ou résistance aux androgènes à différencier.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6b7706ba6d6a9e932c7c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/132
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_testis · §47.1,47.3.1 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-testes/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E34.5 résistance androgènes ; ne valide pas tout E34., E34.5 pour résistance androgènes selon CIM locale ; ne pas la confondre avec E29.1 déficit 5-alpha-réductase.

SSP 98 → E16 · diagnostic

Hypoglycémie hors coma non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-55993dc7fc2b4125eeab docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/39
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Hypoglycémie documentée ; distinguer diabète, nouveau-né et cause hormonale/tumorale., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 101 → E22 · differentiel

Hyperprolactinémie/prolactinome · Hypersécrétion de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b317360fe7c38077dc12 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/113
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 101 → E22 · differentiel

SIAD, E22.2 · Hypersécrétion de l’hypophyse

Hyponatrémie avec manifestations neurologiques : SIAD parmi les diagnostics ; exclure insuffisance surrénale et hypothyroïdie, distinguer polydipsie primaire et pseudo-hyponatrémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c7f62ffed7fc949059f6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/54
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_hhl · §18.2.2–18.2.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E22.2 SIAD ; E87 désordre sodium. Le contexte doit être vérifié ; pas tout E22 déduit des électrolytes., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 105 → E16 · diagnostic

Hypoglycémie hors coma non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ce99ee0fb537c1f59798 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/40
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Hypoglycémie documentée ; distinguer diabète, nouveau-né et cause hormonale/tumorale., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 126 → E05 · differentiel

Crise thyrotoxique · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Crise thyrotoxique : fièvre, sueurs/flush, signes digestifs, tachyarythmie, délire jusqu’au coma peuvent s’associer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3ece46d322bc9136263d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/91
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_thyroid · §25.2.6 clinique https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E05 dans un ensemble clinique compatible, pas depuis un symptôme isolé., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 126 → E22 · differentiel

SIAD, E22.2 · Hypersécrétion de l’hypophyse

Hyponatrémie avec manifestations neurologiques : SIAD parmi les diagnostics ; exclure insuffisance surrénale et hypothyroïdie, distinguer polydipsie primaire et pseudo-hyponatrémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-154a03bfff3ad422c586 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/55
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.2.2–18.2.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E22.2 SIAD ; E87 désordre sodium. Le contexte doit être vérifié ; pas tout E22 déduit des électrolytes., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 126 → E83 · diagnostic

Hypercalcémie · Anomalies du métabolisme des minéraux

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1a59b8d54bdb82a26806 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/29
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/

Trace	Détail
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 126 → E87 · diagnostic

Hyponatrémie · Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

Hyponatrémie avec manifestations neurologiques : SIAD parmi les diagnostics ; exclure insuffisance surrénale et hypothyroïdie, distinguer polydipsie primaire et pseudo-hyponatrémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8f92636e644c964a7caa docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/58
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.2.2–18.2.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E22.2 SIAD ; E87 désordre sodium. Le contexte doit être vérifié ; pas tout E22 déduit des électrolytes., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 131 → E24 · differentiel

Syndrome de Cushing · Syndrome de Cushing

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-91683b44df1cac68755f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/96
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 131 → E25 · differentiel

Anomalies génito-surrénaliennes · Anomalies génito-surrénaliennes

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-dfbfe49f75a89c8a8847 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/100
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 131 → E26 · differentiel

Hyperaldostéronisme · Hyperaldostéronisme

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-22f5c9e63adfd14c3c9b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/98
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 137 → E05 · differentiel

Crise thyrotoxique · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Crise thyrotoxique : fièvre, sueurs/flush, signes digestifs, tachyarythmie, délire jusqu’au coma peuvent s’associer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-af16fbe04d6e7b42c8b2 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/92
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.2.6 clinique https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E05 dans un ensemble clinique compatible, pas depuis un symptôme isolé., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 137 → E16 · diagnostic

Hypoglycémie hors coma non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2ac5c7d0926489674008 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/41
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Hypoglycémie documentée ; distinguer diabète, nouveau-né et cause hormonale/tumorale., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 145 → E05 · differentiel

Crise thyrotoxique · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Crise thyrotoxique : fièvre, sueurs/flush, signes digestifs, tachyarythmie, délire jusqu’au coma peuvent s’associer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f13641fcc4559b06f1b0 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/93
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.2.6 clinique https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E05 dans un ensemble clinique compatible, pas depuis un symptôme isolé., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 145 → E15 · diagnostic

Coma hypoglycémique non diabétique · Coma hypoglycémique non diabétique

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-7e42967c63d72af6b9e9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/44
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Coma et hypoglycémie documentés ; code E15 confirmé OFS p151 ; ne pas confondre avec coma diabétique., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 145 → E22 · differentiel

SIAD, E22.2 · Hypersécrétion de l’hypophyse

Hyponatrémie avec manifestations neurologiques : SIAD parmi les diagnostics ; exclure insuffisance surrénale et hypothyroïdie, distinguer polydipsie primaire et pseudo-hyponatrémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-913fb31fff165281a0da docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/56
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.2.2–18.2.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E22.2 SIAD ; E87 désordre sodium. Le contexte doit être vérifié ; pas tout E22 déduit des électrolytes., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 145 → E83 · diagnostic

Hypercalcémie · Anomalies du métabolisme des minéraux

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-78d96cef00a22dfa888b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/30
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 145 → E87 · diagnostic

Hyponatrémie · Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

Hyponatrémie avec manifestations neurologiques : SIAD parmi les diagnostics ; exclure insuffisance surrénale et hypothyroïdie, distinguer polydipsie primaire et pseudo-hyponatrémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e3b3bec5d7ef8896e93c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/59

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.2.2–18.2.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E22.2 SIAD ; E87 désordre sodium. Le contexte doit être vérifié ; pas tout E22 déduit des électrolytes., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 155 → E88 · differentiel

Syndrome de lyse tumorale, E88.3 · Autres anomalies métaboliques

Cancer/chimiothérapie avec fatigue, vomissements, douleurs abdominales, anomalies électrolytiques et rénales : lyse tumorale parmi les diagnostics ; déshydratation et toxicité rénale sont différentielles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-48a70dfa19486f5ada17 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/149
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	chuv_tls · diapositives5–7, vignette1 et différentiel https://www.unisante.ch/fr/media/1708/download
Limites	Cancer, charge tumorale ou traitement antinéoplasique dans contexte compatible., E88.3 seulement ; nécessite contexte, ne valide pas lipœdème/lipodystrophie., Diapositives pédagogiques ; diagnostic différentiel contextualisé par cancer/chimiothérapie, pas chaque E88.

SSP 156 → C75 · differentiel

Carcinome parathyroïdien, C75.0 · Tumeur maligne d’autres glandes endocrines et structures apparentées

Hyperparathyroïdie : carcinome parathyroïdien rare à considérer dans le différentiel ; la maladie primaire peut entraîner perte osseuse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0b6010aeed39ee38745a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/70

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	ese_parat · p2 Parathyroid carcinoma; p9 PHPT/bone tissue https://www.ese-hormones.org/media/vdef53pz/eje-parat-publication-2019.pdf
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., C75.0 seulement, pas l'intégralité de C75 ni la malignité déduite de la seule hypercalcémie., Consensus primaire européen, pas relecture intégrale des19pages ; traitement non repris.

SSP 156 → E03 · differentiel

Cause à exclure devant hyponatrémie · Autres hypothyroïdies

Hyponatrémie avec manifestations neurologiques : SIAD parmi les diagnostics ; exclure insuffisance surrénale et hypothyroïdie, distinguer polydipsie primaire et pseudo-hyponatrémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-daf64c3d8340b1f2ee79 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/62
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.2.2–18.2.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E22.2 SIAD ; E87 désordre sodium. Le contexte doit être vérifié ; pas tout E22 déduit des électrolytes., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 156 → E05 · differentiel

Hyperthyroïdie · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Anomalie calcique : différentiel parathyroïdien, malin, excès vitaminiqueD, hyperthyroïdie, médicaments ; hypocalcémie peut accompagner carenceD ou insuffisance rénale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8e8044a4a6f7762fe0fa docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/64
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_calcium · §72.1.1–72.1.3;72.2.2 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/storungen-des-kalziumstoffwechsels/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E83.5 couvre anomalie du métabolisme du calcium ; E87 ne remplace pas toutes les causes. Chaque sous-entité minérale non lue reste à vérifier., Les figures et paragraphes vides ne sont pas réputés lus ; pas de validation de tous les troubles du cuivre/fer/magnésium par cette source.

SSP 156 → E20 · differentiel

Hypoparathyroïdie hors cause après acte · Hypoparathyroïdie

Hypocalcémie avec PTH inappropriée basse oriente vers hypoparathyroïdie ; forme après chirurgie cervicale à distinguer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e076571f725d98590fbc docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/68
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	ese_parat · p6, The diagnosis of hypoparathyroidism https://www.ese-hormones.org/media/vdef53pz/eje-parat-publication-2019.pdf
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E20 pour hypoparathyroïdie appropriée ; E89.2 pour après acte. Pas de validation des autres souscodes., Consensus primaire européen, pas relecture intégrale des19pages ; traitement non repris.

SSP 156 → E21 · differentiel

Hyperparathyroïdie primaire · Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2f65f08d0c13e8966f6f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/34
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/

Trace	Détail
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 156 → E21 · differentiel

Hyperparathyroïdie · Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

Anomalie calcique : différentiel parathyroïdien, malin, excès vitaminiqueD, hyperthyroïdie, médicaments ; hypocalcémie peut accompagner carenceD ou insuffisance rénale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d42e16a4109adc7c82cb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/63
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_calcium · §72.1.1–72.1.3;72.2.2 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/storungen-des-kalziumstoffwechsels/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E83.5 couvre anomalie du métabolisme du calcium ; E87 ne remplace pas toutes les causes. Chaque sous-entité minérale non lue reste à vérifier., Les figures et paragraphes vides ne sont pas réputés lus ; pas de validation de tous les troubles du cuivre/fer/magnésium par cette source.

SSP 156 → E22 · differentiel

SIAD, E22.2 · Hypersécrétion de l’hypophyse

Hyponatrémie avec manifestations neurologiques : SIAD parmi les diagnostics ; exclure insuffisance surrénale et hypothyroïdie, distinguer polydipsie primaire et pseudo-hyponatrémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-512f36a64ff8d1c2efb8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/57
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.2.2–18.2.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/

Trace	Détail
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E22.2 SIAD ; E87 désordre sodium. Le contexte doit être vérifié ; pas tout E22 déduit des électrolytes., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 156 → E24 · differentiel

Syndrome de Cushing · Syndrome de Cushing

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-697f5c663998026a7ff9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/97
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 156 → E25 · differentiel

Anomalies génito-surrénaliennes · Anomalies génito-surrénaliennes

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ecf8d429fe7ab049b466 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/101
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 156 → E26 · differentiel

Hyperaldostéronisme · Hyperaldostéronisme

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f00dc937c79eb3c386fd docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/99
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 156 → E27 · differentiel

Hypoaldostéronisme · Autres maladies de la glande surrénale

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-574204e31cb9cc834035 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/105
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 156 → E27 · differentiel

Cause à exclure devant hyponatrémie · Autres maladies de la glande surrénale

Hyponatrémie avec manifestations neurologiques : SIAD parmi les diagnostics ; exclure insuffisance surrénale et hypothyroïdie, distinguer polydipsie primaire et pseudo-hyponatrémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-95a8c7538b2a7aab8416 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/61
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.2.2–18.2.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E22.2 SIAD ; E87 désordre sodium. Le contexte doit être vérifié ; pas tout E22 déduit des électrolytes., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 156 → E55 · differentiel

Carence vitamineD · Carence en vitamine D

Anomalie calcique : différentiel parathyroïdien, malin, excès vitaminiqueD, hyperthyroïdie, médicaments ; hypocalcémie peut accompagner carenceD ou insuffisance rénale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-44e0b6e11c1e6fd74b08 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/66
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_calcium · §72.1.1–72.1.3;72.2.2 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/storungen-des-kalziumstoffwechsels/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E83.5 couvre anomalie du métabolisme du calcium ; E87 ne remplace pas toutes les causes. Chaque sous-entité minérale non lue reste à vérifier., Les figures et paragraphes vides ne sont pas réputés lus ; pas de validation de tous les troubles du cuivre/fer/magnésium par cette source.

SSP 156 → E67 · differentiel

Excès vitamineD · Autres excès d’apport

Anomalie calcique : différentiel parathyroïdien, malin, excès vitaminiqueD, hyperthyroïdie, médicaments ; hypocalcémie peut accompagner carenceD ou insuffisance rénale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3220b778162f90b76580 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/65
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_calcium · §72.1.1–72.1.3;72.2.2 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/storungen-des-kalziumstoffwechsels/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E83.5 couvre anomalie du métabolisme du calcium ; E87 ne remplace pas toutes les causes. Chaque sous-entité minérale non lue reste à vérifier., Les figures et paragraphes vides ne sont pas réputés lus ; pas de validation de tous les troubles du cuivre/fer/magnésium par cette source.

SSP 156 → E83 · diagnostic

Hypercalcémie · Anomalies du métabolisme des minéraux

Polyurie avec fatigue, nausées, constipation ou confusion/coma : hypercalcémie parmi les diagnostics ; distinguer hyperparathyroïdie primaire et cause maligne par contexte et PTH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-85558ad7d8d416701eb2 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/31
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_polyuria · §86 FALL4.1 solutions1–4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/polyurie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Cas pédagogiques primaires suisses ; ne démontrent pas toutes les étiologies ni leur fréquence actuelle.

SSP 156 → E86 · differentiel

Déshydratation/hypovolémie · Hypovolémie

Cancer/chimiothérapie avec fatigue, vomissements, douleurs abdominales, anomalies électrolytiques et rénales : lyse tumorale parmi les diagnostics ; déshydratation et toxicité rénale sont différentielles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0a86b0e193ae2c6bbab3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/153
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	chuv_tls · diapositives5–7, vignette1 et différentiel https://www.unisante.ch/fr/media/1708/download
Limites	Différentiel dans la vignette oncologique, ne prouve pas toute hypovolémie., E88.3 seulement ; nécessite contexte, ne valide pas lipœdème/lipodystrophie., Diapositives pédagogiques ; diagnostic différentiel contextualisé par cancer/chimiothérapie, pas chaque E88.

SSP 156 → E87 · diagnostic

Hyponatrémie · Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

Hyponatrémie avec manifestations neurologiques : SIAD parmi les diagnostics ; exclure insuffisance surrénale et hypothyroïdie, distinguer polydipsie primaire et pseudo-hyponatrémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-eef4f810e6b2f78c129d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/60
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hhl · §18.2.2–18.2.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hhl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E22.2 SIAD ; E87 désordre sodium. Le contexte doit être vérifié ; pas tout E22 déduit des électrolytes., Ancienne terminologie ADH/diabète insipide ; les procédures et seuils ne sont pas repris.

SSP 156 → E88 · differentiel

Syndrome de lyse tumorale, E88.3 · Autres anomalies métaboliques

Cancer/chimiothérapie avec fatigue, vomissements, douleurs abdominales, anomalies électrolytiques et rénales : lyse tumorale parmi les diagnostics ; déshydratation et toxicité rénale sont différentielles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fbf8c765304379e439b3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/150

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	chuv_tls · diapositives5–7, vignette1 et différentiel https://www.unisante.ch/fr/media/1708/download
Limites	Cancer, charge tumorale ou traitement antinéoplasique dans contexte compatible., E88.3 seulement ; nécessite contexte, ne valide pas lipœdème/lipodystrophie., Diapositives pédagogiques ; diagnostic différentiel contextualisé par cancer/chimiothérapie, pas chaque E88.

SSP 156 → E89 · differentiel

Hypoparathyroïdie après acte, E89.2 · Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs

Hypocalcémie avec PTH inappropriée basse oriente vers hypoparathyroïdie ; forme après chirurgie cervicale à distinguer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cd802c0ea363f1bd6e0e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/69
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	ese_parat · p6, The diagnosis of hypoparathyroidism https://www.ese-hormones.org/media/vdef53pz/eje-parat-publication-2019.pdf
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E20 pour hypoparathyroïdie appropriée ; E89.2 pour après acte. Pas de validation des autres souscodes., Consensus primaire européen, pas relecture intégrale des19pages ; traitement non repris.

SSP 156 → N18 · differentiel

Cause rénale de trouble calcique · Maladie rénale chronique

Anomalie calcique : différentiel parathyroïdien, malin, excès vitaminiqueD, hyperthyroïdie, médicaments ; hypocalcémie peut accompagner carenceD ou insuffisance rénale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-818c95537253d1bcffaf docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/67
Propriétaire / statut	S04 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_calcium · §72.1.1–72.1.3;72.2.2 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/storungen-des-kalziumstoffwechsels/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E83.5 couvre anomalie du métabolisme du calcium ; E87 ne remplace pas toutes les causes. Chaque sous-entité minérale non lue reste à vérifier., Les figures et paragraphes vides ne sont pas réputés lus ; pas de validation de tous les troubles du cuivre/fer/magnésium par cette source.

SSP 158 → E10 · diagnostic

Diabète sucré, type 1 · Diabète sucré, type 1

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b1ea7184384a97a273b4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/13
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 158 → E11 · diagnostic

Diabète sucré, type 2 · Diabète sucré, type 2

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d5065341debd7e7422af docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/17
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/

Trace	Détail
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 158 → E13 · diagnostic

Autres diabètes sucrés précisés · Autres diabètes sucrés précisés

Polydipsie, polyurie, perte pondérale avec anomalie glycémique conduisent au diagnostic de diabète ; type1, type2 et formes spécifiques doivent ensuite être distingués.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ac0a32eb9fd8a45e39f3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/21
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Classification, §2 Diagnostic https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 158 → E15 · diagnostic

Coma hypoglycémique non diabétique · Coma hypoglycémique non diabétique

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c859696071aaa9500e16 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/45
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie

Trace	Détail
Limites	Coma et hypoglycémie documentés ; code E15 confirmé OFS p151 ; ne pas confondre avec coma diabétique., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 158 → E16 · diagnostic

Hypoglycémie hors coma non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-91c412a239c771679e86 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/42
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Hypoglycémie documentée ; distinguer diabète, nouveau-né et cause hormonale/tumorale., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 158 → E16 · differentiel

Hyperinsulinisme/hypoglycémie non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie : causes médicamenteuses, déficits hormonaux, manque de substrat et tumeurs ; hyperinsulinisme et insulinome figurent dans l’enquête étiologique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d0400dbae2528783c196 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/47
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_hypoglycemia · §57.1,57.4,57.6 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/hypoglykamie/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Chapitre pédagogique, date non indiquée ; aucune procédure de test ou traitement reproduite.

SSP 158 → E22 · differentiel

Cause endocrine de diabète spécifique · Hypersécrétion de l’hypophyse

Cushing, phéochromocytome et acromégalie sont des causes endocrines de diabète spécifique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-832bf10f113ad62cd7e6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/22
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Autres types spécifiques https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 158 → E24 · differentiel

Cause endocrine de diabète spécifique · Syndrome de Cushing

Cushing, phéochromocytome et acromégalie sont des causes endocrines de diabète spécifique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1c53e9fa53992c37519d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/23
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	medix_diabetes · §1 Autres types spécifiques https://www.medix.ch/fr/connaissances/guide-des-bonnes-pratiques/diabete/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Une correspondance pédagogique déduite, non une table officielle CIM/PROFILES., Source de classification et de symptômes ; aucune recommandation thérapeutique exportée.

SSP 158 → E24 · differentiel

Cushing · Syndrome de Cushing

Troubles glycémiques/électrolytiques ou hypertension : Cushing, hyperaldostéronisme et causes endocrines différentielles ; anomalies génito-surrénaliennes si virilisation compatible.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5bd6e85a569190b4948f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/102
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_adrenal · §30.2.1–30.2.4;30.3.3 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-nnr/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Aucune généralisation de SSP184 à toutes les affections E20–E35 ; figures non lues exclues., Plusieurs signes cliniques sont en figures non transcrites : ne sont pas déduits depuis ces figures.

SSP 158 → E74 · differentiel

Glycogénose · Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d6c05f8c5cf7c379bab8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/48
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Enquête pédiatrique contextuelle ; aucune maladie précise du groupe déduite sans bilan., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 159 → C73 · differentiel

Cancer thyroïdien · Tumeur maligne de la thyroïde

Nodule dur croissant, atteinte locale et histologie peuvent orienter vers cancer ; adénome folliculaire, goitre nodulaire et thyroïdite sont des différentiels.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2bc03af8a0a441da0392 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/95
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.6 clinique et différentiel https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., C73 seulement après diagnostic approprié ; absence de symptômes possible., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 159 → D34 · differentiel

Adénome folliculaire bénin · Tumeur bénigne de la thyroïde

Goitre/nodule : causes liées à iode, non toxiques, hyperthyroïdie et thyroïdite ; carcinome et adénome folliculaire entrent dans le différentiel.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9199cb9449146bcf8a0d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/77
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.1 et25.6.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Nodule ou lésion folliculaire ; bénignité à établir, pas tout nodule = D34., D34 nécessite une entité bénigne documentée, pas le seul nodule., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 161 → E86 · differentiel

Déshydratation/hypovolémie · Hypovolémie

Cancer/chimiothérapie avec fatigue, vomissements, douleurs abdominales, anomalies électrolytiques et rénales : lyse tumorale parmi les diagnostics ; déshydratation et toxicité rénale sont différentielles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e49c0ad6bdc00d5d494c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/154
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	chuv_tls · diapositives5–7, vignette1 et différentiel https://www.unisante.ch/fr/media/1708/download
Limites	Différentiel dans la vignette oncologique, ne prouve pas toute hypovolémie., E88.3 seulement ; nécessite contexte, ne valide pas lipœdème/lipodystrophie., Diapositives pédagogiques ; diagnostic différentiel contextualisé par cancer/chimiothérapie, pas chaque E88.

SSP 161 → E88 · differentiel

Syndrome de lyse tumorale, E88.3 · Autres anomalies métaboliques

Cancer/chimiothérapie avec fatigue, vomissements, douleurs abdominales, anomalies électrolytiques et rénales : lyse tumorale parmi les diagnostics ; déshydratation et toxicité rénale sont différentielles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-71829ead90bee96fa3dc docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/151
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	chuv_tls · diapositives5–7, vignette1 et différentiel https://www.unisante.ch/fr/media/1708/download
Limites	Cancer, charge tumorale ou traitement antinéoplasique dans contexte compatible., E88.3 seulement ; nécessite contexte, ne valide pas lipœdème/lipodystrophie., Diapositives pédagogiques ; diagnostic différentiel contextualisé par cancer/chimiothérapie, pas chaque E88.

SSP 162 → E03 · differentiel

Cause secondaire de dyslipidémie · Autres hypothyroïdies

Lipides anormaux : dyslipidémie primaire versus causes secondaires thyroïdienne, diabétique ou syndrome néphrotique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-678c34613d5203df64f6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/141
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_lipids · §62.1 tableau primaire/secondaire https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/formen-der-dyslipidamien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Anomalie lipidique seule ne prouve pas un mécanisme spécifique., Uniquement taxonomie et causes secondaires ; aucune conduite ni affirmation alcool protecteur reprise.

SSP 162 → E10 · differentiel

Cause secondaire de dyslipidémie · Diabète sucré, type 1

Lipides anormaux : dyslipidémie primaire versus causes secondaires thyroïdienne, diabétique ou syndrome néphrotique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e84ce72217a944775d6e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/142
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_lipids · §62.1 tableau primaire/secondaire https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/formen-der-dyslipidamien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Anomalie lipidique seule ne prouve pas un mécanisme spécifique., Uniquement taxonomie et causes secondaires ; aucune conduite ni affirmation alcool protecteur reprise.

SSP 162 → E11 · differentiel

Cause secondaire de dyslipidémie · Diabète sucré, type 2

Lipides anormaux : dyslipidémie primaire versus causes secondaires thyroïdienne, diabétique ou syndrome néphrotique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2b7141dc8578630e94c8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/143
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_lipids · §62.1 tableau primaire/secondaire https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/formen-der-dyslipidamien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Anomalie lipidique seule ne prouve pas un mécanisme spécifique., Uniquement taxonomie et causes secondaires ; aucune conduite ni affirmation alcool protecteur reprise.

SSP 162 → E78 · diagnostic

Dyslipidémie primaire/secondaire · Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies

Lipides anormaux : dyslipidémie primaire versus causes secondaires thyroïdienne, diabétique ou syndrome néphrotique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-91db86e3d4738ebc2876 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/140
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_lipids · §62.1 tableau primaire/secondaire https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/formen-der-dyslipidamien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Anomalie lipidique seule ne prouve pas un mécanisme spécifique., Uniquement taxonomie et causes secondaires ; aucune conduite ni affirmation alcool protecteur reprise.

SSP 162 → N04 · differentiel

Cause secondaire de dyslipidémie · Syndrome néphrotique

Lipides anormaux : dyslipidémie primaire versus causes secondaires thyroïdienne, diabétique ou syndrome néphrotique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9c9109e5f7add59dd1e4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/144
Propriétaire / statut	S04 · soutenu_pour_cette_entite_seulement

Trace	Détail
Source / section	eth_lipids · §62.1 tableau primaire/secondaire https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/formen-der-dyslipidamien/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Anomalie lipidique seule ne prouve pas un mécanisme spécifique., Uniquement taxonomie et causes secondaires ; aucune conduite ni affirmation alcool protecteur reprise.

SSP 163 → E03 · differentiel

Dysthyroïdie ou exception centrale/résistance selon contexte · Autres hypothyroïdies

Hormones thyroïdiennes anormales : hypo-/hyperthyroïdie et exceptions centrales ou résistance hormonale doivent être distinguées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-aa1f3dfa535b2c733e00 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/78
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	ssed_thyroid · p1–2 Introduction, recommandations, exceptions https://www.sgedssed.ch/SgedSsed/fileadmin/7_Endokrinologie/72_Empfehlungen_SGED/recommandations_postanalytique_bilan_thyroidien_20251010.pdf
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Adulte hors grossesse ; anomalie TSH ne suffit pas à attribuer un code étiologique., Adulte hors grossesse. Soutient hypothyroïdie/hyperthyroïdie et exceptions, pas chaque code thyroïdien.

SSP 163 → E05 · differentiel

Dysthyroïdie ou exception centrale/résistance selon contexte · Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Hormones thyroïdiennes anormales : hypo-/hyperthyroïdie et exceptions centrales ou résistance hormonale doivent être distinguées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3cd71435f004da3a6c0f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/79
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	ssed_thyroid · p1–2 Introduction, recommandations, exceptions https://www.sgedssed.ch/SgedSsed/fileadmin/7_Endokrinologie/72_Empfehlungen_SGED/recommandations_postanalytique_bilan_thyroidien_20251010.pdf

Trace	Détail
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Adulte hors grossesse ; anomalie TSH ne suffit pas à attribuer un code étiologique., Adulte hors grossesse. Soutient hypothyroïdie/hyperthyroïdie et exceptions, pas chaque code thyroïdien.

SSP 163 → E06 · differentiel

Thyroïdite · Thyroïdite

Dysthyroïdie : différencier thyroïdite auto-immune, carence iodée, cause centrale, après chirurgie/radioiode et syndrome de maladie non thyroïdienne.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9efecc3627c8198a7ab7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/83
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.3.1,25.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E89.0 après acte, E23 central ; pas de reclassement automatique en E03., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 163 → E07 · differentiel

Syndrome de maladie non thyroïdienne · Autres affections de la thyroïde

Dysthyroïdie : différencier thyroïdite auto-immune, carence iodée, cause centrale, après chirurgie/radioiode et syndrome de maladie non thyroïdienne.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-41bd6cb1aec2529b6164 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/84
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.3.1,25.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E89.0 après acte, E23 central ; pas de reclassement automatique en E03., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 163 → E22 · differentiel

Dysthyroïdie ou exception centrale/résistance selon contexte · Hypersécrétion de l’hypophyse

Hormones thyroïdiennes anormales : hypo-/hyperthyroïdie et exceptions centrales ou résistance hormonale doivent être distinguées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3d10fe14d156d8a34f17 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/80
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	ssed_thyroid · p1–2 Introduction, recommandations, exceptions https://www.sgedssed.ch/SgedSsed/fileadmin/7_Endokrinologie/72_Empfehlungen_SGED/recommandations_postanalytique_bilan_thyroidien_20251010.pdf
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Adulte hors grossesse ; anomalie TSH ne suffit pas à attribuer un code étiologique., Adulte hors grossesse. Soutient hypothyroïdie/hyperthyroïdie et exceptions, pas chaque code thyroïdien.

SSP 163 → E23 · differentiel

Dysthyroïdie ou exception centrale/résistance selon contexte · Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse

Hormones thyroïdiennes anormales : hypo-/hyperthyroïdie et exceptions centrales ou résistance hormonale doivent être distinguées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-29e56ec0704efcba0267 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/81
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	ssed_thyroid · p1–2 Introduction, recommandations, exceptions https://www.sgedssed.ch/SgedSsed/fileadmin/7_Endokrinologie/72_Empfehlungen_SGED/recommandations_postanalytique_bilan_thyroidien_20251010.pdf
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Adulte hors grossesse ; anomalie TSH ne suffit pas à attribuer un code étiologique., Adulte hors grossesse. Soutient hypothyroïdie/hyperthyroïdie et exceptions, pas chaque code thyroïdien.

SSP 163 → E23 · differentiel

Hypogonadisme central ou hypothyroïdie centrale · Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f0a8bc54e9a712819384 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/117
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 163 → E34 · differentiel

Dysthyroïdie ou exception centrale/résistance selon contexte · Autres troubles endocriniens

Hormones thyroïdiennes anormales : hypo-/hyperthyroïdie et exceptions centrales ou résistance hormonale doivent être distinguées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b8518ea71f23d5de461b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/82
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	ssed_thyroid · p1–2 Introduction, recommandations, exceptions https://www.sgedssed.ch/SgedSsed/fileadmin/7_Endokrinologie/72_Empfehlungen_SGED/recommandations_postanalytique_bilan_thyroidien_20251010.pdf
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Adulte hors grossesse ; anomalie TSH ne suffit pas à attribuer un code étiologique., Adulte hors grossesse. Soutient hypothyroïdie/hyperthyroïdie et exceptions, pas chaque code thyroïdien.

SSP 163 → E89 · differentiel

Hypothyroïdie après chirurgie/radioiode, E89.0 · Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs

Dysthyroïdie : différencier thyroïdite auto-immune, carence iodée, cause centrale, après chirurgie/radioiode et syndrome de maladie non thyroïdienne.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1db26d80ac5dbc10f68b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/85
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_thyroid · §25.3.1,25.4 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-der-schilddruse/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., E89.0 après acte, E23 central ; pas de reclassement automatique en E03., Erreurs typographiques manifestes dans certains intitulés hypo/hyper ; ne pas les reproduire. Source utilisée uniquement pour entités et différentiels, pas pour seuils ni traitement.

SSP 169 → E21 · differentiel

Hyperparathyroïdie avec perte osseuse · Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

Hyperparathyroïdie : carcinome parathyroïdien rare à considérer dans le différentiel ; la maladie primaire peut entraîner perte osseuse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a614d2f841477932133c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/71
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	ese_parat · p2 Parathyroid carcinoma; p9 PHPT/bone tissue https://www.ese-hormones.org/media/vdef53pz/eje-parat-publication-2019.pdf
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., C75.0 seulement, pas l’intégralité de C75 ni la malignité déduite de la seule hypercalcémie., Consensus primaire européen, pas relecture intégrale des19pages ; traitement non repris.

SSP 184 → E22 · differentiel

Gigantisme par excèsGH · Hypersécrétion de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c12eab8edbd7a6a5b605 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/107
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 184 → E23 · differentiel

DéficitGH · Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse

Croissance anormale : déficitGH versus gigantisme ; galactorrhée, troubles menstruels, infertilité, libido, céphalées ou champ visuel : hyperprolactinémie/hypophyse.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f5fc95d0c5562b2da0b4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/106
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	eth_hvl · §19.1–19.3;19.6–19.7 https://wp-prd.let.ethz.ch/WP0-CIPRF9881/chapter/erkrankungen-des-hypothalamus-hvl-systems/
Limites	Contexte clinique et confirmation diagnostique requis., Hyperprolactinémie possède aussi des causes médicamenteuses, hypothyroïdie et grossesse ; pas toujours prolactinome., Les sous-entités lues ne revalident pas toute la catégorie E22/E23.

SSP 217 → E15 · diagnostic

Coma hypoglycémique non diabétique · Coma hypoglycémique non diabétique

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6e79b54386a9a7c399b2 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/46
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Coma et hypoglycémie documentés ; code E15 confirmé OFS p151 ; ne pas confondre avec coma diabétique., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

SSP 219 → E16 · diagnostic

Hypoglycémie hors coma non diabétique · Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

Hypoglycémie à envisager devant sueurs, tachycardie, tremblements, fatigue, signes neurologiques, convulsions ou coma. L’enquête inclut dénutrition, maladies hépatiques, sepsis, médicaments et glycogénoses.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2e0888f84384ca19adc9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S05.json/graph/43
Propriétaire / statut	S05 · soutenu_pour_cette_entite_seulement
Source / section	cnpu_hypoglycemia · II.A, II.B, II.C.1 https://www.pedia-univ.fr/deuxieme-cycle/referentiel/endocrinologie-metabolisme/hypoglycemie
Limites	Hypoglycémie documentée ; distinguer diabète, nouveau-né et cause hormonale/tumorale., Source pédiatrique ; seuls symptômes/différentiels, aucun seuil ou traitement extrapolé. E15 seulement si coma hypoglycémique non diabétique selon OFS ; pas toute perte de connaissance., Pédiatrie ; ne pas généraliser ses seuils aux adultes ni aux nouveau-nés. Ici symptômes et démarche différentielle seulement.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 21

Annexe : graphe probant — N-07 — Néphrologie

103 arêtes issues de preuves-S04.json. Les arêtes de contexte/candidat restent explicitement séparées ; les renvois ne changent pas leur propriétaire.

SSP 4 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fcf4e7ec1d5f15222372 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/10
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 6 → N10 · differentiel

Néphrite tubulo-interstitielle aiguë · Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Fièvre/frissons, douleur flanc/lombes et nausée/vomissement orientent vers pyélonéphrite aiguë.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1ba5d69663f51af0b21a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/38
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_uti · 3.1 classification table1 ; 3.6.1.a–d pyelonephritis diagnosis ; 3.6.2 https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline

Trace	Détail
Source / section	icd_ti · N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n10-n16.htm
Limites	Tableau clinique/culture requis ; SSP82 ici douleur flanc/costovertébrale, pas lombalgie mécanique générique., Pas de recommandation antibiotique reprise. Dysurie isolée ne localise pas l'infection au rein ; N13 obstructif différentiel urgent., Source de codage seulement, croisée aux textes cliniques.

SSP 6 → N12 · candidat

Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique · Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

Cours existant préservé ; N12 = temporalité non précisée. Ne pas réutiliser la preuve de pyélonéphrite aiguë pour prétendre confirmer quatre SSP de N12.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-042ab6f414da69f727a5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/85
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 6 → N13 · differentiel

Uropathie obstructive et par reflux · Uropathie obstructive et par reflux

Une infection rénale sur obstacle doit être distinguée d'une pyélonéphrite sans obstruction.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cda0e864483ba0165788 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/45
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_uti · 3.1 classification table1 ; 3.6.1.a–d pyelonephritis diagnosis ; 3.6.2 https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline
Source / section	icd_ti · N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n10-n16.htm

Trace	Détail
Limites	Lien limité à pyonephrose/obstruction infectée, non à toute dysurie/pyurie ; renvoi urologie et infectiologie., Pas de recommandation antibiotique reprise. Dysurie isolée ne localise pas l'infection au rein ; N13 obstructif différentiel urgent., Source de codage seulement, croisée aux textes cliniques.

SSP 6 → N15 · candidat

Autres maladies rénales tubulo-interstitielles · Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

Abcès rénal/périnéphritique parmi sous-entités : envisager devant infection persistante compliquée, mais source spécifique à lire ; N15 n'est pas toute anomalie urinaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1f702d5e39a2279d9243 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/89
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 9 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9ff97950a4adeae0fcb8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/11
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 12 → C64 · differentiel

Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet · Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet

Des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs peuvent indiquer une extension veineuse d’une tumeur rénale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-640bce77f70b6fd08aa5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/52
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_rcc · 5.1 Symptoms ; 5.1.1 Physical examination ; 5.2 Imaging ; 5.3 Renal tumour biopsy https://uroweb.org/guidelines/renal-cell-carcinoma/chapter/diagnostic-evaluation
Limites	Situation particulière avec suspicion tumorale/veineuse ; pas cause habituelle de tout œdème., Les symptômes ne confirment pas à eux seuls un cancer. Rare triade non exigée. Catégorie dans S04 mais coordination urologie/oncologie.

SSP 12 → N00 · differentiel

Syndrome néphritique aigu · Syndrome néphritique aigu

Glomérulonéphrite peut donner baisse des urines, œdème et HTA.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-aa8d6c837a4a16a77682 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/26
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_gn · Symptoms ; When to get medical advice ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/glomerulonephritis/
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm

Trace	Détail
Limites	Précision aiguë démontrée avant N00 ; symptômes non spécifiques. Appui œdème/néphrite aiguë explicite dans NG148 pédiatrie1.1.2., Information patient, dernière revue affichée 2023 ; ne classe pas chaque maladie par durée ni histologie., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 12 → N04 · diagnostic

Syndrome néphrotique · Syndrome néphrotique

Syndrome néphrotique : pertes protéiques urinaires importantes, albumine basse, œdèmes souvent périoculaires et parfois baisse des urines.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6711abd58a0b27928b3a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/29
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_nephrotic · What problems can it cause? ; Diagnosing nephrotic syndrome ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/nephrotic-syndrome/
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Source symptomatique pédiatrique ; protéinurie seule ou œdème seul ne suffit pas. SSP172 = hypoalbuminémie et SSP63 = oligurie pendant rechute., Source pédiatrique (dernière revue affichée 2022, révision prévue 2025 dépassée) : pas extrapolation des doses ou du bilan complet adulte., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 12 → N17 · differentiel

Insuffisance rénale aiguë · Insuffisance rénale aiguë

Surcharge et œdème pulmonaire peuvent compliquer une IRA.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-93ec09da6ba827257e03 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/4

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Limites	Chercher surcharge avec altération aiguë fonction ; SSP206 concerne dyspnée aiguë sévère dans ce contexte., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique.

SSP 12 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-73ef8f2033938e991114 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/12
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 16 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c873ca8d2aaaafa509a8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/13

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 38 → N04 · diagnostic

Syndrome néphrotique · Syndrome néphrotique

Syndrome néphrotique : pertes protéiques urinaires importantes, albumine basse, œdèmes souvent périoculaires et parfois baisse des urines.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-bd2b45319fa0fb351c09 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/30
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_nephrotic · What problems can it cause? ; Diagnosing nephrotic syndrome ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/nephrotic-syndrome/
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Source symptomatique pédiatrique ; protéinurie seule ou œdème seul ne suffit pas. SSP172 = hypoalbuminémie et SSP63 = oligurie pendant rechute., Source pédiatrique (dernière revue affichée 2022, révision prévue 2025 dépassée) : pas extrapolation des doses ou du bilan complet adulte., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d’une présentation.

SSP 46 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1c327d63eff307a3fdcf docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/14
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 54 → C64 · differentiel

Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet · Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet

Cancer rénal peut se présenter par hématurie visible, douleur flanc ou masse abdominale, même si la triade est rare.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-139844bce944af311f43 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/50
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_rcc · 5.1 Symptoms ; 5.1.1 Physical examination ; 5.2 Imaging ; 5.3 Renal tumour biopsy https://uroweb.org/guidelines/renal-cell-carcinoma/chapter/diagnostic-evaluation
Limites	Imagerie et caractérisation de masse ; symptomatologie ne confirme pas malignité., Les symptômes ne confirment pas à eux seuls un cancer. Rare triade non exigée. Catégorie dans S04 mais coordination urologie/oncologie.

SSP 61 → N10 · differentiel

Néphrite tubulo-interstitielle aiguë · Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Fièvre/frissons, douleur flanc/lombes et nausée/vomissement orientent vers pyélonéphrite aiguë.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f581c61a9aa99898f9fe docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/39
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_uti · 3.1 classification table1 ; 3.6.1.a–d pyelonephritis diagnosis ; 3.6.2 https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline
Source / section	icd_ti · N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n10-n16.htm
Limites	Tableau clinique/culture requis ; SSP82 ici douleur flanc/costovertébrale, pas lombalgie mécanique générique., Pas de recommandation antibiotique reprise. Dysurie isolée ne localise pas l’infection au rein ; N13 obstructif différentiel urgent., Source de codage seulement, croisée aux textes cliniques.

SSP 61 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-779bc0c71143d704020c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/15
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 63 → N00 · differentiel

Syndrome néphritique aigu · Syndrome néphritique aigu

Glomérulonéphrite peut donner baisse des urines, œdème et HTA.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-58ef2109df098058cee0 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/25
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_gn · Symptoms ; When to get medical advice ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/glomerulonephritis/
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Précision aiguë démontrée avant N00 ; symptômes non spécifiques. Appui œdème/néphrite aiguë explicite dans NG148 pédiatrie1.1.2., Information patient, dernière revue affichée 2023 ; ne classe pas chaque maladie par durée ni histologie., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d’une présentation.

SSP 63 → N04 · diagnostic

Syndrome néphrotique · Syndrome néphrotique

Syndrome néphrotique : pertes protéiques urinaires importantes, albumine basse, œdèmes souvent périoculaires et parfois baisse des urines.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-19c54f7a28833732d819 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/31
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_nephrotic · What problems can it cause? ; Diagnosing nephrotic syndrome ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/nephrotic-syndrome/

Trace	Détail
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Source symptomatique pédiatrique ; protéinurie seule ou œdème seul ne suffit pas. SSP172 = hypoalbuminémie et SSP63 = oligurie pendant rechute., Source pédiatrique (dernière revue affichée 2022, révision prévue 2025 dépassée) : pas extrapolation des doses ou du bilan complet adulte., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 63 → N13 · differentiel

Uropathie obstructive et par reflux · Uropathie obstructive et par reflux

L'obstruction urinaire haute est une cause à rechercher devant IRA sans cause claire, par imagerie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-178aafd2aa55853060eb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/43
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Source / section	icd_ti · N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n10-n16.htm
Limites	Localisation haute/obstacle confirmé ; distinguer obstacle congénital Q62, calcul sans hydronéphrose N20, rétention basse., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique., Source de codage seulement, croisée aux textes cliniques.

SSP 63 → N17 · diagnostic

Insuffisance rénale aiguë · Insuffisance rénale aiguë

L'oligurie mesurée peut détecter une IRA.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f4921709d9170e51412d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/1

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Limites	La SSP regroupe quatre troubles : ce lien concerne oligurie/anurie, pas toute pollakiurie ou polyurie., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique.

SSP 63 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a8968fa03aea6d120a6e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/16
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 64 → C64 · differentiel

Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet · Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet

Cancer rénal peut se présenter par hématurie visible, douleur flanc ou masse abdominale, même si la triade est rare.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d5b8b2f3c2e66d68daff docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/49

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_rcc · 5.1 Symptoms ; 5.1.1 Physical examination ; 5.2 Imaging ; 5.3 Renal tumour biopsy https://uroweb.org/guidelines/renal-cell-carcinoma/chapter/diagnostic-evaluation
Limites	Imagerie et caractérisation de masse ; symptomatologie ne confirme pas malignité., Les symptômes ne confirment pas à eux seuls un cancer. Rare triade non exigée. Catégorie dans S04 mais coordination urologie/oncologie.

SSP 64 → C65 · differentiel

Tumeur maligne du bassinet · Tumeur maligne du bassinet

Les tumeurs urothéliales hautes donnent souvent hématurie et parfois douleur flanc par obstruction.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5278d7e8a3b2623649e3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/55
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_utuc · 5.1 Symptoms ; 5.4 Cytology ; 5.5 Ureteroscopy ; 5.7 Summary https://uroweb.org/guidelines/upper-urinary-tract-urothelial-cell-carcinoma/chapter/diagnosis
Limites	Siège bassinet pour C65, uretère pour C66 ; ne pas attribuer les deux comme diagnostics simultanés., C65 et C66 dépendent du siège bassinet/uretère ; même tableau ne permet pas de choisir entre eux. Coordination urologie/oncologie.

SSP 64 → C66 · differentiel

Tumeur maligne de l’uretère · Tumeur maligne de l’uretère

Les tumeurs urothéliales hautes donnent souvent hématurie et parfois douleur flanc par obstruction.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5e6d8c2982bb5ac1cfcd docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/58
Propriétaire / statut	S04 · confirme

Trace	Détail
Source / section	eau_utuc · 5.1 Symptoms ; 5.4 Cytology ; 5.5 Ureteroscopy ; 5.7 Summary https://uroweb.org/guidelines/upper-urinary-tract-urothelial-cell-carcinoma/chapter/diagnosis
Limites	Siège bassinet pour C65, uretère pour C66 ; ne pas attribuer les deux comme diagnostics simultanés., C65 et C66 dépendent du siège bassinet/uretère ; même tableau ne permet pas de choisir entre eux. Coordination urologie/oncologie.

SSP 64 → N00 · differentiel

Syndrome néphritique aigu · Syndrome néphritique aigu

Devant IRA inexpliquée avec hématurie et protéinurie, une néphrite aiguë/glomérulonéphrite est à envisager.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cce61db38fe65fd8a3c0 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/22
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Source / section	hug_immune · Types d’atteintes rénales ; Diagnostic, traitement et suivi https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-immunologiques-renales
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Syndrome glomérulaire aigu établi, non néphrite interstitielle ; symptômes isolés insuffisants., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique., Le texte ne distingue pas à lui seul aigu/chronique/rapidement progressif, ni les catégories N00–N08., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d’une présentation.

SSP 64 → N02 · candidat

Hématurie récidivante et persistante · Hématurie récidivante et persistante

Hématurie persistante : sélectionner seulement avec lésions morphologiques ; sinon R31. Bilan glomérulaire et source propre à l’entité encore requis.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8bcd2c0979fb93178705 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/73
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 64 → N07 · candidat

Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs · Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

Néphropathie héréditaire NEC : preuve génétique précise et exclusions à appliquer. Alport est explicitement exclu vers Q87.8 ; la source Alport ne valide pas N07.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-7e6f212c50b2d1133118 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/82
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 64 → N08 · differentiel

Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs · Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

Des atteintes glomérulaires secondaires au lupus, vascularites ou diabète peuvent se manifester par sang/protéines urinaires et altération fonctionnelle.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-528282baad050dc655f6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/35
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_immune · Types d’atteintes rénales ; Diagnostic, traitement et suivi https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-immunologiques-renales
Source / section	hug_diabetic · Symptômes et dépistage https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/nephropathie-diabetique

Trace	Détail
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	N08* seulement comme manifestation avec maladie causale documentée, codée séparément (p.ex. diabète/lupus), jamais autonome., Le texte ne distingue pas à lui seul aigu/chronique/rapidement progressif, ni les catégories N00–N08., N08* est une manifestation à associer au diabète causal, pas un diagnostic autonome de diabète., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 64 → N10 · diagnostic

Néphrite tubulo-interstitielle aiguë · Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Pyurie/hématurie et leucocytes/hématies urinaires font partie de l'évaluation diagnostique de pyélonéphrite.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ce9dd822e9a041fdb9f8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/41
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_uti · 3.1 classification table1 ; 3.6.1.a–d pyelonephritis diagnosis ; 3.6.2 https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline
Source / section	icd_ti · N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n10-n16.htm
Limites	Dysurie seule ne prouve pas localisation rénale ; contexte clinique et culture., Pas de recommandation antibiotique reprise. Dysurie isolée ne localise pas l'infection au rein ; N13 obstructif différentiel urgent., Source de codage seulement, croisée aux textes cliniques.

SSP 64 → N12 · candidat

Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique · Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

Cours existant préservé ; N12 = temporalité non précisée. Ne pas réutiliser la preuve de pyélonéphrite aiguë pour prétendre confirmer quatre SSP de N12.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3c0a19963743b0fe9f9f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/86
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 64 → N13 · differentiel

Uropathie obstructive et par reflux · Uropathie obstructive et par reflux

Une infection rénale sur obstacle doit être distinguée d’une pyélonéphrite sans obstruction.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8457ad403472c1a493a8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/46
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_uti · 3.1 classification table1 ; 3.6.1.a–d pyelonephritis diagnosis ; 3.6.2 https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline
Source / section	icd_ti · N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n10-n16.htm
Limites	Lien limité à pyonephrose/obstruction infectée, non à toute dysurie/pyurie ; renvoi urologie et infectiologie., Pas de recommandation antibiotique reprise. Dysurie isolée ne localise pas l’infection au rein ; N13 obstructif différentiel urgent., Source de codage seulement, croisée aux textes cliniques.

SSP 64 → N28 · candidat

Autres affections du rein et de l’uretère, non classées ailleurs · Autres affections du rein et de l’uretère, non classées ailleurs

Important à préciser par sous-entité : infarctus rénal (douleur flanc/hématurie), kyste acquis ou autre lésion. Source clinique propre encore à lire ; ne pas regrouper sous une seule preuve.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-56101dc825e2ef7fec21 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/95
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie

Trace	Détail
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 64 → Q61 · differentiel

Maladies kystiques du rein · Maladies kystiques du rein

ADPKD peut se manifester par hématurie, douleur flanc/lombes, HTA et perte fonctionnelle.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-be3ff46a479bee3b87c5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/61
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_adpkd · Problems caused by ADPKD ; Pain ; Blood in your urine ; High blood pressure ; Chronic kidney disease https://www.nhs.uk/conditions/autosomal-dominant-polycystic-kidney-disease-adpkd/symptoms/
Source / section	hug_genetic · Présentation ; Consultation des maladies rénales génétiques https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-renales-genetiques
Limites	Lien à sous-ensemble ADPKD, imagerie/histoire familiale nécessaires ; kyste acquis N28.1 distinct., Sous-ensemble ADPKD de Q61, pas preuve pour toutes maladies kystiques. Revue affichée 2023, échéance revue 2026 dépassée., Preuve de contexte génétique, pas preuve que chaque anomalie congénitale impose un test ni que toute maladie héréditaire relève de N07.

SSP 64 → S37 · differentiel

Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires · Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Après traumatisme abdominal/pelvien, lésion rein/uretère à envisager ; hématurie fréquente mais absence ne l’exclut pas.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-803d16c90ea4e6bdf4d8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/69
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_trauma · 4.1.2.a–b Renal trauma evaluation ; 4.2.2.a ureteral trauma https://uroweb.org/guidelines/urological-trauma/chapter/urogenital-trauma-guidelines

Trace	Détail
Limites	S37 à trois caractères regroupe plusieurs organes ; rôle S04 limité rein/uretère, urologie/traumatologie en coordination., S37 regroupe plusieurs organes : ce lien S04 concerne rein/uretère ; lésions vessie/urètre relèvent de l’urologie.

SSP 70 → N07 · candidat

Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs · Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

Néphropathie héréditaire NEC : preuve génétique précise et exclusions à appliquer. Alport est explicitement exclu vers Q87.8 ; la source Alport ne valide pas N07.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d93dfeea8d46b370f359 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/81
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 70 → Q61 · contexte

Maladies kystiques du rein · Maladies kystiques du rein

Le diagnostic d’une maladie rénale kystique héréditaire peut motiver une consultation de néphrogénétique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3f7554abcce19c3d4a32 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/65
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_genetic · Présentation ; Consultation des maladies rénales génétiques https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-renales-genetiques
Limites	Conseil individualisé, pas présomption que tout kyste est génétique., Preuve de contexte génétique, pas preuve que chaque anomalie congénitale impose un test ni que toute maladie héréditaire relève de N07.

SSP 82 → C64 · differentiel

Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet · Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet

Cancer rénal peut se présenter par hématurie visible, douleur flanc ou masse abdominale, même si la triade est rare.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b5131aa68ffb9adfc1f7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/51
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_rcc · 5.1 Symptoms ; 5.1.1 Physical examination ; 5.2 Imaging ; 5.3 Renal tumour biopsy https://uroweb.org/guidelines/renal-cell-carcinoma/chapter/diagnostic-evaluation
Limites	Imagerie et caractérisation de masse ; symptomatologie ne confirme pas malignité., Les symptômes ne confirment pas à eux seuls un cancer. Rare triade non exigée. Catégorie dans S04 mais coordination urologie/oncologie.

SSP 82 → C65 · differentiel

Tumeur maligne du bassinet · Tumeur maligne du bassinet

Les tumeurs urothéliales hautes donnent souvent hématurie et parfois douleur flanc par obstruction.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a2490af6dd3b48c301c5 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/56
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_utuc · 5.1 Symptoms ; 5.4 Cytology ; 5.5 Ureteroscopy ; 5.7 Summary https://uroweb.org/guidelines/upper-urinary-tract-urothelial-cell-carcinoma/chapter/diagnosis
Limites	Siège bassinet pour C65, uretère pour C66 ; ne pas attribuer les deux comme diagnostics simultanés., C65 et C66 dépendent du siège bassinet/uretère ; même tableau ne permet pas de choisir entre eux. Coordination urologie/oncologie.

SSP 82 → C66 · differentiel

Tumeur maligne de l’uretère · Tumeur maligne de l’uretère

Les tumeurs urothéliales hautes donnent souvent hématurie et parfois douleur flanc par obstruction.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8920592408527c607f63 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/59
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_utuc · 5.1 Symptoms ; 5.4 Cytology ; 5.5 Ureteroscopy ; 5.7 Summary https://uroweb.org/guidelines/upper-urinary-tract-urothelial-cell-carcinoma/chapter/diagnosis
Limites	Siège bassinet pour C65, uretère pour C66 ; ne pas attribuer les deux comme diagnostics simultanés., C65 et C66 dépendent du siège bassinet/uretère ; même tableau ne permet pas de choisir entre eux. Coordination urologie/oncologie.

SSP 82 → N10 · differentiel

Néphrite tubulo-interstitielle aiguë · Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Fièvre/frissons, douleur flanc/lombes et nausée/vomissement orientent vers pyélonéphrite aiguë.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fb922d46d0f367aeae18 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/40
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_uti · 3.1 classification table1 ; 3.6.1.a–d pyelonephritis diagnosis ; 3.6.2 https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline
Source / section	icd_ti · N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n10-n16.htm
Limites	Tableau clinique/culture requis ; SSP82 ici douleur flanc/costovertébrale, pas lombalgie mécanique générique., Pas de recommandation antibiotique reprise. Dysurie isolée ne localise pas l’infection au rein ; N13 obstructif différentiel urgent., Source de codage seulement, croisée aux textes cliniques.

SSP 82 → N15 · candidat

Autres maladies rénales tubulo-interstitielles · Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

Abcès rénal/périnéphritique parmi sous-entités : envisager devant infection persistante compliquée, mais source spécifique à lire ; N15 n’est pas toute anomalie urinaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6f3a0ec3ff85898d9093 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/90
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 82 → N28 · candidat

Autres affections du rein et de l’uretère, non classées ailleurs · Autres affections du rein et de l’uretère, non classées ailleurs

Important à préciser par sous-entité : infarctus rénal (douleur flanc/hématurie), kyste acquis ou autre lésion. Source clinique propre encore à lire ; ne pas regrouper sous une seule preuve.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2d484cda9dc1b1b06fc3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/96
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 82 → Q61 · differentiel

Maladies kystiques du rein · Maladies kystiques du rein

ADPKD peut se manifester par hématurie, douleur flanc/lombes, HTA et perte fonctionnelle.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-306b207cbf11f55fc23a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/62
Propriétaire / statut	S04 · confirme

Trace	Détail
Source / section	nhs_adpkd · Problems caused by ADPKD ; Pain ; Blood in your urine ; High blood pressure ; Chronic kidney disease https://www.nhs.uk/conditions/autosomal-dominant-polycystic-kidney-disease-adpkd/symptoms/
Source / section	hug_genetic · Présentation ; Consultation des maladies rénales génétiques https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-renales-genetiques
Limites	Lien à sous-ensemble ADPKD, imagerie/histoire familiale nécessaires ; kyste acquis N28.1 distinct., Sous-ensemble ADPKD de Q61, pas preuve pour toutes maladies kystiques. Revue affichée 2023, échéance revue 2026 dépassée., Preuve de contexte génétique, pas preuve que chaque anomalie congénitale impose un test ni que toute maladie héréditaire relève de N07.

SSP 85 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-61da9ea19c107f8b4faa docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/17
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 101 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c865d10f76369438a8ab docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/18
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 102 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-457ced75a3bb32f083bb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/19
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 106 → S37 · differentiel

Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires · Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Après traumatisme abdominal/pelvien, lésion rein/uretère à envisager ; hématurie fréquente mais absence ne l’exclut pas.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cebb458087f017934cd8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/68
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_trauma · 4.1.2.a–b Renal trauma evaluation ; 4.2.2.a ureteral trauma https://uroweb.org/guidelines/urological-trauma/chapter/urogenital-trauma-guidelines
Limites	S37 à trois caractères regroupe plusieurs organes ; rôle S04 limité rein/uretère, urologie/traumatologie en coordination., S37 regroupe plusieurs organes : ce lien S04 concerne rein/uretère ; lésions vessie/urètre relèvent de l’urologie.

SSP 131 → N00 · differentiel

Syndrome néphritique aigu · Syndrome néphritique aigu

Glomérulonéphrite peut donner baisse des urines, œdème et HTA.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f9f813477ceb3fb3c8b6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/28
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_gn · Symptoms ; When to get medical advice ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/glomerulonephritis/
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Précision aiguë démontrée avant N00 ; symptômes non spécifiques. Appui œdème/néphrite aiguë explicite dans NG148 pédiatrie1.1.2., Information patient, dernière revue affichée 2023 ; ne classe pas chaque maladie par durée ni histologie., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d’une présentation.

SSP 131 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

L'HTA peut révéler une MRC et en est aussi un facteur de risque.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8858f1a225af652b7758 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/9
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Ne pas attribuer toute HTA à la maladie rénale ; considérer causes primaires et secondaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 131 → Q61 · differentiel

Maladies kystiques du rein · Maladies kystiques du rein

ADPKD peut se manifester par hématurie, douleur flanc/lombes, HTA et perte fonctionnelle.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-97caa0a7d20f4faa7beb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/63
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_adpkd · Problems caused by ADPKD ; Pain ; Blood in your urine ; High blood pressure ; Chronic kidney disease https://www.nhs.uk/conditions/autosomal-dominant-polycystic-kidney-disease-adpkd/symptoms/
Source / section	hug_genetic · Présentation ; Consultation des maladies rénales génétiques https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-renales-genetiques
Limites	Lien à sous-ensemble ADPKD, imagerie/histoire familiale nécessaires ; kyste acquis N28.1 distinct., Sous-ensemble ADPKD de Q61, pas preuve pour toutes maladies kystiques. Revue affichée 2023, échéance revue 2026 dépassée., Preuve de contexte génétique, pas preuve que chaque anomalie congénitale impose un test ni que toute maladie héréditaire relève de N07.

SSP 146 → C64 · differentiel

Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet · Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet

Des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs peuvent indiquer une extension veineuse d’une tumeur rénale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-51b31c60691d88411faa docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/53
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_rcc · 5.1 Symptoms ; 5.1.1 Physical examination ; 5.2 Imaging ; 5.3 Renal tumour biopsy https://uroweb.org/guidelines/renal-cell-carcinoma/chapter/diagnostic-evaluation
Limites	Situation particulière avec suspicion tumorale/veineuse ; pas cause habituelle de tout œdème., Les symptômes ne confirment pas à eux seuls un cancer. Rare triade non exigée. Catégorie dans S04 mais coordination urologie/oncologie.

SSP 146 → N00 · differentiel

Syndrome néphritique aigu · Syndrome néphritique aigu

Glomérulonéphrite peut donner baisse des urines, œdème et HTA.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-577556366646a5effe81 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/27
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_gn · Symptoms ; When to get medical advice ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/glomerulonephritis/
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm

Trace	Détail
Limites	Précision aiguë démontrée avant N00 ; symptômes non spécifiques. Appui œdème/néphrite aiguë explicite dans NG148 pédiatrie1.1.2., Information patient, dernière revue affichée 2023 ; ne classe pas chaque maladie par durée ni histologie., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 146 → N04 · diagnostic

Syndrome néphrotique · Syndrome néphrotique

Syndrome néphrotique : pertes protéiques urinaires importantes, albumine basse, œdèmes souvent périoculaires et parfois baisse des urines.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-699ee4d04f2b48c522e6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/32
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_nephrotic · What problems can it cause? ; Diagnosing nephrotic syndrome ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/nephrotic-syndrome/
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Source symptomatique pédiatrique ; protéinurie seule ou œdème seul ne suffit pas. SSP172 = hypoalbuminémie et SSP63 = oligurie pendant rechute., Source pédiatrique (dernière revue affichée 2022, révision prévue 2025 dépassée) : pas extrapolation des doses ou du bilan complet adulte., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 146 → N17 · differentiel

Insuffisance rénale aiguë · Insuffisance rénale aiguë

Surcharge et œdème pulmonaire peuvent compliquer une IRA.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-eeb9e1c7562b570cb71c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/5

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Limites	Chercher surcharge avec altération aiguë fonction ; SSP206 concerne dyspnée aiguë sévère dans ce contexte., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique.

SSP 146 → N18 · differentiel

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

Le texte HUG énumère fatigue, prurit, œdèmes, perte appétit, nausées/vomissements, dyspnée, mictions nocturnes, crampes, céphalées et troubles cognitifs comme manifestations souvent tardives.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fea94c54306fe8e54383 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/20
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Limites	Symptômes non spécifiques ; SSP63 = mictions fréquentes/nocturnes et SSP85 = crampes seulement. Bilan objectif/chronicité nécessaires., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris.

SSP 150 → N17 · differentiel

Insuffisance rénale aiguë · Insuffisance rénale aiguë

L’acidose métabolique fait partie des complications rénales aiguës citées.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c86f35d14453388d8a2a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/3

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Limites	Pas d’attribution de toute anomalie gazométrique à l’IRA., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique.

SSP 150 → N25 · differentiel

Affections dues à une tubulopathie · Affections dues à une tubulopathie

Une acidose tubulaire rénale distale peut donner acidose métabolique et hypokaliémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f2ef7347efd381eb1274 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/47
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	erk_drta · Abstract réellement lu ; notice recommandation ERKNet aussi lue https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=DOI:10.1093/ndt/gfab171&format=json&resultType=core
Source / section	icd_other · N25,N26,N27,N28,N29 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n25-n29.htm
Limites	Sous-entité N25.8 ; abstract seulement pour présentation, diagnostic différentiel de l’acidose à compléter. Ne pas ranger toutes tubulopathies/génétiques sous N25., Résumé uniquement : établit acidose/hypokaliémie comme présentation simple, pas critères diagnostiques détaillés ni exclusion acidose digestive. Article doi10.1093/ndt/gfab171 ; page ERKNet https://www.erknet.org/guidelines-pathways/tubulopathies/distal-renal-tubular-acidosis, Source de codage seulement, aucune preuve que N25–N29 expliquent collectivement incontinence/rétention/hématurie.

SSP 156 → N17 · differentiel

Insuffisance rénale aiguë · Insuffisance rénale aiguë

L’hyperkaliémie peut compliquer l’IRA et justifie de chercher une atteinte aiguë de fonction.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-afb3cd36ab2401f4e75b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/2

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Limites	Lien limité à hyperkaliémie, pas tous les troubles électrolytiques., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique.

SSP 156 → N25 · differentiel

Affections dues à une tubulopathie · Affections dues à une tubulopathie

Une acidose tubulaire rénale distale peut donner acidose métabolique et hypokaliémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f74f34804ee2eae80943 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/48
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	erk_drta · Abstract réellement lu ; notice recommandation ERKNet aussi lue https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/search?query=DOI:10.1093/ndt/gfab171&format=json&resultType=core
Source / section	icd_other · N25,N26,N27,N28,N29 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n25-n29.htm
Limites	Sous-entité N25.8 ; abstract seulement pour présentation, diagnostic différentiel de l’acidose à compléter. Ne pas ranger toutes tubulopathies/génétiques sous N25., Résumé uniquement : établit acidose/hypokaliémie comme présentation simple, pas critères diagnostiques détaillés ni exclusion acidose digestive. Article doi10.1093/ndt/gfab171 ; page ERKNet https://www.erknet.org/guidelines-pathways/tubulopathies/distal-renal-tubular-acidosis, Source de codage seulement, aucune preuve que N25–N29 expliquent collectivement incontinence/rétention/hématurie.

SSP 159 → C64 · diagnostic

Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet · Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet

L’histologie d’une masse rénale peut en préciser la nature après évaluation.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-167b534af39697924985 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/54
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_rcc · 5.1 Symptoms ; 5.1.1 Physical examination ; 5.2 Imaging ; 5.3 Renal tumour biopsy https://uroweb.org/guidelines/renal-cell-carcinoma/chapter/diagnostic-evaluation
Limites	Histologie interprétée avec siège et imagerie ; pas toute anomalie histologique générale., Les symptômes ne confirment pas à eux seuls un cancer. Rare triade non exigée. Catégorie dans S04 mais coordination urologie/oncologie.

SSP 159 → C65 · diagnostic

Tumeur maligne du bassinet · Tumeur maligne du bassinet

Cytologie/biopsie urétéroscopique contribuent au diagnostic tumoral urothélial haut.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d27579120ea72120eaf0 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/57
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_utuc · 5.1 Symptoms ; 5.4 Cytology ; 5.5 Ureteroscopy ; 5.7 Summary https://uroweb.org/guidelines/upper-urinary-tract-urothelial-cell-carcinoma/chapter/diagnosis
Limites	Diagnostic et localisation précis ; cytologie positive seule ne distingue pas C65 et C66., C65 et C66 dépendent du siège bassinet/uretère ; même tableau ne permet pas de choisir entre eux. Coordination urologie/oncologie.

SSP 159 → C66 · diagnostic

Tumeur maligne de l’uretère · Tumeur maligne de l’uretère

Cytologie/biopsie urétéroscopique contribuent au diagnostic tumoral urothélial haut.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8c3afec2ecb850227406 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/60
Propriétaire / statut	S04 · confirme

Trace	Détail
Source / section	eau_utuc · 5.1 Symptoms ; 5.4 Cytology ; 5.5 Ureteroscopy ; 5.7 Summary https://uroweb.org/guidelines/upper-urinary-tract-urothelial-cell-carcinoma/chapter/diagnosis
Limites	Diagnostic et localisation précis ; cytologie positive seule ne distingue pas C65 et C66., C65 et C66 dépendent du siège bassinet/uretère ; même tableau ne permet pas de choisir entre eux. Coordination urologie/oncologie.

SSP 161 → N00 · differentiel

Syndrome néphritique aigu · Syndrome néphritique aigu

Devant IRA inexpliquée avec hématurie et protéinurie, une néphrite aiguë/glomérulonéphrite est à envisager.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1e3e9e4757b562879a27 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/23
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Source / section	hug_immune · Types d’atteintes rénales ; Diagnostic, traitement et suivi https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-immunologiques-renales
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Syndrome glomérulaire aigu établi, non néphrite interstitielle ; symptômes isolés insuffisants., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique., Le texte ne distingue pas à lui seul aigu/chronique/rapidement progressif, ni les catégories N00–N08., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d’une présentation.

SSP 161 → N01 · candidat

Syndrome néphritique d’évolution rapide · Syndrome néphritique d’évolution rapide

Priorité clinique : syndrome néphritique rapidement progressif devant dégradation rapide avec sédiment actif ; source spécifiant diagnostic/tempo à lire. La néphrite aiguë générique ne valide pas N01.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0ec1b10f86ea78b8613c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/70
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 161 → N03 · candidat

Syndrome néphritique chronique · Syndrome néphritique chronique

Chronique non équivalent à toute MRC : démontrer syndrome néphritique chronique, lire source spécifique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0ecdbea46df2665bf645 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/75
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 161 → N08 · differentiel

Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs · Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

Des atteintes glomérulaires secondaires au lupus, vascularites ou diabète peuvent se manifester par sang/protéines urinaires et altération fonctionnelle.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-bfe4017315260de3fd58 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/36
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_immune · Types d’atteintes rénales ; Diagnostic, traitement et suivi https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-immunologiques-renales
Source / section	hug_diabetic · Symptômes et dépistage https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/nephropathie-diabetique

Trace	Détail
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	N08* seulement comme manifestation avec maladie causale documentée, codée séparément (p.ex. diabète/lupus), jamais autonome., Le texte ne distingue pas à lui seul aigu/chronique/rapidement progressif, ni les catégories N00–N08., N08* est une manifestation à associer au diabète causal, pas un diagnostic autonome de diabète., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 161 → N11 · candidat

Néphrite tubulo-interstitielle chronique · Néphrite tubulo-interstitielle chronique

Néphrite interstitielle chronique/reflux avec infection chronique : source diagnostique propre et chronicité encore à vérifier.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1cfe8bf03d62b9ad58cc docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/84
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 161 → N13 · differentiel

Uropathie obstructive et par reflux · Uropathie obstructive et par reflux

L'obstruction urinaire haute est une cause à rechercher devant IRA sans cause claire, par imagerie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f41d9e26d626048bc3d6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/44
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations

Trace	Détail
Source / section	icd_ti · N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n10-n16.htm
Limites	Localisation haute/obstacle confirmé ; distinguer obstacle congénital Q62, calcul sans hydronéphrose N20, rétention basse., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique., Source de codage seulement, croisée aux textes cliniques.

SSP 161 → N14 · candidat

Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds · Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

Atteinte médicamenteuse/toxique importante dans différentiels IRA/néphrite interstitielle ; HUG général lu, mais preuve spécifique médicament→lésion tubulo-interstitielle et présentation à compléter.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c6b816cc4e377a147189 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/87
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 161 → N16 · candidat

Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs · Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

Manifestation tubulo-interstitielle secondaire N16* ; maladie sous-jacente et atteinte définie à documenter, source spécifique non vérifiée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4f73806712cdb439e600 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/91
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 161 → N17 · diagnostic

Insuffisance rénale aiguë · Insuffisance rénale aiguë

Une élévation aiguë de la créatinine est un critère de détection d’IRA.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0a9cfb81f156c9affe17 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/0
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Limites	Cinétique aiguë confirmée ; distinguer MRC et IRA sur MRC., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique.

SSP 161 → N18 · diagnostic

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

La MRC se recherche par fonction rénale et protéines urinaires, avec chronicité documentée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3d11c5eabc3ec56868e0 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/7
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Source / section	nice_ckd · 1.1.10–1.1.25 ; 1.2.1 ; 1.5.5 https://www.nice.org.uk/guidance/ng203/chapter/Recommendations
Limites	Atteinte persistante >3 mois ; un résultat isolé ne suffit pas., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris., Une anomalie protéinurie ou hématurie seule ne prouve pas N06 ou N02 ; distinction clinique puis codage requis.

SSP 161 → N19 · candidat

Insuffisance rénale, sans précision · Insuffisance rénale, sans précision

Insuffisance rénale non précisée : n’ajoute pas une maladie distincte à N17/N18 ; catégorie de recours, ne pas compter gain de SSP.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a654db32b82e2097941a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/92
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 161 → N26 · candidat

Rein scléreux, sans précision · Rein scléreux, sans précision

Rein scléreux : morphologie et cause à documenter ; aucun argument lu n’en fait un diagnostic de première ligne de dysurie/incontinence/rétention.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9a555cd26da78e032621 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/93
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 161 → N27 · candidat

Petit rein de cause inconnue · Petit rein de cause inconnue

Cours existant préservé ; petit rein de cause inconnue n’est pas une explication automatique des SSP64/76/77, ni une hypoplasie congénitale démontrée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3c19e311c49c0e044d52 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/94
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 161 → N29 · candidat

Autres affections du rein et de l’uretère au cours de maladies classées ailleurs · Autres affections du rein et de l’uretère au cours de maladies classées ailleurs

Cours existant préservé ; N29* exige maladie causale et manifestation précise. Pas de preuve symptomatique couvrant 64/76/77.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d4e7fceb186d7468b7fc docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/97
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 161 → Q60 · differentiel

Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal · Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal

Des défauts de développement rénal, notamment bilatéraux, peuvent entraîner une insuffisance rénale chez l’enfant.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fabcee28fe61b79620a8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/67
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	erk_dysplasia · PDF pp3–4 résumé/introduction ; pp8–11 échographie pré/postnatale ; pp12–13 fonction/BP/protéinurie ; pp16–17 conseil génétique https://www.erknet.org/fileadmin/files/pdf/Kohl_et_al.__2022__NDT.pdf
Limites	Contexte morphologique précis ; petits reins d’origine inconnue N27 et dysplasie kystique Q61 ne sont pas synonymes., Q60 concerne hypoplasie/agénésie ; dysplasie kystique peut relever de Q61 : ne pas coder toute dysplasie Q60, ni petit rein N27 si cause congénitale précisée.

SSP 161 → Q61 · differentiel

Maladies kystiques du rein · Maladies kystiques du rein

ADPKD peut se manifester par hématurie, douleur flanc/lombes, HTA et perte fonctionnelle.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-565ff02b565a2fde1f52 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/64

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nhs_adpkd · Problems caused by ADPKD ; Pain ; Blood in your urine ; High blood pressure ; Chronic kidney disease https://www.nhs.uk/conditions/autosomal-dominant-polycystic-kidney-disease-adpkd/symptoms/
Source / section	hug_genetic · Présentation ; Consultation des maladies rénales génétiques https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-renales-genetiques
Limites	Lien à sous-ensemble ADPKD, imagerie/histoire familiale nécessaires ; kyste acquis N28.1 distinct., Sous-ensemble ADPKD de Q61, pas preuve pour toutes maladies kystiques. Revue affichée 2023, échéance revue 2026 dépassée., Preuve de contexte génétique, pas preuve que chaque anomalie congénitale impose un test ni que toute maladie héréditaire relève de N07.

SSP 161 → Q62 · candidat

Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l’uretère · Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l’uretère

Malformation obstructive congénitale : diagnostic échographique/anténatal et causes à documenter. L’obstruction acquise ne valide pas Q62.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ac57b763b2c8a8038706 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/99
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 164 → N01 · candidat

Syndrome néphritique d’évolution rapide · Syndrome néphritique d’évolution rapide

Priorité clinique : syndrome néphritique rapidement progressif devant dégradation rapide avec sédiment actif ; source spécifiant diagnostic/tempo à lire. La néphrite aiguë générique ne valide pas N01.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-927c3f9e5023ce37f433 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/71

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 164 → N02 · candidat

Hématurie récidivante et persistante · Hématurie récidivante et persistante

Hématurie persistante : sélectionner seulement avec lésions morphologiques ; sinon R31. Bilan glomérulaire et source propre à l'entité encore requis.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-50e7c0ec23c0b468d594 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/74
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 164 → N03 · candidat

Syndrome néphritique chronique · Syndrome néphritique chronique

Chronique non équivalent à toute MRC : démontrer syndrome néphritique chronique, lire source spécifique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-13218aa1c2c865a5e0df docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/76
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 164 → N05 · candidat

Syndrome néphritique, sans précision · Syndrome néphritique, sans précision

Code de syndrome néphritique sans précision ; ne pas produire une catégorie supplémentaire pour doubler N00/N03. Éligibilité clinique non vérifiée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-69d7e48b246a4cdc9d2e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/78
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 164 → N10 · diagnostic

Néphrite tubulo-interstitielle aiguë · Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Pyurie/hématurie et leucocytes/hématies urinaires font partie de l’évaluation diagnostique de pyélonéphrite.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-44c0afaa5baea2c7d147 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/42
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	eau_uti · 3.1 classification table1 ; 3.6.1.a–d pyelonephritis diagnosis ; 3.6.2 https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline
Source / section	icd_ti · N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16 https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n10-n16.htm
Limites	Dysurie seule ne prouve pas localisation rénale ; contexte clinique et culture., Pas de recommandation antibiotique reprise. Dysurie isolée ne localise pas l’infection au rein ; N13 obstructif différentiel urgent., Source de codage seulement, croisée aux textes cliniques.

SSP 172 → N04 · diagnostic

Syndrome néphrotique · Syndrome néphrotique

Syndrome néphrotique : pertes protéiques urinaires importantes, albumine basse, œdèmes souvent périoculaires et parfois baisse des urines.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6169e4dc4a3c66a795a7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/33
Propriétaire / statut	S04 · confirme

Trace	Détail
Source / section	nhs_nephrotic · What problems can it cause? ; Diagnosing nephrotic syndrome ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/nephrotic-syndrome/
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Source symptomatique pédiatrique ; protéinurie seule ou œdème seul ne suffit pas. SSP172 = hypoalbuminémie et SSP63 = oligurie pendant rechute., Source pédiatrique (dernière revue affichée 2022, révision prévue 2025 dépassée) : pas extrapolation des doses ou du bilan complet adulte., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 173 → N00 · differentiel

Syndrome néphritique aigu · Syndrome néphritique aigu

Devant IRA inexpliquée avec hématurie et protéinurie, une néphrite aiguë/glomérulonéphrite est à envisager.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a53dbb06fd241f07e88a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/24
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Source / section	hug_immune · Types d'atteintes rénales ; Diagnostic, traitement et suivi https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-immunologiques-renales
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Syndrome glomérulaire aigu établi, non néphrite interstitielle ; symptômes isolés insuffisants., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique., Le texte ne distingue pas à lui seul aigu/chronique/rapidement progressif, ni les catégories N00–N08., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 173 → N01 · candidat

Syndrome néphritique d’évolution rapide · Syndrome néphritique d’évolution rapide

Priorité clinique : syndrome néphritique rapidement progressif devant dégradation rapide avec sédiment actif ; source spécifiant diagnostic/tempo à lire. La néphrite aiguë générique ne valide pas N01.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1b4335cbdb7d0a28de63 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/72
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 173 → N03 · candidat

Syndrome néphritique chronique · Syndrome néphritique chronique

Chronique non équivalent à toute MRC : démontrer syndrome néphritique chronique, lire source spécifique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b588e8c60f11900d465d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/77
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 173 → N04 · diagnostic

Syndrome néphrotique · Syndrome néphrotique

Syndrome néphrotique : pertes protéiques urinaires importantes, albumine basse, œdèmes souvent périoculaires et parfois baisse des urines.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6cda08a92411310f0653 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/34
Propriétaire / statut	S04 · confirme

Trace	Détail
Source / section	nhs_nephrotic · What problems can it cause? ; Diagnosing nephrotic syndrome ; Causes https://www.nhs.uk/conditions/nephrotic-syndrome/
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm
Limites	Source symptomatique pédiatrique ; protéinurie seule ou œdème seul ne suffit pas. SSP172 = hypoalbuminémie et SSP63 = oligurie pendant rechute., Source pédiatrique (dernière revue affichée 2022, révision prévue 2025 dépassée) : pas extrapolation des doses ou du bilan complet adulte., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 173 → N05 · candidat

Syndrome néphritique, sans précision · Syndrome néphritique, sans précision

Code de syndrome néphritique sans précision ; ne pas produire une catégorie supplémentaire pour doubler N00/N03. Éligibilité clinique non vérifiée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9b0f629787dd49b0984f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/79
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 173 → N06 · candidat

Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées · Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

Protéinurie isolée avec morphologie documentée ; sinon R80/N39.1/N39.2 selon cas. Source clinique propre non vérifiée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b40bd8462fabd38fb2af docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/80
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie

Trace	Détail
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 173 → N07 · candidat

Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs · Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

Néphropathie héréditaire NEC : preuve génétique précise et exclusions à appliquer. Alport est explicitement exclu vers Q87.8 ; la source Alport ne valide pas N07.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-02969174078576498d0f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/83
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 173 → N08 · differentiel

Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs · Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

Des atteintes glomérulaires secondaires au lupus, vascularites ou diabète peuvent se manifester par sang/protéines urinaires et altération fonctionnelle.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-02c1dcee7e5c171bc912 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/37
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_immune · Types d’atteintes rénales ; Diagnostic, traitement et suivi https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/maladies-immunologiques-renales
Source / section	hug_diabetic · Symptômes et dépistage https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/nephropathie-diabetique
Source / section	icd_glom · Catégories N00–N08, inclusions/exclusions et modificateurs https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/block-n00-n08.htm

Trace	Détail
Limites	N08* seulement comme manifestation avec maladie causale documentée, codée séparément (p.ex. diabète/lupus), jamais autonome., Le texte ne distingue pas à lui seul aigu/chronique/rapidement progressif, ni les catégories N00–N08., N08* est une manifestation à associer au diabète causal, pas un diagnostic autonome de diabète., Source de codage européenne GM2024 ; les libellés français OFS locaux restent référence suisse. Ce texte ne vaut pas preuve médicale d'une présentation.

SSP 173 → N18 · diagnostic

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

La MRC se recherche par fonction rénale et protéines urinaires, avec chronicité documentée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-bb1be607177641d51129 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/8
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_ckd · Comment découvre-t-on… : analyse sang/urine, bilan HTA, apparition de symptômes https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/depistage-diagnostic-insuffisance-renale-chronique
Source / section	nice_ckd · 1.1.10–1.1.25 ; 1.2.1 ; 1.5.5 https://www.nice.org.uk/guidance/ng203/chapter/Recommendations
Limites	Atteinte persistante >3 mois ; un résultat isolé ne suffit pas., Information institutionnelle patient ; symptômes non spécifiques, souvent tardifs. Aucun seuil thérapeutique repris., Une anomalie protéinurie ou hématurie seule ne prouve pas N06 ou N02 ; distinction clinique puis codage requis.

SSP 177 → Q60 · contexte

Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal · Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal

L'évaluation échographique pré/postnatale des anomalies rénales inclut hypoplasie/agénésie et différencie d'autres malformations.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-0b912c79a0dac4f78045 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/66
Propriétaire / statut	S04 · confirme

Trace	Détail
Source / section	erk_dysplasia · PDF pp3–4 résumé/introduction ; pp8–11 échographie pré/postnatale ; pp12–13 fonction/BP/protéinurie ; pp16–17 conseil génétique https://www.erknet.org/fileadmin/files/pdf/Kohl_et_al.__2022__NDT.pdf
Limites	Q60 limité au défaut de développement correspondant ; ne pas coder toute dysplasie/kystes Q60. Contexte malformation prénatale seulement., Q60 concerne hypoplasie/agénésie ; dysplasie kystique peut relever de Q61 : ne pas coder toute dysplasie Q60, ni petit rein N27 si cause congénitale précisée.

SSP 177 → Q62 · candidat

Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l’uretère · Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l’uretère

Malformation obstructive congénitale : diagnostic échographique/anténatal et causes à documenter. L’obstruction acquise ne valide pas Q62.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f9ea6455844e85952f89 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/98
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 177 → Q63 · candidat

Autres malformations congénitales du rein · Autres malformations congénitales du rein

Autres malformations : la classe ne suffit pas à valider conseil génétique ou dépistage préconceptionnel pour chaque anomalie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f3dea096abae84b5999b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/100
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 206 → N17 · differentiel

Insuffisance rénale aiguë · Insuffisance rénale aiguë

Surcharge et œdème pulmonaire peuvent compliquer une IRA.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-208d5e74a35b883ff8f2 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/6
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	nice_aki · 1.1.1–1.1.4 ; 1.3.1 ; 1.4.2–1.4.6 ; 1.5.8 ; 1.5.15 https://www.nice.org.uk/guidance/ng148/chapter/Recommendations
Limites	Chercher surcharge avec altération aiguë fonction ; SSP206 concerne dyspnée aiguë sévère dans ce contexte., Recommandation britannique, dates des paragraphes majoritairement 2013, section contraste révisée 2024. Utilisée seulement pour diagnostic, étiologies et manifestations, sans conduite thérapeutique.

SSP 251 → Z49 · candidat

Surveillance d’une dialyse · Surveillance d’une dialyse

Surveillance dialyse = contexte de soins, pas diagnostic expliquant symptôme ni réadaptation SSP255 par défaut. Source spécifique du lien SSP–surveillance à lire ; réadaptation de transplantation ne valide pas Z49.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3ad4d62d8ed75b9eb5bf docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/101
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 255 → Z49 · candidat

Surveillance d’une dialyse · Surveillance d’une dialyse

Surveillance dialyse = contexte de soins, pas diagnostic expliquant symptôme ni réadaptation SSP255 par défaut. Source spécifique du lien SSP–surveillance à lire ; réadaptation de transplantation ne valide pas Z49.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2a7cb7197d9e1e234a3b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/102
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

SSP 261 → N18 · contexte

Maladie rénale chronique · Maladie rénale chronique

La maladie rénale avancée peut conduire à une discussion de transplantation et de don.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ecafdc7d49b77586f62c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/21
Propriétaire / statut	S04 · confirme
Source / section	hug_transplant · Bilan pré-greffe ; Consultation ; Réadaptation https://www.hug.ch/nephrologie-hypertension/transplantation-renale
Limites	Contexte de maladie avancée éligible ; ne confirme aucune étiologie., Contexte SSP261/255, pas un diagnostic étiologique de l’anomalie rénale ; Z49 dialyse ne devient pas code de transplantation.

SSP 263 → N14 · candidat

Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds · Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

Atteinte médicamenteuse/toxique importante dans différentiels IRA/néphrite interstitielle ; HUG général lu, mais preuve spécifique médicament→lésion tubulo-interstitielle et présentation à compléter.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4af9aaf4d742e5114727 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S04.json/relations/88
Propriétaire / statut	S04 · candidat_non_verifie
Limites	Aucune preuve source associée à cette relation dans le fichier original ; candidat non confirmé.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 22

Annexe : graphe probant — H-08 — Hématologie

66 arêtes issues de preuves-S06.json. Les arêtes de contexte/candidat restent explicitement séparées ; les renvois ne changent pas leur propriétaire.

SSP 2 → C77 · differentiel

Métastase ganglionnaire d'une tumeur solide · Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée

Les métastases ganglionnaires de tumeurs solides sont explicitement dans le diagnostic différentiel des adénopathies (§4.4).

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5e41115ce94acfb6101b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/0
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	FL · §3 Klinisches Bild ; §4.1.1 Erstdiagnose ; §4.4 Differenzialdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/follikulaeres-lymphom/@@guideline/html/index.html
Limites	Biopsie nécessaire ; adénopathie non synonyme de lymphome.

SSP 2 → C81 · differentiel

Lymphome de Hodgkin · Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]

Adénopathies souvent indolores au premier plan ; confirmation histologique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-155378b2a0aaaeddfee7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/1
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HL · §4 Klinisches Bild ; §5.2.1 Erstdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/hodgkin-lymphom/@@guideline/html/index.html
Limites	Biopsie ganglionnaire ; bilan biologique non spécifique.

SSP 2 → C82 · differentiel

Lymphome folliculaire · Lymphome folliculaire

Adénopathies indolores ; atteinte hématopoïétique avec anémie/fatigue décrite dans §3.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-bb6a643c63242626639d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/3
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	FL · §3 Klinisches Bild ; §4.1.1 Erstdiagnose ; §4.4 Differenzialdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/follikulaeres-lymphom/@@guideline/html/index.html
Limites	Biopsie nécessaire ; adénopathie non synonyme de lymphome.

SSP 2 → C83 · differentiel

Lymphome diffus à grandes cellules B · Lymphome non folliculaire

Adénopathies rapidement progressives ; prélèvement tissulaire nécessaire ; catégorie C83 via ce diagnostic précis.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-88e4b40c04a2243d01f8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/6
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	DLBCL · §3 Klinisches Bild ; §4.1 Gewebeprobe ; §4.5 Differentialdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/diffuses-grosszelliges-b-zell-lymphom/@@guideline/html/index.html
Limites	Histologie requise ; mention des T périphériques ne justifie pas toutes les catégories T/NK.

SSP 2 → C84 · differentiel

Lymphome périphérique T, C84.4 · Lymphomes à cellules T/NK matures

Les lymphomes périphériques T sont un différentiel explicite du DLBCL dans §4.5.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b2f56d420b032be19a5c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/7

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	DLBCL · §3 Klinisches Bild ; §4.1 Gewebeprobe ; §4.5 Differentialdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/diffuses-grosszelliges-b-zell-lymphom/@@guideline/html/index.html
Limites	Histologie requise ; mention des T périphériques ne justifie pas toutes les catégories T/NK.

SSP 2 → C91 · differentiel

Leucémie lymphoïde chronique, C91.1 · Leucémie lymphoïde

Lymphocytose souvent fortuite ±adénopathies ; frottis et immunophénotype établissent une population clonale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-eab511a87bca307abfc1 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/13
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	CLL · §4 Klinisches Bild ; §5.1 Kriterien ; §5.2 Diagnostik https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/chronische-lymphatische-leukaemie-cll/@@guideline/html/index.html
Limites	Lymphocytose clonale définie ; ne concerne pas toutes les leucémies C91.

SSP 4 → C82 · differentiel

Lymphome folliculaire · Lymphome folliculaire

Adénopathies indolores ; atteinte hématopoïétique avec anémie/fatigue décrite dans §3.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6ec27a0cbb7ff75dfc1d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/4
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	FL · §3 Klinisches Bild ; §4.1.1 Erstdiagnose ; §4.4 Differenzialdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/follikulaeres-lymphom/@@guideline/html/index.html
Limites	Biopsie nécessaire ; adénopathie non synonyme de lymphome.

SSP 4 → C90 · differentiel

Myélome multiple · Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

Fatigue/anémie et paraprotéine orientent ; électrophorèse, chaînes légères, moelle et lésions d’organes différencient les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a5233ee6f13f368b04de docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/10
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	MM · §4.1 Symptome ; §5.1 Kriterien ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/multiples-myelom/@@guideline/html/index.html
Limites	Anémie/paraprotéine insuffisantes seules ; confirmation médullaire et critères diagnostiques.

SSP 4 → C92 · differentiel

Leucémie aiguë myéloïde · Leucémie myéloïde

L’insuffisance médullaire peut produire anémie avec pâleur/fatigue, neutropénie et thrombopénie avec ecchymoses ; leucocytose ou nombre normal/bas possibles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fe70b25e0873b825d4c3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/15
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AML · §4.1 Symptome ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/akute-myeloische-leukaemie-aml/@@guideline/html/index.html
Limites	Cytopénies ou leucocytose orientent ; cytologie, immunophénotype et génétique nécessaires ; pas équivalence automatique AML→C93/C94/C95.

SSP 4 → D50 · differentiel

Anémie ferriprive · Anémie par carence en fer

Pâleur et fatigue sont manifestations générales d’anémie ; déficit martial première cause proposée dans démarche microcytaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-19544edfa32cbe98e3f4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/23
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 4 → D59 · differentiel

Anémie hémolytique auto-immune · Anémie hémolytique acquise

Fatigue, pâleur et ictère décrits ; confirmer hémolyse et mécanisme immunologique, DAT seul insuffisant.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-026d81de5d729561beff docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/32
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AIHA · §3 Klinisches Bild ; §4–4.2 diagnostic et paramètres hémolyse https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/autoimmunhaemolytische-anaemien-aiha/@@guideline/html/index.html
Limites	DAT positif seul ne suffit pas ; distinction auto/alloréactivité ; catégorieD59 sélectionnée via AIHA.

SSP 4 → D64 · diagnostic

Anémie non encore précisée, stade syndromique · Autres anémies

L’anémie est un résultat de laboratoire dont il faut rechercher la cause ; stade de présentation utile à la démarche.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-415a7f048d759d2ab196 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/42
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE

Trace	Détail
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Catégorie de syndrome/attente, pas diagnostic étiologique supplémentaire à compter chez une personne après découverte d'une carence ou hémolyse., Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 6 → D70 · contexte

Neutropénie fébrile chez le patient oncologique · Agranulocytose et neutropénie

La neutropénie fébrile est un tableau d'urgence décrit chez les adultes avec cancer ; contexte immunodéprimé à traiter explicitement.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a1b7ac325cf7ef2ed8c0 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/56
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	NEUTRO · §1 Zusammenfassung https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/fieber-unbekannter-genese-fuo-bei-neutropenischen-patienten/@@guideline/html/index.html
Limites	Adultes avec cancers, neutropénie fébrile ; support d'urgence/contexte, pas audit des causes congénitales.

SSP 6 → D76 · differentiel

Lymphohistiocytose hémophagocytaire, D76.1 · Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire

Triade fièvre prolongée, hépatosplénomégalie, bi-/pancytopénie motive l'évaluation HLH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-fb01a022c9931dbf728b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/62
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HLH · §4 Klinisches Bild ; §5.1 Diagnostische Kriterien https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/haemophagozytische-lymphohistiozytose-hlh/@@guideline/html/index.html

Trace	Détail
Limites	Enrichissement rare mais urgent ; critères pédiatriques ne sont pas mécaniquement transposables adulte ; hémophagocytose non suffisante ni nécessaire seule.

SSP 88 → C92 · differentiel

Leucémie aiguë myéloïde · Leucémie myéloïde

L’insuffisance médullaire peut produire anémie avec pâleur/fatigue, neutropénie et thrombopénie avec ecchymoses ; leucocytose ou nombre normal/bas possibles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-128df4c6f32e507b7e32 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/16
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AML · §4.1 Symptome ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/akute-myeloische-leukaemie-aml/@@guideline/html/index.html
Limites	Cytopénies ou leucocytose orientent ; cytologie, immunophénotype et génétique nécessaires ; pas équivalence automatique AML→C93/C94/C95.

SSP 88 → D65 · differentiel

Coagulation intravasculaire disséminée · Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]

CIVD explicitement parmi les causes à évoquer devant pétéchies/purpura dans tableau3.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-65bd31ea978927556e67 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/46
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 88 → D66 · differentiel

HémophilieA, déficitFVIII · Carence héréditaire en facteur VIII

Saignements musculaires/hématomes et aPTT fréquemment prolongé orientent ; activitéFVIII confirme, un bilan normal ne suffit pas à exclure une forme légère.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-137bfa84559c152ba859 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/47
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HEMO · §3 Klinisches Bild ; §4 Diagnostik https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/haemophilie/@@guideline/html/index.html
Limites	FVIII/FIX et histoire clinique ; pas de diagnostic à partir d’un seul aPTT.

SSP 88 → D67 · differentiel

HémophilieB, déficitFIX · Carence héréditaire en facteur IX

Même démarche clinique et hémostase ; activitéFIX distingue l’hémophilieB.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8ff0516b3a9d8311e9f7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/49
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HEMO · §3 Klinisches Bild ; §4 Diagnostik https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/haemophilie/@@guideline/html/index.html
Limites	FVIII/FIX et histoire clinique ; pas de diagnostic à partir d’un seul aPTT.

SSP 88 → D68 · differentiel

Maladie de von Willebrand et autres coagulopathies ciblées · Autres anomalies de la coagulation

VWF et facteurs sont explorés dans le bilan d’une tendance hémorragique ; déficits légers parfois sans anomalie des tests globaux.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-7203db666f6fe576e2f8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/51

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	BLEED · §7.3.1–2 tests ; §8.1 HämophilieA/B ; §8.2 Von Willebrand ; §9.2–3 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/abklaerung-einer-blutungsneigung/@@guideline/html/index.html
Limites	Bilan adapté au phénotype ; aPTT normale n’exclut pas déficit léger ; pas de posologie lue comme preuve.

SSP 88 → D69 · differentiel

Thrombopénie immune et purpura · Purpura et autres affections hémorragiques

ITP à différencier d’artéfact, médicaments, hépatopathie, MDS, TMA ; le lien compte la catégorie et non chaque sous-code.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8040e174ced1c0ed8ddb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/53
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	ITP · §5.5.1 Übersicht, tableau11 Differenzialdiagnose bei V.a.ITP https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/immunthrombozytopenie-itp/@@guideline/html/index.html
Limites	Section différentielle lue ; ne conclut pas ITP sur thrombopénie isolée et ne couvre pas tous les purpuras vasculaires., Table différentielle ciblée, pseudo-thrombopénie à exclure ; pas toute thrombopénie=ITP ; tableau hémangiomes/Kasabach-Merritt ne suffit pas pour D18.

SSP 91 → D59 · differentiel

Anémie hémolytique auto-immune · Anémie hémolytique acquise

Fatigue, pâleur et ictère décrits ; confirmer hémolyse et mécanisme immunologique, DAT seul insuffisant.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-240c4ec1ffe4268154cb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/33
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE

Trace	Détail
Source / section	AIHA · §3 Klinisches Bild ; §4–4.2 diagnostic et paramètres hémolyse https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/autoimmunhaemolytische-anaemien-aiha/@@guideline/html/index.html
Limites	DAT positif seul ne suffit pas ; distinction auto/alloréactivité ; catégorieD59 sélectionnée via AIHA.

SSP 140 → D74 · differentiel

Méthémoglobinémie acquise · Méthémoglobinémie

La cyanose est une manifestation explicitement décrite après exposition oxydante ; remplace le rattachement non argumenté154/171.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-7493ec34a05c50068101 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/60
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	METHB · p.3 Eine spezifische unerwünschte Wirkung…Methämoglobinämie ; Klinische Entwicklung und Physiopathologie https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/marktueberwachung/vigilance/vigilance-news_juni2011.pdf.download.pdf/vigilance-news_juni2011.pdf
Limites	Signal suisse ancien d’exposition aux oxydants ; utilisé pour lien cyanose→méthémoglobinémie, sans reprendre seuils/doses/traitements.

SSP 147 → C92 · differentiel

Leucémie aiguë myéloïde · Leucémie myéloïde

L’insuffisance médullaire peut produire anémie avec pâleur/fatigue, neutropénie et thrombopénie avec ecchymoses ; leucocytose ou nombre normal/bas possibles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-4eb483e0268fa75faa8f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/17
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AML · §4.1 Symptome ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/akute-myeloische-leukaemie-aml/@@guideline/html/index.html

Trace	Détail
Limites	Cytopénies ou leucocytose orientent ; cytologie, immunophénotype et génétique nécessaires ; pas équivalence automatique AML→C93/C94/C95.

SSP 147 → D50 · differentiel

Anémie ferriprive · Anémie par carence en fer

Pâleur et fatigue sont manifestations générales d’anémie ; déficit martial première cause proposée dans démarche microcytaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2bdd3d6d753ad1fb01ba docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/24
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 147 → D59 · differentiel

Anémie hémolytique auto-immune · Anémie hémolytique acquise

Fatigue, pâleur et ictère décrits ; confirmer hémolyse et mécanisme immunologique, DAT seul insuffisant.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-80f8246553547e033b5b docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/34
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AIHA · §3 Klinisches Bild ; §4–4.2 diagnostic et paramètres hémolyse https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/autoimmunhaemolytische-anaemien-aiha/@@guideline/html/index.html
Limites	DAT positif seul ne suffit pas ; distinction auto/alloréactivité ; catégorieD59 sélectionnée via AIHA.

SSP 147 → D64 · diagnostic

Anémie non encore précisée, stade syndromique · Autres anémies

L’anémie est un résultat de laboratoire dont il faut rechercher la cause ; stade de présentation utile à la démarche.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-f0c293b7ecac990c6ff9 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/43
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Catégorie de syndrome/attente, pas diagnostic étiologique supplémentaire à compter chez une personne après découverte d’une carence ou hémolyse., Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 152 → D66 · differentiel

HémophilieA, déficitFVIII · Carence héréditaire en facteur VIII

Saignements musculaires/hématomes et aPTT fréquemment prolongé orientent ; activitéFVIII confirme, un bilan normal ne suffit pas à exclure une forme légère.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1ac40ae483bfb95eedeb docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/48
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HEMO · §3 Klinisches Bild ; §4 Diagnostik https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/haemophilie/@@guideline/html/index.html
Limites	FVIII/FIX et histoire clinique ; pas de diagnostic à partir d’un seul aPTT.

SSP 152 → D67 · differentiel

HémophilieB, déficitFIX · Carence héréditaire en facteur IX

Même démarche clinique et hémostase ; activitéFIX distingue l’hémophilieB.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-216a4dcd9a2602f04cb7 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/50
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HEMO · §3 Klinisches Bild ; §4 Diagnostik https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/haemophilie/@@guideline/html/index.html
Limites	FVIII/FIX et histoire clinique ; pas de diagnostic à partir d’un seul aPTT.

SSP 152 → D68 · differentiel

Maladie de von Willebrand et autres coagulopathies ciblées · Autres anomalies de la coagulation

VWF et facteurs sont explorés dans le bilan d’une tendance hémorragique ; déficits légers parfois sans anomalie des tests globaux.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-207f4a959ffa3cb27483 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/52
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	BLEED · §7.3.1–2 tests ; §8.1 HämophilieA/B ; §8.2 Von Willebrand ; §9.2–3 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/abklaerung-einer-blutungsneigung/@@guideline/html/index.html
Limites	Bilan adapté au phénotype ; aPTT normale n’exclut pas déficit léger ; pas de posologie lue comme preuve.

SSP 154 → C91 · differentiel

Leucémie lymphoïde chronique, C91.1 · Leucémie lymphoïde

Lymphocytose souvent fortuite ±adénopathies ; frottis et immunophénotype établissent une population clonale.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-67a924d8500627784c80 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/14
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE

Trace	Détail
Source / section	CLL · §4 Klinisches Bild ; §5.1 Kriterien ; §5.2 Diagnostik https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/chronische-lymphatische-leukaemie-cll/@@guideline/html/index.html
Limites	Lymphocytose clonale définie ; ne concerne pas toutes les leucémies C91.

SSP 154 → C92 · differentiel

Leucémie aiguë myéloïde · Leucémie myéloïde

L’insuffisance médullaire peut produire anémie avec pâleur/fatigue, neutropénie et thrombopénie avec ecchymoses ; leucocytose ou nombre normal/bas possibles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e12f6a223f156b1ffdf3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/18
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AML · §4.1 Symptome ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/akute-myeloische-leukaemie-aml/@@guideline/html/index.html
Limites	Cytopénies ou leucocytose orientent ; cytologie, immunophénotype et génétique nécessaires ; pas équivalence automatique AML→C93/C94/C95.

SSP 154 → D61 · differentiel

Anémie aplastique/pancytopénie · Autres anémies aplastiques

Bi-/pancytopénie donne anémie, infections neutropéniques et saignements thrombopéniques ; confirmation médullaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-43fd9dde291d20ca9ca4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/36
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AA · §4 Klinisches Bild ; §5.1 Diagnosekriterien ; §5.2.1 Erstdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/aplastische-anaemie/@@guideline/html/index.html
Limites	Bi-/pancytopénie et moelle hypo/aplasique ; ne prouve pas érythroblastopénie pure D60.

SSP 154 → D70 · diagnostic

Neutropénie · Agranulocytose et neutropénie

Une neutropénie est une anomalie leucocytaire et manifestation possible de l’insuffisance médullaire ; numération différentielle la caractérise.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-eccfefebf291d7a35ebf docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/55
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AML · §4.1 Symptome ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/akute-myeloische-leukaemie-aml/@@guideline/html/index.html
Limites	D70 désigne une anomalie numérale, pas la causeAML ; aucune extrapolation à toutes les neutropénies congénitales., Cytopénies ou leucocytose orientent ; cytologie, immunophénotype et génétique nécessaires ; pas équivalence automatique AML→C93/C94/C95.

SSP 154 → D72 · differentiel

Éosinophilie réactionnelle à distinguer d’une forme clonale · Autres anomalies des leucocytes

La démarche distingue réactionnelle et clonale avec examen des organes ; le numérateur leucocytaire est une porte d’entrée clinique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9e3f2d544e1e93f4d8ef docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/58
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	EOS · §4.1 Klinischer Symptomenkomplex ; §4.2 Besonderheiten https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/eosinophilie-primaere-klonale-eosinophile-und-differentialdiagnosen/@@guideline/html/index.html
Limites	CatégorieD72 via éosinophilie non néoplasique ; une néoplasie définie reçoit le code adapté, pas automatiquementD72., Éosinophilie réactionnelle/clonale à distinguer ; D72 n’est pas code universel de toute néoplasie éosinophile.

SSP 154 → D76 · differentiel

Lymphohistiocytose hémophagocytaire, D76.1 · Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire

Triade fièvre prolongée, hépatosplénomégalie, bi-/pancytopénie motive l’évaluation HLH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-b6e7235edbb5140f3155 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/63
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HLH · §4 Klinisches Bild ; §5.1 Diagnostische Kriterien https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/haemophagozytische-lymphohistiozytose-hlh/@@guideline/html/index.html
Limites	Enrichissement rare mais urgent ; critères pédiatriques ne sont pas mécaniquement transposables adulte ; hémophagocytose non suffisante ni nécessaire seule.

SSP 159 → C81 · diagnostic

Lymphome de Hodgkin confirmé histologiquement · Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]

L’histologie ganglionnaire établit le diagnostic ; SSP159 est ici une étape de confirmation, jamais un mécanisme de sélection de tous les cancers.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-9f0aa2018961f08c502a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/2
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HL · §4 Klinisches Bild ; §5.2.1 Erstdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/hodgkin-lymphom/@@guideline/html/index.html
Limites	Biopsie ganglionnaire ; bilan biologique non spécifique.

SSP 159 → D47 · diagnostic

Thrombocytémie essentielle, D47.3 · Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue

Mutation JAK2/CALR/MPL et moelle caractérisent la néoplasie après sélection clinique ; pas d’héritage global vers tous les sous-codesD47.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-073e3be57436128c63be docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/22
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	ET · §5.2 Diagnostik ; §5.3 Diagnosekriterien https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/essentielle-oder-primaere-thrombozythaemie-et/@@guideline/html/index.html
Limites	Exclure thrombocytose secondaire puis mutation/histologie ; D47.3 vérifié dans référentiel OFS local.

SSP 165 → C82 · differentiel

Lymphome folliculaire · Lymphome folliculaire

Adénopathies indolores ; atteinte hématopoïétique avec anémie/fatigue décrite dans §3.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-badb6d7a8bfea3c9c53a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/5
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	FL · §3 Klinisches Bild ; §4.1.1 Erstdiagnose ; §4.4 Differenzialdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/follikulaeres-lymphom/@@guideline/html/index.html
Limites	Biopsie nécessaire ; adénopathie non synonyme de lymphome.

SSP 165 → C88 · differentiel

Macroglobulinémie de Waldenström · Maladies immunoprolifératives malignes

Infiltration médullaire avec anémie ; IgM sérique monoclonale, électrophorèse/immunofixation et biopsie médullaire pour confirmer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8c094a53d884519a7117 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/8
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	WM · §4.1 Symptome ; §5.1 Diagnose-Kriterien ; §5.2.1 Erstdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/morbus-waldenstroem-lymphoplasmozytisches-lymphom/@@guideline/html/index.html

Trace	Détail
Limites	IgM monoclonale avec confirmation médullaire ; ne généralise pas toutes les maladies C88.

SSP 165 → C90 · differentiel

Myélome multiple · Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

Fatigue/anémie et paraprotéine orientent ; électrophorèse, chaînes légères, moelle et lésions d’organes différencient les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-c49d75b8159d0ce0616e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/11
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	MM · §4.1 Symptome ; §5.1 Kriterien ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/multiples-myelom/@@guideline/html/index.html
Limites	Anémie/paraprotéine insuffisantes seules ; confirmation médullaire et critères diagnostiques.

SSP 165 → C92 · differentiel

Leucémie aiguë myéloïde · Leucémie myéloïde

L’insuffisance médullaire peut produire anémie avec pâleur/fatigue, neutropénie et thrombopénie avec ecchymoses ; leucocytose ou nombre normal/bas possibles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-de0ead85ac5dce8ba75d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/19
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AML · §4.1 Symptome ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/akute-myeloische-leukaemie-aml/@@guideline/html/index.html
Limites	Cytopénies ou leucocytose orientent ; cytologie, immunophénotype et génétique nécessaires ; pas équivalence automatique AML→C93/C94/C95.

SSP 165 → D50 · differentiel

Anémie ferriprive · Anémie par carence en fer

Pâleur et fatigue sont manifestations générales d’anémie ; déficit martial première cause proposée dans démarche microcytaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3e9ed5f6c10c0cbde44a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/25
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 165 → D51 · differentiel

Anémie par carence en vitamineB12 · Anémie par carence en vitamine B12

Démarche macrocytaire : rechercher déficitB12 ; corréler à l’anémie plutôt qu’à une carence isolée.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-d54000d56cedb195150c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/26
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 165 → D52 · differentiel

Anémie par carence en folates · Anémie par carence en acide folique

Démarche macrocytaire : déficit folique parmi les étiologies à rechercher.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ceeea2d2cae4070c0894 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/27

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 165 → D55 · differentiel

Anémie par déficitG6PD, D55.0 · Anémie due à des anomalies enzymatiques

Anamnèse d’une hémolyse : antécédents familiaux/G6PD explicitement cités tableau4.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-668be8f196b33c7f0959 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/28
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Support suisse ancien d’orientation ; ne prouve pas chaque enzymopathie rareD55, ni diagnostic sur origine ethnique seule., Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 165 → D56 · differentiel

Bêta-thalassémie · Thalassémie

Certaines formes présentent une anémie chronique ; forme minor souvent peu symptomatique ; discussion dans démarche de l’anémie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e9687aaafb574865b214 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/29
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	THAL · §4.1–4.2 Klinisches Bild https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/beta-thalassaemie/@@guideline/html/index.html

Trace	Détail
Limites	Formes minor souvent asymptomatiques ; lien anémie n’impose pas toutes les sous-entitésD56.

SSP 165 → D57 · differentiel

Drépanocytose · Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

Anémie hémolytique inexpliquée et contexte pertinent sont indication d’analyse de l’hémoglobine.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e85eb4f03aa52b5d8211 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/30
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	SICKLE · §3 Klinisches Bild, tableau1 indication Hb-Analyse https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/sichelzellkrankheiten/@@guideline/html/index.html
Limites	Risque/anamnèse et anémie hémolytique inexpliquée ; screening néonatal allemand cité dans source non transposé à la Suisse.

SSP 165 → D58 · differentiel

Sphérocytose héréditaire, D58.0 · Autres anémies hémolytiques héréditaires

Anémie Coombs négative, ictère et splénomégalie composent le phénotype ; catégorie retenue via entité explicite.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-cec792ee553dd0e363c8 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/31
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	SPHERO · §4.1 Symptome, tableaux2–3 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/sphaerozytose-hereditaer-kugelzellenanaemie/@@guideline/html/index.html
Limites	Anémie Coombs négative, ictère, splénomégalie/histoire familiale ; D58 retenu via sphérocytose, pas toutes les membranes rares.

SSP 165 → D59 · differentiel

Anémie hémolytique auto-immune · Anémie hémolytique acquise

Fatigue, pâleur et ictère décrits ; confirmer hémolyse et mécanisme immunologique, DAT seul insuffisant.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-96006a65e80f9d7aed4f docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/35
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AIHA · §3 Klinisches Bild ; §4–4.2 diagnostic et paramètres hémolyse https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/autoimmunhaemolytische-anaemien-aiha/@@guideline/html/index.html
Limites	DAT positif seul ne suffit pas ; distinction auto/alloréactivité ; catégorieD59 sélectionnée via AIHA.

SSP 165 → D61 · differentiel

Anémie aplastique/pancytopénie · Autres anémies aplastiques

Bi-/pancytopénie donne anémie, infections neutropéniques et saignements thrombopéniques ; confirmation médullaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6ddebb550357bd75b17c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/37
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AA · §4 Klinisches Bild ; §5.1 Diagnosekriterien ; §5.2.1 Erstdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/aplastische-anaemie/@@guideline/html/index.html
Limites	Bi-/pancytopénie et moelle hypo/aplasique ; ne prouve pas érythroblastopénie pure D60.

SSP 165 → D62 · differentiel

Anémie posthémorragique aiguë · Anémie posthémorragique aiguë

Démarche anémie régénérative : chercher saignement ; l’hypovolémie hémorragique donne orthostatisme/hypotension. Le lien215 suppose anémie consécutive au saignement, pas toute hémorragie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a856260d169e2506db0e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/39
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Source syndrome/anémie, pas guide d’hémorragie massive ; seuils anciens et prise en charge non repris., Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 165 → D63 · differentiel

Anémie inflammatoire au cours d’une maladie chronique · Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs

Anémie inflammatoire explicitement dans le différentiel de l’anémie microcytaire ; maladie causale à caractériser.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-8fcc54a607d9f551a4a3 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/41
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	D63 est une manifestation d’une maladie classée ailleurs ; ne remplace pas le diagnostic causal et n’est pas une deuxième étiologie si déjà codée., Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 165 → D64 · diagnostic

Anémie non encore précisée, stade syndromique · Autres anémies

L’anémie est un résultat de laboratoire dont il faut rechercher la cause ; stade de présentation utile à la démarche.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-573d071cc97b733f85d4 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/44

Trace	Détail
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Catégorie de syndrome/attente, pas diagnostic étiologique supplémentaire à compter chez une personne après découverte d’une carence ou hémolyse., Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 165 → D76 · differentiel

Lymphohistiocytose hémophagocytaire, D76.1 · Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire

Triade fièvre prolongée, hépatosplénomégalie, bi-/pancytopénie motive l’évaluation HLH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-006edbf5ee59d664ecae docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/64
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HLH · §4 Klinisches Bild ; §5.1 Diagnostische Kriterien https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/haemophagozytische-lymphohistiozytose-hlh/@@guideline/html/index.html
Limites	Enrichissement rare mais urgent ; critères pédiatriques ne sont pas mécaniquement transposables adulte ; hémophagocytose non suffisante ni nécessaire seule.

SSP 171 → D75 · differentiel

Polycythémie secondaire, D75.1 · Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

Devant érythrocytose, différencier PV, forme relative et érythrocytose secondaire hypoxique/médicamenteuse/paranéoplasique.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-19fec8d001dc5582853d docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/61
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE

Trace	Détail
Source / section	PV · §5.2.1 Erstdiagnose ; §5.2.1.1–2 ; §5.5 Differenzialdiagnose, tableau6 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/polycythaemia-vera-pv/@@guideline/html/index.html
Limites	Séparer érythrocytose relative, secondaire et PV ; D45 propriétaire T4.

SSP 172 → C88 · differentiel

Macroglobulinémie de Waldenström · Maladies immunoprolifératives malignes

Infiltration médullaire avec anémie ; IgM sérique monoclonale, électrophorèse/immunofixation et biopsie médullaire pour confirmer.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-11f788676fe1e8d3f156 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/9
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	WM · §4.1 Symptome ; §5.1 Diagnose-Kriterien ; §5.2.1 Erstdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/morbus-waldenstroem-lymphoplasmozytisches-lymphom/@@guideline/html/index.html
Limites	IgM monoclonale avec confirmation médullaire ; ne généralise pas toutes les maladies C88.

SSP 172 → C90 · differentiel

Myélome multiple · Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

Fatigue/anémie et paraprotéine orientent ; électrophorèse, chaînes légères, moelle et lésions d’organes différencient les causes.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-6f80627947f6076f1a73 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/12
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	MM · §4.1 Symptome ; §5.1 Kriterien ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/multiples-myelom/@@guideline/html/index.html
Limites	Anémie/paraprotéine insuffisantes seules ; confirmation médullaire et critères diagnostiques.

SSP 174 → C92 · differentiel

Leucémie aiguë myéloïde · Leucémie myéloïde

L’insuffisance médullaire peut produire anémie avec pâleur/fatigue, neutropénie et thrombopénie avec ecchymoses ; leucocytose ou nombre normal/bas possibles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-2942372318b59c314446 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/20
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AML · §4.1 Symptome ; §5.2.1 Erstdiagnose, tableau1 https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/akute-myeloische-leukaemie-aml/@@guideline/html/index.html
Limites	Cytopénies ou leucocytose orientent ; cytologie, immunophénotype et génétique nécessaires ; pas équivalence automatique AML→C93/C94/C95.

SSP 174 → D47 · differentiel

Thrombocytémie essentielle, D47.3 · Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue

Devant une thrombocytose persistante, exclure cause réactionnelle et CML ; mutation puis histologie distinguent ET et myélofibrose.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5e550e0b02aa4f53d5d6 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/21
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	ET · §5.2 Diagnostik ; §5.3 Diagnosekriterien https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/essentielle-oder-primaere-thrombozythaemie-et/@@guideline/html/index.html
Limites	Exclure thrombocytose secondaire puis mutation/histologie ; D47.3 vérifié dans référentiel OFS local.

SSP 174 → D61 · differentiel

Anémie aplastique/pancytopénie · Autres anémies aplastiques

Bi-/pancytopénie donne anémie, infections neutropéniques et saignements thrombopéniques ; confirmation médullaire.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-e659e7b924c8b14a9a8a docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/38
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	AA · §4 Klinisches Bild ; §5.1 Diagnosekriterien ; §5.2.1 Erstdiagnose https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/aplastische-anaemie/@@guideline/html/index.html
Limites	Bi-/pancytopénie et moelle hypo/aplasique ; ne prouve pas érythroblastopénie pure D60.

SSP 174 → D65 · differentiel

Coagulation intravasculaire disséminée · Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]

La DIC est une cause explicite de thrombopénie de consommation avec thromboses possibles.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-96f852e744dcdaa82c26 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/45
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	THROMBO · §4.1 manifestations ; §4.2 Inzidentelle Befunde ; §5.1 Diagnose-Kriterien https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/thrombozytopenien/@@guideline/html/index.html
Limites	DIC/TMA/HIT distinguées ; pseudo-thrombopénie à exclure ; pas de codage causal à partir de numération seule.

SSP 174 → D69 · differentiel

Thrombopénie immune et purpura · Purpura et autres affections hémorragiques

ITP à différencier d’artéfact, médicaments, hépatopathie, MDS, TMA ; le lien compte la catégorie et non chaque sous-code.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-5bfec8f1ef98c76f7367 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/54
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE

Trace	Détail
Source / section	ITP · §5.5.1 Übersicht, tableau11 Differenzialdiagnose bei V.a.ITP https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/immunthrombozytopenie-itp/@@guideline/html/index.html
Limites	Section différentielle lue ; ne conclut pas ITP sur thrombopénie isolée et ne couvre pas tous les purpuras vasculaires., Table différentielle ciblée, pseudo-thrombopénie à exclure ; pas toute thrombopénie=ITP ; tableau hémangiomes/Kasabach-Merritt ne suffit pas pour D18.

SSP 174 → D73 · differentiel

Hypersplénisme · Maladies de la rate

Splénomégalie avec hypersplénisme est un différentiel explicite de thrombopénie dans tableau11.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-1ce05ae11dd600fca04e docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/59
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	ITP · §5.5.1 Übersicht, tableau11 Differenzialdiagnose bei V.a.ITP https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/immunthrombozytopenie-itp/@@guideline/html/index.html
Limites	La cause hépatique/infectieuse/hématologique doit être précisée ; splénomégalie seule n’établit pas hypersplénisme., Table différentielle ciblée, pseudo-thrombopénie à exclure ; pas toute thrombopénie=ITP ; tableau hémangiomes/Kasabach-Merritt ne suffit pas pour D18.

SSP 174 → D76 · differentiel

Lymphohistiocytose hémophagocytaire, D76.1 · Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire

Triade fièvre prolongée, hépatosplénomégalie, bi-/pancytopénie motive l’évaluation HLH.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-3af6aedb02de7f2637bf docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/65
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HLH · §4 Klinisches Bild ; §5.1 Diagnostische Kriterien https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/haemophagozytische-lymphohistiozytose-hlh/@@guideline/html/index.html

Trace	Détail
Limites	Enrichissement rare mais urgent ; critères pédiatriques ne sont pas mécaniquement transposables adulte ; hémophagocytose non suffisante ni nécessaire seule.

SSP 215 → D62 · differentiel

Anémie posthémorragique aiguë · Anémie posthémorragique aiguë

Démarche anémie régénérative : chercher saignement ; l’hypovolémie hémorragique donne orthostatisme/hypotension. Le lien215 suppose anémie consécutive au saignement, pas toute hémorragie.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-ce1ceb668139de3efe1c docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/40
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	HUG · §3 Manifestations cliniques ; §4 Diagnostic, tableaux3–5, figures1–3 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/anemie_arce.pdf
Limites	Source syndrome/anémie, pas guide d’hémorragie massive ; seuils anciens et prise en charge non repris., Document suisse de premier recours ancien ; utilisé seulement pour orientation diagnostique, aucun seuil/traitement repris.

SSP 247 → D70 · contexte

Neutropénie fébrile chez le patient oncologique · Agranulocytose et neutropénie

La neutropénie fébrile est un tableau d’urgence décrit chez les adultes avec cancer ; contexte immunodéprimé à traiter explicitement.

Trace	Détail
ID / provenance	SSPV2-a15d4a2dd263ed4ba245 docs/collaboration/ssp-v2/2026-10-15/preuves-S06.json/links/57
Propriétaire / statut	S06 · LIEN_DOCUMENTE_PROPOSITION_PEDAGOGIQUE_NON_OFFICIELLE
Source / section	NEUTRO · §1 Zusammenfassung https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/fieber-unbekannter-genese-fuo-bei-neutropenischen-patienten/@@guideline/html/index.html
Limites	Adultes avec cancers, neutropénie fébrile ; support d’urgence/contexte, pas audit des causes congénitales.

MEDINA / PROTOCOLE V2 / 23

Décider d’une livraison sans faux “pass”

Question	Critère de décision
Le travail est-il autorisé ?	Mission active trusted-base, bonne branche, bonne génération et réservation actuelle ; planninggénération0 ne suffit pas.
Est-il isolé ?	Cours, chemins et sorties propres ; aucun chevauchement avec réservation active ; anciens systèmes et lignes catalogue hors mission conservés.
Le contenu est-il probant ?	Passages réellement lus et applicables ; lien typé ; statut partiel honnête ; correction recontrôlée dans ses surfaces ; lacunes visibles.
Le contrôle est-il réel ?	Exact head/base/registre, source de contrôleur trusted, résultat d’échec conservé, preuve non périmée. Ni skipped ni exception transformée en succès.
Le serveur impose-t-il la règle ?	Configuration relue et démonstrations de refus disponibles ; avec403, conserver “à imposer/vérifier”.
La reprise est-elle possible ?	Diff, SHA, worktree et reçus conservés ; libération explicite ; génération supérieure approuvée ; relais de gouvernance préapprouvé.
La clôture est-elle proportionnée ?	Vérification finale selon risque et nouvelle version ; aucune promesse de zéro erreur/collision ni audit final négligeable.

Le dossier complet demeure planifié pour le travail médical. Le registre et les contrôles locaux apportent des preuves techniques concrètes ; les droits/contrôles serveur et le reçu de publication de versions corrigées gardent leurs limites explicites.